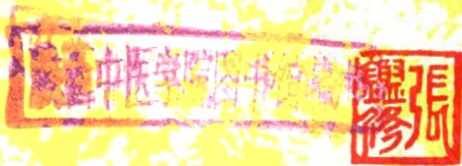


中医治疗精神病

湖北人民出版社



R277
1

R277.79
1

封面设计：刘宜海

189075

12

R277

统一书号：14106·13

定 价：0.79 元

中 医 治 疗 精 神 病

张 鎰 修 编 著

湖 北 人 民 出 版 社

前 言

我国是世界文明发达最早的国家之一。勤劳勇敢的我国各族人民,在长期的劳动和斗争中,创造了灿烂的古代科学文化。传统的祖国医药学,就是这优秀古代文化的一个组成部分。祖国医药学有着悠久的历史,是我国人民长期与疾病作斗争的智慧结晶,也是我国历代防治疾病的丰富实践经验与理论知识的总结。祖国医学对于精神病也早有认识,历代医籍中均有不少精辟的论述,但都散见于内科杂病诸门内。毛泽东同志指出:“中国医药学是一个伟大的宝库,应当努力发掘,加以提高。”解放以来,在马列主义、毛泽东思想的指导下,在党和政府的关怀下,中医精神病学有了很大发展。目前,中西医结合治疗精神病的研究正在广泛展开,取得了很大的成绩。为了总结经验,加强医学科学的交流,给医学科学的现代化添砖加瓦,编者根据多年来运用祖国医学治疗精神病的医疗实践,参考我国有关文献资料,编写了《中医治疗精神病》一书。书中扼要地介绍了中医关于精神病的基本理论和精神科常见疾病的诊治方法,以供精神科医师和中医工作者临床参考。

一九五九年四月中央内务部和卫生部,根据我院治疗精神病的临床实践,召开了“全国精神病收治工作经验交流现场会”,对我们中医治疗精神病的疗效作了充分的肯定。一九六五年六月湖北省卫生厅组织专人协助进行初步整理,并以

《中医治疗精神病》作内部印行。文后附有湖北省卫生厅中医著作编审小组关于“沙市市精神病疗养院的调查报告”。此次出版，在原有材料基础上，又增添了十多年来的临床经验。

本书的编写，始终是在省地市各级领导的关怀下进行的。省民政局、荆州地委、沙市市委和科委都给予了极大的支持。我院田维才、余朝武两院长亲自参与了编审工作。在初稿写出后，金志高、芦绪燕、赵少君等同志，分别担任了部分章节的修订任务，使本书的修订工作得以胜利完成。

由于编者年近八旬，虽然行医六十余年，解放后运用中医的理论、方药治疗精神病已达二十余年之久，疗效较高，得到有关领导和病人、病人家属的赞助，但由于精力有限，经验不足，离党和人民的要求还很远，书中的缺点和错误一定不少，敬请精神科的医务工作者和广大读者提出宝贵意见，以便再版时修正。

张 鑑 修

一九八〇年四月于沙市市精神病医院

目 录

第一章 中医关于精神病的论述	1
一、中医精神病学的发展概况	1
二、正常精神活动的基本概念	7
三、精神病的病因学说	8
四、中医关于精神病的发病机理	11
(一) 阴阳失调与精神病的关系	11
(二) 脏腑失调与精神病的关系	13
(三) 经络失调与精神病的关系	13
(四) 气、血、痰、火与精神病的关系	14
第二章 中医关于精神病的诊断方法	17
一、四诊	17
(一) 望诊	17
(二) 闻诊	19
(三) 问诊	21
(四) 切诊	21
二、八纲	23
三、中医关于精神病的鉴别诊断	26
第三章 中医关于精神病的治 疗 原 则	30
一、整体观念	30
二、精神治疗和药物治疗相结合	30
三、标本兼顾	31
四、辨证施治	32
五、预后	32
第四章 中医常用治法在精神科的应用	34

一、清心降火法	34
二、舒肝解郁法	34
三、祛痰开窍法	35
四、养血安神法	35
第五章 中医关于精神病的分类和治疗	36
一、分证的方法	36
(一) 内经分证法	36
(二) 后代分证法	37
二、癫证	39
(一) 概述	39
(二) 病因和发病机理	39
(三) 辨证施治	40
(四) 典型病例	42
三、狂证	45
(一) 概述	45
(二) 病因和发病机理	46
(三) 辨证施治	47
(四) 典型病例	49
四、癫狂合并证	52
(一) 临床表现	52
(二) 病因和发病机理	53
(三) 辨证施治	53
(四) 典型病例	54
五、痫证	58
(一) 概述	58
(二) 病因和发病机理	58
(三) 辨证施治	59
(四) 典型病例	60

六、癲狂合并证	61
(一) 概述	61
(二) 病因和发病机理	61
(三) 辨证施治	62
(四) 典型病例	62
七、癲呆证	63
(一) 概述	63
(二) 病因和发病机理	64
(三) 辨证施治	64
(四) 典型病例	64
八、头痛、眩晕、不寐等症	65
(一) 头痛	65
1. 概述	65
2. 病因和发病机理	66
3. 辨证施治	66
4. 典型病例	67
(二) 眩晕	68
1. 概述	68
2. 病因和发病机理	68
3. 辨证施治	68
4. 典型病例	69
(三) 不寐	70
1. 概述	70
2. 病因和发病机理	70
3. 辨证施治	70
4. 典型病例	70
(四) 惊悸、怔忡	71
1. 概述	71
2. 病因和发病机理	71

3. 辨证施治	71
4. 典型病例	72
(五) 脏躁	72
1. 概述	72
2. 病因和发病机理	72
3. 辨证施治	73
4. 典型病例	73
第六章 精神科常用方剂及应用体会	74
一、精神科常用方剂	74
(一) 癫证主方	74
(二) 狂证主方	80
(三) 痫证主方	83
(四) 次方与辅助方	83
二、几种主要药方的应用体会	108
第七章 电针疗法在精神科的应用	116
一、常用穴位	116
二、督脉电针疗法	126
三、体针电(艾)灸疗法	129
第八章 关于精神病的中西医结合治疗	131
一、狂证	131
二、癫证	132
三、癫呆证	133
四、癫狂证	134
五、痫证	135
六、痫狂合并证	136
七、典型病例	136
第九章 精神病的家庭简便治疗法	141
附 录 方剂索引	145

第一章 中医关于精神病的论述

一、中医精神病学的发展概况

我国医药学有着悠久的历史，它是我国劳动人民长期与疾病作斗争过程中的经验积累，在我们伟大的中华民族的生存、延续、繁衍和发展，以及世界人类的保健事业上作出了巨大的贡献，是一个伟大的宝库。在祖国医学科学中，虽然没有专门的精神病学，但早在殷代甲骨文中，已有心疾、首疾等疾病的记载，说明当时对精神病已有初步认识。在春秋战国时期（公元前四七五至前二二一年），我国现存最早的医学经典著作《黄帝内经》中即有关于癫、狂、痫的专篇论述（所谓癫、狂、痫即指精神病而言），这就为后世精神病学的发展奠定了初步的理论基础。《黄帝内经素问·阳明脉解篇》写道：“其妄言骂詈，不避亲疏而歌者”，阳明病甚则“弃衣而走，登高而歌，或至不食数日，逾垣上屋，所上之处，皆非其素所能也。”（唐·王冰注：《黄帝内经素问》，人民卫生出版社，一九六三年六月第1版，下同。）也就是说，胃络上通于心，阳盛则心神昏乱，故使人妄言骂詈，不避亲疏。热盛于胃，则不欲食，不欲食，故妄走。《黄帝内经素问·厥论篇》又说：“阳明之厥，则癫疾欲走呼，腹满不得卧，面赤而热，妄见而妄言。”这对癫、狂、痫的病证作了初步的描述。但限于当时的历史条件，《黄帝内经》对癫、狂、痫的分证还无明显的界限，

具体内容的叙述也各有详略，一般对癲、狂证的叙述比较详细，而对痫证的叙述比较简略。《黄帝内经素问·宣明五气篇》说：“邪入于阳则狂，邪入于阴则痹，搏阳则为癲疾。”《黄帝内经素问·阴阳类论篇》中说：“二阴二阳皆交至，病在肾，骂詈妄行，癲疾为狂。”《黄帝内经灵枢·癲狂篇》中说：“癲疾者，疾发如狂者”，“狂始发，少卧不饥，自高贤也，自辩智也，自尊贵也，善骂詈，日夜不休……。狂言、惊、善笑、好歌乐、妄行不休者……。狂，目妄见、耳妄闻、善呼者”（此为幻觉状态）。《灵枢经》，人民卫生出版社，一九六三年四月第1版，下同。）但当时对“癲”与“痫”的认识却混淆不清，如《黄帝内经灵枢·癲狂篇》说：“癲疾始作，先反僵”，“筋癲疾者，身倦挛急大”，“癲疾者，疾发如狂者”，这里说的是癲疾，而实际上包含有癲痫及癲痫性精神障碍两种意思。

《黄帝内经》中对癲、狂、痫的病因和发病机理也有比较详细的记载。《黄帝内经素问·脉要精微论篇》指出：“衣被不敛，言语善恶，不避亲疏者，此神明之乱也。”这就是说，精神错乱的本质是“神明之乱”，神乱则谵语也。《黄帝内经素问·脉解篇》说：太阳“所谓甚则狂癲疾者，阳尽在上而阴气从下，下虚上实，故狂癲疾也。”阳明“所谓病至则欲乘高而歌，弃衣而走者，阴阳复争，而外并于阳，故使之弃衣而走也。”这说明癲狂是由阴阳平衡失调所引起。《黄帝内经素问·调经论篇》有“血并于阴，气并于阳，故为惊狂”之说。血并于阴，则阳盛而血实，心主血脉，故阴盛则惊。气并于阳，则阳盛而气实，阳盛则发狂，指的是气血不调也可以引起精神障碍。《黄帝内经素问·至真要大论篇》指出：“诸躁狂越，皆属于火”，“火热受邪，心病生焉”。这里不仅说明，“火”可

以产生精神紊乱，并明确地肯定了“火”为狂症的发病机理。

《黄帝内经素问》中不仅有关于癫、狂、痫的一些症状的生动描述，而且还详细地记载了对“阳厥”怒狂的夺食（即禁食）和服生铁落饮的治疗方法。如《黄帝内经素问·病能论篇》中载：“夺其食即已，夫食入于阴，长气于阳，故夺其食即已。使之服以生铁落为饮，夫生铁落者，下气疾也。”同时，《黄帝内经灵枢·癫狂篇》中记载了对于不同症状针刺不同穴位的治疗方法，如：“狂始生，先自悲也。喜忘苦怒善恐者，得之忧饥，治之取手太阴、阳明，血变而止，及取足太阴、阳明”。

根据以上论述，可见《黄帝内经》对癫、狂、痫的证治已形成了初步概念，为中医治疗精神病奠定了理论和临床实践的基础。后世医家在这一基础上，不断地通过临床实践和理论研究，逐步加以充实和发展，使癫、狂、痫的辨证施治渐趋完善。

春秋时期（公元前五世纪），秦越人（扁鹊）所著《难经》是我国古代著名经典医学著作之一。它在《黄帝内经》的基础上，在《难经·第二十难·论阴阳伏匿的脉象》中指出：“重阳者狂，重阴者癫。”（《难经校释》，人民卫生出版社，一九七九年十一月第1版）明确地提出以阴阳作为癫狂分类的理论根据，这一认识直到现在仍为许多中医学者所采用。

《金匱要略》是汉代名医张仲景（公元一五〇至二一〇年）所著。它对癫、狂、痫的叙述并没有超过《黄帝内经》的范围，它是我国临床医学和方剂学的发展比较成熟的著作，它首先提出了“妇人脏躁”、“奔豚病”、“百合病”等病名（《金匱要略释义》，上海人民卫生出版社，一九六三年九月第1版），其临

床症状的描述，颇似现代医学中的癔症、神经官能症等。

晋代(公元三世纪初)王叔和著的《脉经》，记载了根据脉象诊断癫狂病的经验。

隋开皇元年至唐永淳元年(公元五八一至六八二年)，孙思邈著的《备急千金要方》，不仅生动地叙述了癫狂的症状，而且在病因和发病机理方面认为与风邪有关，书中写道：“风入阳经则狂，入阴经则癫”，“邪入于阳则为狂，邪入于阴则为血痹，邪入于阳，传即为癫狂”。对于痫证也有详细的记载，如把痫证分为阳痫、阴痫、风痫、湿痫、马痫等。从症状的描述来看，多属癫痫抽搐发作。《备急千金要方》还记载了大量药物治疗的单方和针灸治疗的方法，为治疗精神病提供了丰富的经验(转引自清代陈梦雷等编：《古今图书集成医部全录》卷二百九十五，人民卫生出版社，一九六一年十一月第1版)。

宋大观元年(公元一一〇七年)朱肱著《类证活人书》中，将伤寒发狂区别为“阳毒发狂”与“畜血如狂”二类，对其外证和脉象作了论述。并提出了对“火邪发惊狂者，医以火于卧床下，或周身用火，迫劫汗出”的治疗方法。

金刘完素(约一一二〇至一二〇〇年)著的《河间六书》，发挥了《黄帝内经素问》“诸躁狂越，皆属于火”的观点，说“狂者，狂乱而无正定。越者乖越礼法而失常也。夫外清而内浊，动乱参差，火之体，静顺清朗，准则信平，水之体，由是肾水主志而水火相反，故心火旺则肾水衰，乃失志而狂越”。(转引自清代陈梦雷等编：《古今图书集成医部全录》卷二百九十五，人民卫生出版社，一九六一年十一月第1版)并对“狂”证的治疗，使其“吐涌之以瓜蒂散，出痰涎宿物”的方法，为癫狂“痰迷心窍”的理论提供了实践的依据，对后世的影响颇大。

元代朱震亨(公元一二八一至一三五八年)著的《丹溪心法·痼三十八》，对痼证的辨证进行了详细的研究，指出：“痼因惊而得惊，则神不守舍，舍空而痰聚也。”风痼可“卒然昏倒，或作牛吼、马嘶、鸡鸣、羊叫、猪呼、犬吠，腑脏相引气争掣，继吐沫流涎，久而方醒。”同时，《丹溪心法》仍把癲、狂分为二类，称“癲属阴，狂属阳，癲多喜而狂多怒，……癲者神不守舍，狂言如有见，经年不愈，心经有损，是为真病。如心经蓄热，当清心除热，如痰迷心窍，当下痰宁志，若癲哭呻吟为邪所凭，非狂也，……阳虚阴实则癲，阴虚阳实则狂，狂病宜大吐下则除之。”这就大大突破了《黄帝内经》及前世医家对精神病分证的观点。《丹溪心法》的另一个贡献，是明确地提出了以情胜情的“活套”疗法，文曰，“五志之火，因七情而起，郁而成痰，故为癲病狂妄之证，宜以人事制之，非药石所能疗也，须诊察其由以平之。”(《丹溪心法·活套》，转引自《古今图书集成医部全录》卷二百九十五，人民出版社，一九六二年十一月第1版)在七情五志的基础上，比较完整地发挥了中医关于精神病的治疗方法。

到了明朝，则对癲、狂、痼的辨证更为明确、细致。明代王肯堂(嘉靖二十八年至万历四十一年，即公元一五四九至一六一三年)著的《证治准绳》一书中，对我国明代以前中医各科作了一次系统的总结，且列出神志门，形成了比较完整的精神病学专章，将精神病分为癲狂痼、烦躁、惊悸恐三大类。在癲、狂、痼下，又将癲、狂、痼三者明确区分，改变了以往对癲、痼这两个概念长期混淆不清的状况。在烦躁项下列有烦躁、谵妄、循衣摸床、喜笑不休、怒、善太息、悲诸类。在惊悸恐下列有惊、悸(怔忡)、恐、健忘诸类。其中还对痼

病与中风、中寒、中暑和痉病的鉴别作了描述。著述分类明确，论证精辟，简洁扼要，为后世医学家论证癫狂者所宗师（见《证治准绳》，上海科技出版社，一九五九年十月第1版影印本）。

明天启四年（公元一六二四年），张介宾（公元一五六三至一六四〇年）著的《景岳全书》认为，“癫，即痫也。”即将精神病分为癫、狂、痴呆三类。其中，对于痴呆的症状、治疗及预后均有精辟的见解，如“痴呆证，凡平素无痰而或以郁结，或以不遂，或以思虑，或以疑惑，或以惊恐而渐至痴呆，言辞颠倒，举动不经，或多汗，或善愁，其证则千奇万怪，无所不至。……此证有可愈者，有不可愈者，亦在乎胃气元气之强弱，待时而复，非可急也。”这种对精神病痴呆症状的详细描述，颇似十九世纪德国精神病学家克雷丕林（Kraepelin，一八五六至一九二七年）所描述的“早发性痴呆”，但在时间上却早了二百多年，可见祖国医学的历史悠久和对人类的卓越贡献（张会卿先生著，《景岳全书》，上海科技出版社，一九五九年九月第1版）。

清代陈士铎（？年）著的《石室秘录》，将精神病区分为癫证、狂证和呆病证三类，其中还将癫病分有花癫之证，文曰：“乃女子思想其人而心邪，然亦因脾胃之寒而邪人也。”（清岐伯辑：《石室秘录》卷之六，宏道堂藏版）尚有许多病案记载，在治疗上除以方药治疗为主外，还强调了药物治疗与精神治疗相结合的方针，内容相当丰富。

以上所述，是中医关于精神病学的一般发展概况，足以说明祖国医学历史悠久，内容丰富，是一个伟大的宝库。我们必须从我国的具体情况出发，将前人的经验加以认真地总结，为创造具有中国特点的新型精神病学而努力奋斗。

二、正常精神活动的基本概念

了解人的精神活动的基本概念，对于精神病的诊断和治疗具有重要的意义。在这方面，我国古代医学家和经典医学著作中有不少精辟的论述。

《黄帝内经灵枢》写道：“生之来谓之精，两精相搏谓之神”（《黄帝内经灵枢·本神篇》），“神者，水谷之精气也”（《黄帝内经灵枢·平人绝谷篇》）。可见精神来源于先天，而精神活动则靠后天水谷的精气。

祖国医学从人的整体观念出发，把人的精神活动视为五脏功能的一种反映，其中与心、肾、脑髓以及肝等脏腑的关系尤为密切。如《黄帝内经》中写道：“心者，君主之官也，神明出焉”（《黄帝内经素问·灵兰秘典论篇》），“心者，五脏六腑之大主也，精神之所舍也”（《黄帝内经灵枢·邪客篇》）。可见心的功能，不仅表现在精神活动方面，而且有统管五脏六腑的重大作用。

关于脑，《黄帝内经》称“头者精明之府”（《黄帝内经素问·脉要精微论篇》），“脑为髓之海，其输上在于其盖，下在风府”（《黄帝内经灵枢·海论篇》）。“诸髓者皆属于脑。”（《黄帝内经素问·五藏生成篇》）清代王清任在《医林改错》中说：“灵机记性不在心在脑”（《医林改错·脑髓说》，人民卫生出版社，一九七六年六月第1版）。这说明脑髓不仅是精神活动的所在地，同时与精神活动有直接关系。

脑髓本属先天的精气，但其功能正常与否与肾脏的功能是否正常有密切关系。《黄帝内经》中早有所谓“肾生骨髓”（《黄帝内经素问·阴阳应象大论篇》）的说法。肾之所以能生骨髓，

亦依赖于水谷的精气。从二者的关系中，我们可以看到，肾健则脑健，肾衰则脑衰。脑髓的功能正常与否全依肾脏精气的虚实为转移，临床上为何常在脑髓出现功能减退的症状时，采取补肾疗法而见效，其道理就在这里。

至于肝，《黄帝内经》中有“肝者，将军之官，谋虑出焉”（《黄帝内经素问·灵兰秘典论篇》）。肝的功能主“谋虑”，指出肝与注意、思维、记忆等智力范围的精神活动有关。

根据以上所述，中医把人的精神活动归之为几个脏器的功能之中，但我们不能机械地体会，而应当从整体观念出发，从精神活动的统一性出发，以及各脏腑之间的相互联系的基础上去加以理解。

三、精神病的病因学说

关于精神病的病因，内容甚多，归纳起来，不外乎张仲景和陈无择的“三因”学说。汉代张仲景在所著《金匱要略·脏腑经络先后病脉证第一》中称：“千般灾难，不越三条：一者，经络受邪，入脏腑，为内所因也；二者，四肢九窍，血脉相传，壅塞不通，为外皮肤所中也；三者，房室、金刃、虫兽所伤。以此详之，病由都尽。”（《金匱要略释义》，上海人民出版社一九七三年二月新1版）宋代陈无择在所著《三因极——病证方论》中，又把致病因素分为三类即内因、外因、不内外因。内因指七情，外因指六淫，不内外因指饮食不节，劳逸不当等。清代程国彭在《医学心悟》中也说：“医家误，辨证难，三因分症似三山，三山别出千条脉，病有根源仔细看。”（《医学心悟》，人民卫生出版社影印本）凡病之来，不过内伤、外感与不内外因三者而已。现分述如下：

1. 外因：即风、寒、暑、湿、燥、火六淫。六淫之说，源于春秋。如《左传》载医和谓赵孟曰：“阴淫寒疾，阳淫热疾，风淫末疾，雨淫腹疾，明淫心疾，晦淫惑疾……”。所谓“心疾”与“惑疾”，即指精神疾病而言。后世医学家对于外感六淫所致精神障碍者，亦多有论述。如巢元方在《诸病源候论·风狂病候》中，载有“狂病者，由风邪入并于阳所为也”（曹元方等著：《诸病源候论》人民卫生出版社一九五五年六月第1版）。唐代孙思邈著的《备急千金要方》称：“风入阳经则狂，风入阴经则癫。”其后的温病学派在论及风湿、燥火诸因素所致的各种温热病时，描述了神昏谵语、狂乱、抽搐等许多神经精神症状。说明精神病的发生与外感六淫有密切关系。

2. 内因：即指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊等七情而言。这在一般情况下，是人们精神活动的正常表现。但如超过一定的限度，失去正常的节制，就可能成为精神疾病的致病因素。这在我国历代医籍中，多有论述。

祖国医学认为，不同脏腑的病变与相应的情志太过有关。如《黄帝内经素问·阴阳应象大论篇》中载有“怒伤肝”，“喜伤心”，“思伤脾”，“忧伤肺”，“恐伤肾”之说。关于情志所伤与临床证候的关系，历代医学家各有见解。如明代戴思恭在《证治要诀》中说：“癫狂由七情所郁，遂生痰涎，迷塞心窍，不省人事，目瞪不瞬，妄言叫骂，甚至逾墙上屋，裸体打人”（清代陈梦雷等编：《古今图书集成医部全录》卷二百九十五，人民卫生出版社一九六二年十一月第1版）。如《黄帝内经灵枢·癫狂篇》说：“狂者多食，善见鬼神，善笑而不发于外者，得之有所大喜。”“狂言、惊、善笑、好歌乐、妄行不休者，得之大恐”。张仲景在《景岳全书》论及痴呆与情志所伤的关系时写道，“凡

平素无痰而或以郁结，或以不遂，或以思虑，或以疑惑，或以惊恐而渐致痴呆”（《古今图书集成医部全录》，卷二百九十六）。清代沈金鳌编的《杂病源流犀浊》中也说：“或由于有所大恐大喜，大忧大惊，以至失神之为患也。”（《杂病源流犀浊》，上海科技出版社一九六二年十一月第1版）张仲景著的《金匱要略》认为：“妇人脏躁”及“奔豚病”，皆从惊恐而得。由此可见，古代医学家对于精神因素的致病作用是相当重视的。这里必须指出，虽然一定的情志障碍，可引起相应的脏器病变，而出现精神异常。但因人是一个整体，脏腑之间又有着相生相克的复杂关系。另一方面，虽同是七情所伤，但所引起的气血痰火等病理变化亦不尽相同，故临床表现而随之各异。

3. 其它：除六淫、七情之外，尚有许多因素与精神病有关，如酒、饮食等。明代李梴在《医学入门》中也有“膏粱醉饱后发狂者”（清代陈梦雷等编：《古今图书集成医部全录》卷二百九十五）的看法。

关于遗传胎病之说，在《黄帝内经素问·奇病论篇》中载有：“人生而有病癲疾者，……病名为胎病，此得之在母腹中时，其母有所大惊，气上而不下，精气并居，故令子发为癲疾也”。说明癲疾与先天因素有关。

另外，明龚廷贤编的《寿世保元·产后》中说：“败血入心，烦躁发狂，言语错乱，或见鬼神似癲”。（《寿世保元》，上海科技出版社，一九五九年四月新1版）在李梴著的《医学入门》中，曾有“妇人月水崩漏过多，血气迷心，或产后恶露上冲，而言语错乱，神志不守者，此血虚神耗也”（《古今图书集成医部全录》卷二百九十五）的记载，说明精神失常与月经失调和分娩均有一定关系。

有关其它疾病引起的精神障碍，以及药石乱投、误治引

起的精神失常者，古代医籍中亦均有记载，如汉代张仲景所著《伤寒论》中写道：“伤寒脉浮，医者以火迫劫之，亡阳，必惊狂”（《伤寒论》，人民卫生出版社一九七八年十一月第1版）。

由此可见，精神失常莫不与恶酒、宿食、药石、外伤等有关。

根据以上所述，祖国医学中，有关精神病病因学的内容是非常丰富的，其中尤以七情和六淫最为重要。在疾病的发生方面，病因固属重要，但脏腑的虚实，机体抗病能力的强弱，对发病也有密切关系。如《黄帝内经素问·上古天真论篇》中写道：“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来”。清代陈世铎在《石室秘录》中指出：“癫病之生也，多生于脾胃之虚寒，脾胃虚寒，所食水谷不变精而变痰，痰凝胸膈之间，不得化流于心而癫证生矣。”（《石室秘录》，宏道堂藏版）毛泽东同志曾经指出：“外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。”我们在评价致病因素的作用时，也必须遵守这个原则。如果离开人体的机能状况，去片面地在外因上做文章，那将是错误的。

四、中医关于精神病的发病机理

精神病的发生发展，有着一系列的生理病理变化。这在祖国医学中，是以阴阳五行、脏腑经络为纲，结合气血痰火等病理变化加以阐述的。这是辨证施治的基础，掌握这方面的知识，具有重要的临床意义。

（一）阴阳失调与精神病的关系

祖国医学中的阴阳学说，应用于生理病理、诊断治疗的

各个方面。从中医的观点看来，人是阴阳对立的统一体。阴阳二者属性不同，功能也各异。《黄帝内经素问·生气通天论篇》说：“阴者，藏精而起亟也；阳者，卫外而为固也。阴不胜其阳，则脉流薄疾，并乃狂”。只有使二者在运动中保持动态平衡，才能使精神活动保持正常。《黄帝内经素问·生气通天论篇》中有所谓“阴平阳秘，精神乃治”之说，就是这个意思。人之所以患病，正是因为外感六淫或七情内伤以及其它原因导致阴阳失调的结果。如《黄帝内经素问·宣明五气篇》说：“邪入于阳则狂”。宋代朱肱撰的《类证活人书》中说：“伤寒病，若阳气独盛，阴气暴绝，必发躁狂走，妄言面赤，咽痛身斑，斑若锦文。”（《类证活人书》，商务印书馆，一九五五年十一月版）这些，都是指外邪导致阴阳失调而产生精神症状而言。至于《黄帝内经素问·阴阳应象大论篇》中所说的“暴怒伤阴，暴喜伤阳”，则是属于七情内伤所致的阴阳失调。

由于在生理上有所谓阳主动、阴主静的不同，故阴阳的偏胜和偏衰引起的精神障碍在临床上也是有区别的。如《难经·第二十难·论阴阳伏匿的脉象》中说：“重阳者狂，重阴者癫，脱阳者见鬼，脱阴者目盲”。《黄帝内经素问·生气通天论篇》写道：“阴不胜其阳，则脉流薄疾，并乃狂；阳不胜其阴，则五脏气争，九窍不通。”朱丹溪的《足本丹溪心法·癫狂三十九》则根据阴阳失调与临床症状的关系，概括为“癫属阴，狂属阳”。

从以上所述，说明阴阳失调与精神症状的发生有着密切关系，但临床上阴阳失调是在脏腑经络失调以及气血痰火等病理变化诸方面的具体表现。

(二) 脏腑失调与精神病的关系

从脏腑的功能特点来看，精神活动主要与心肝肾有关，但从精神病的发生来看，与心肝脾肺肾诸脏莫不具有一定关系。如《黄帝内经灵枢·本神篇》中说：“心怵惕思虑则伤神，神伤则恐惧自失，……脾愁忧而不解则伤意，意伤则悵乱，……肝悲哀动中则伤魂，魂伤则狂妄不精，……肺喜乐无极则伤魄，魄伤则狂，……肾盛怒而不止则伤志，志伤则喜忘其前言”。这说明七情内伤使心肝脾肺肾五脏受损，皆可导致精神失常。精神情感活动失常，可影响某些内脏的生理功能而引起疾病，某些内脏发生病变时，在临床上也可影响正常的精神情感活动，产生不同的临床病象。这对于指导辨证施治是有重要意义的。

(三) 经络失调与精神病的关系

经络学说，是我国古代劳动人民在长期的医疗实践中发展起来的，是祖国医学的基本理论之一。它和阴阳五行、脏腑学说等有着不可分割的联系。

有关经络失调与精神症状的关系，历代医家多有阐述。如《黄帝内经素问·厥论篇》所载：“阳明之厥，则癫疾欲走呼，腹满不得卧，面赤而热，妄见而妄言。”这说明，实热燥火结于阳明（胃与大肠），可出现精神症状。《伤寒论·蓄血证》中说：“太阳病不解，热结膀胱，其人如狂。”后世温病学派亦认为邪入心包，可出现神昏谵语。这些均说明脏腑经络受损，均可出现精神障碍。

从有关文献资料看来，在十二经脉和奇经八脉中，以足

阳明胃经和手阳明大肠经，足太阴脾经与手太阴肺经，足太阳膀胱经与手厥阴心包经，足少阴肾经以及奇经八脉等经脉与精神病的关系较为密切。而且不同的经脉受损，在临床表现上亦有所不同。实热郁结阳明，可出现狂证。邪入心包可出现神昏谵语。再如《黄帝内经灵枢·经脉篇》中关于肾经失调时的症状为：“是动则病，饥不欲食，面如漆柴，咳唾则有血，喝喝而喘，坐而欲起，目眈眈如无所见，心如悬若饥状，气不足则善恐，心惕惕如人将捕之”。再如《黄帝内经素问·骨空论篇》中说：督脉“上额交巅上，入络脑”，被称为一身之阳。督脉失调，《黄帝内经灵枢·经脉篇》说：“实则脊强，虚则头重，高摇之”，都说明督脉失调可出现神经精神症状。从我们的实践来看，应用督脉电针治疗精神病确有一定效果，这也说明督脉病变与精神病有关。

（四）气、血、痰、火与精神病的关系

气血痰火是中医病理学的主要内容，它是脏腑病理变化的产物，精神失常莫不与此有关。

“血”与“气”，互为阴阳，共同组成为一个对立的统一体，气为生命活动的动力，血为生命活动的基础，故《黄帝内经素问·阴阳应象大论篇》有“阳生阴长”及“阴在内，阳之守也，阳在外，阴之使也”的说法。不论何种原因，一旦造成气血失调，阴阳失去平衡，各种疾病即可随之而生。《黄帝内经素问·举痛论篇》说：“百病生于气也，怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，寒则气收，热则气泄，惊则气乱，劳则气耗，思则气结”。说明七情内伤等种种因素均可导致气机失调而致病。而“惊则气乱”则可出现“心无所倚，神无所归，

虑无所定”的精神症状。

血与精神病的关系也相当密切。早在《黄帝内经素问·调经论篇》中即有“血有余则怒，不足则恐”和“血并于阴，气并于阳，故为惊狂”的论点。以后各医学家在此基础上又有所阐发。李梴在《医学入门》中谈到产后精神失常时，则认为这是由于“血虚神耗”，或产后“恶露上冲”引起“血气迷心”（《古今图书集成医部全录》卷二百九十五）的原因。清代王清任在《医林改错》中进一步指出：“癫狂一症，哭笑不休，詈骂歌唱，不避亲疏，许多恶态，乃气血凝滞脑气，与脏腑气不接，如同做梦一样”（《医林改错·癫狂梦醒汤》）。说明无论癫狂证，均与气血失调，造成气血凝滞有关。

“痰”与“火”，也是引起精神病因素之一。痰迷心窍的理论在祖国医学中占有重要地位。早在《黄帝内经》中即有以“下其痰”而治狂证的说法，后张仲景在《金匱要略》中亦曾提到，但观点尚不甚明确。直至金元时期，所谓“痰迷心窍”的理论才告形成。如元代朱震亨在《丹溪心法》指出癫狂证“大率多因痰结于心胸间，治当镇心神，开痰结”（《古今图书集成医部全录》卷二百九十五）。明代张介宾在《景岳全书》中也说：“癫病多由痰起，凡气有所逆，痰有所滞，皆能壅闭经络，格塞心窍。”这里不仅阐明了痰的形成与七情内伤、气机失调有关，而且强调了“痰”与精神病的密切关系。临床上“豁痰开窍”的治疗方法，正是这一理论在治疗上的应用。

“火”为六淫之一。关于火与精神病的关系，早在《黄帝内经素问·至真要大论篇》中即有“诸躁狂越，皆属于火”等论述，这里不仅说明了“火”与“热”的关系，只是程度上的不同，而且强调了“火”能致狂的重要作用。历代医学家在此基

础上又有所发展。如明代李挺在《医学入门》中论及癫狂时指出：“狂者凶狂也，轻则自高自是，好歌好舞，甚则弃衣而走，逾垣上屋，又甚则披头大叫，不避水火，且好杀人。此心火独盛，阳气有余，神不守舍，痰火壅成使然。”“癫者异常也，平日能言，癫则沉默，平日不言，癫则呻吟，甚则僵仆直视，心常不乐。此阴虚血少，心火不宁”。由此可见，癫狂的发生，不仅与“火”作用于“心”有关，而且在临床上，尚有虚实的区别。

在精神病的发生上，“痰”与“火”也往往互为作用，不可分割。如明代虞博在《医学正传》中说：“大抵狂为痰火实盛，癫为心血不足，……狂宜乎下，癫则宜乎安神养血，兼除痰火。”（《古今图书集成医部全录》卷二百九十五）而清代陈世铎在《石室秘录》中论及痰的治疗时，强调必须补气。称：“苟徒治痰而不补气，未有不速之死者。”（《古今图书集成医部全录》卷二百九十六）可见痰火之间以及痰火与气滞气虚等，莫不具有密切的关系。

总之，从七情六淫到伤及脏腑经络，以至阴阳失调，而发生气、血、痰、火等一系列变化，反映了精神病发生发展的病理过程。这些理论，值得进一步加以研究。

第二章 中医关于精神病的 诊断方法

精神病的中医诊断方法，包括四诊、八纲等内容，这是识别病证，推断病情，为防治疾病提供根据的基本手段。

一、四 诊

望、闻、问、切称为四诊。这是诊断疾病的第一步，种种证候资料都将通过四诊而获得。因此，作为一个临床医生，必须熟练掌握。

(一) 望诊

医生通过视觉，对患者的神、色、形、态以及分泌物、排泄物等，有目的地进行观察，以获得有关的证候资料，称为望诊。在精神科，以观察患者的精神状态、表情动作、皮肤、五官及舌苔等较为重要。

1. 望神色：神色总括精神与气色。人的精神状态和气色的变异，足以显示人体的机能状况和疾病的轻重缓急。如面色红润，两目有神，精神焕发，多为无病；面色晦暗，目光无神，表情呆滞，多为重病。因此，望神色在诊断上有重要作用。

(1) 如面红目赤，兴奋激越，表情多变，体格壮实，多属实证狂证。

(2) 如面色晦暗，目光无神，表情呆滞，多属虚证 癡证。

(3) 如对空讲话，侧耳倾听，伴有或怒或喜等情感变化，多为妄见妄闻(幻觉)。

(4) 如表情苦楚，情绪抑郁，落落寡欢，多属癡证（多为抑郁症或由于罪恶妄想或贫穷妄想等所支配）。

(5) 如意识不清，妄见妄闻，或循衣摸床，兴奋躁动，多为伤寒热病的失神表现(某些症状性精神病，脑器质性精神病，如病毒性脑炎等常见之)。

(6) 如躁动不安，形容枯槁，唇裂舌燥，多属狂证，日久伤阴。

2. 望舌：舌诊是望诊中的重要组成部分，也是中医诊断学的特色之一。舌诊内容包括舌质与舌苔两部分。一般说来，舌质主察内脏的虚实，舌苔主察病邪的深浅与胃气的盛衰。在临床实践中，大抵气病观苔，血病查质。但二者不可截然分开，必须互相参证，综合分析。

(1) 望舌质：应注意色泽、形态、荣枯等变化。

① 色淡白：多见于痰气郁结和气血两虚者，常表现有神情呆滞、行为孤僻、淡漠退缩等精神症状，多见于癡证。

② 色鲜红：为热证的表现。舌尖红为心火炽盛，舌边红为肝胆有热，精神症状多为兴奋躁动。

③ 色绛红：为阴虚火旺之证。如颜色深绛，伴有裂纹，或光绛无苔，均提示邪热伤阴过甚，多见于情绪紧张，焦虑不眠，或狂证日久的患者。

④ 色紫：色深干枯属热，色浅湿润为寒，色紫暗而湿润者为淤血。多见于有幻觉、妄想，伴有躁动不安、行为紊乱

的患者。

此外，舌体胖嫩，舌边有齿痕者，不论苔色如何，皆属虚证，常见于癫证患者。舌有芒刺或裂纹者，多属邪热内结或血虚阴虚，多见于实狂或虚狂的患者。至于舌体颤动或有吐弄的表现者，多属肝风或心脾有热（在精神科，因服用抗精神病药物而引起锥体外系反应的患者，常有此种表现）。

（2）望舌苔：

① 薄白滑腻：多为湿困脾阳，痰气郁结所致。常见于癫证初起。

② 白厚而腻：多为痰气郁结。常见于癫证日久，表现有神情呆滞、表情迷茫、思维奇特等精神症状。

③ 黄腻：多属血淤兼湿，或顽痰化火。其精神症状常表现为幻觉妄想、焦虑不安等。

④ 黄厚干：为痰热壅盛，郁热伤津。常见于兴奋不眠、躁动不安的狂证患者。

⑤ 黄兼黑而腻：为湿热内结，如焦黑老黄而有芒刺者，则为里热已极。多见于有幻觉妄想、行为紊乱的久病癫证，以及狂证日久、邪热伤阴的患者。

另外，还有其他颜色相兼和厚薄滑腻等种种变化，必须注意与舌质、脉象等参证，分清寒热，辨别虚实，切不可形而上学，生搬硬套。

（二）闻诊

闻诊，包括听声音和闻气味两方面。通过了解患者在语声、排泄物的气味等方面的变化，有助于临床辨证参考。

1. 听声音：包括语声、呼吸、咳嗽等内容，其中以听语

声对于精神科的诊断意义较大。声音的产生在于“气”，因气有盛衰，所以声音有强弱之别。通过听患者说话声音的高低及具体内容，可以测知患者的思维活动以及情感倾向，而這些，对于精神病的诊断是极有意义的。

(1) 发声重浊，声高而粗者，多属邪热亢盛，常见于狂证、实证。

(2) 话多声嘶者，多属邪热内结，狂证日久，损伤肺阴。

(3) 话多声高而内容零乱者，多属狂证、实证。

(4) 语声低微或喃喃自语者，多属癫证、虚证。

(5) 自言自语，无故漫骂，多为幻觉支配，常见于癫证、狂证。

(6) 妄言妄语，伴循衣摸床等证者，称为“谵语”，多为热证、实证。

嗅气味：以大便气味的改变，在诊断上意义较大。如：

(1) 大便腥臭：为肠胃有热，多见于狂证、实证。

(2) 大便酸臭：多因暴饮暴食，宿食停滞，消化不良所致，常见于狂证、实证。

另外，病程较长的患者，身上有一种特殊的气味，这种气味可能与卫生搞得不好，服用抗精神病药物或与疾病本身有关。

以上列举了闻语声与嗅气味两方面的主要内容。在闻语声方面，对于生理上的缺陷和感情上的变异，以及方言、习惯等带来的变化，必须注意加以鉴别。

(三) 问诊

医生向家属或患者本人有目的地查询病情，称为问诊。根据精神病的特点，主要有一般情况、发病诱因、病程经过、症状特点、性格特点、习惯嗜好、既往史、家族史以及患者对疾病的态度和认识等内容。其中症状特点和病程经过，是问诊的重点，是辨证施治的重要依据之一，必须详细地询问。在辨证施治中，如性别和年龄，虽属一般情况，但有时在诊断上非常重要。因为有的病起病年龄较早，有的病起病年龄较晚。有的多见于男性，有的则多见于女性。如脏躁一病，即以青年女性为多见。再如，了解发病诱因，不仅在辨证上是重要的，在治疗上也是同样重要的。精神病的发生，大多有一定的诱因，特别是精神因素，即所谓“七情”所伤，不仅能为医生分析病情提供依据，而且给治疗特别是心理治疗提供方向，使之更具有针对性。

总之，医生必须针对各种疾病的证候特点及其演变规律，进行深刻的了解和分析，同时又要掌握病人的心理特点，才能不断提高问诊的技巧。

(四) 切诊

切诊，在精神科诊断中，占有极其重要的地位。关于精神症状与脉象变化的关系，还是一个有待深入探索的问题，需要细致地观察和研究。在这里，只能就我们在诊断中常见的脉象加以介绍。

1. 浮脉：浮脉为阳，主病在表。但浮而有力为表实，浮而无力为表虚，二者必须注意鉴别。一般说来，浮而有力

多属癫狂实证。

2. 沉脉：沉脉为阴，主病在里。有力为里实淤血，无力为里虚气陷。前者多表现为幻觉、妄想，思维怪异；后者多表现为淡漠退缩、呆滞少言等精神症状。总之，沉脉多见于病程迁延的慢性癫证患者。

3. 迟脉：迟脉为阴，主病为寒。迟而无力，多属虚寒，迟而有力，多为冷积实证或有淤血。部分表现为静而懒言、淡漠退缩的癫证患者，有时可有迟脉。

4. 数脉：数脉为阳，主病为热。数而有力为实，数而无力为虚。狂证实证的患者，脉多数而洪大，表现为躁动不安，面红目赤，此属痰火扰心所致。阴虚火旺的患者，脉多细数。

5. 滑脉：滑脉为阳，病主痰火。此脉在癫狂两证中多见于痰气郁结或痰火为患的病人，精神症状常表现为兴奋躁动、幻觉妄想等。

6. 弦脉：多属肝气郁结或风痰，前者为气滞，精神症状表现为情绪忧郁，焦虑不安；后者为血淤，精神症状常表现为妄想幻觉等。

7. 细脉：细脉属阴，其病主虚，凡气血两虚的久病虚癫患者，其脉多见沉细无力。

8. 实脉：实脉属阳，其病主实。多见于新病实证的狂证患者，因内火炽盛，常表现有兴奋躁动、暴饮暴食等精神症状。

9. 虚脉：虚脉属阴，其病主虚。多见于气血两虚的癫证患者，表现有情感淡漠、神疲懒言等精神症状。

10. 洪脉：洪脉属阳，其病主热。狂证实证患者，常可见

到洪大的脉象。

以上扼要地介绍了四诊在精神科的应用方法。某种病变，如果脉证相符，当然辨证也比较容易。但在实际工作中，有时要舍脉从证，有时却要舍证从脉，要根据病人的具体情况而定。根据我们的体会，在精神科常常以舍脉从证者居多。其原因，除了在前面所叙述的以外，还因为脉象常受着患者的精神状况、饮食以及某些药物因素的影响。总之，要注意把四诊情况全面考虑，综合分析，这样才能提高诊断的准确性。

二、八 纲

八纲，就是阴、阳、表、里、寒、热、虚、实。阴与阳，表与里，寒与热，虚与实，是根据病人的证候表现，通过分析，归纳的四个对立面。八纲之间，有着不可分割的内在联系，均不可孤立对待。其中阴阳二纲，可以概括其他的六纲，因此，阴阳二纲，又称之为纲中之纲。比如寒证，就有里寒外寒之分；热证，也有里热外热之别。这就是所谓阴中有阳，阳中有阴。所以在临床实践中，对于八纲辨证，必须根据具体情况，具体对待。

1. 阴阳：阴阳是八纲辨证的总纲。《黄帝内经素问·阴阳应象大论篇》中写道：“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也，治病必求于本。”这就是说，阴阳是事物发展的一般规律，疾病，就是人体阴阳失调的结果。治病，就是调整阴阳，以达到“阴平阳秘，精神乃治”（《黄帝内经素问·生气通天论篇》）的目的。《黄帝内经素问·阴阳应象大论篇》又说：“善诊者，察色按脉，先别阴

阳。”故凡诊脉施治，必须先审阴阳，乃为医道的纲领。阴阳无谬，治焉有差，医道虽繁，可一言以蔽之，曰阴阳而已。由此可见，阴阳在诊断上的地位是非常重要的。

关于阴阳失调与精神病的关系，根据《黄帝内经》中动为阳、静为阴的观点，《难经·第二十难·论阴阳伏匿的脉象》中提出了“重阳者狂，重阴者癫”的看法。所谓癫与狂，即为两组不同的证候群。如金朝刘完素所著的《河间六书》中说：“多喜为癫，多怒为狂”（《古今图书集成医部全录》卷二百九十五）。元代朱震亨在《丹溪心法》中也说：“癫属阴，狂属阳，癫多喜而狂多怒”（《古今图书集成医部全录》卷二百九十五）。以上论述，说明了阴阳失调与精神病的关系。现将阴阳偏盛偏衰而致失调所引起的精神症状的一般表现列表（表1）如下：

表 1 精神病阴阳失调的一般表现

类别	四 诊			八 纲
	望	闻	切	
阴	淡漠少语，喜静少动，如醉如痴，面色不华，舌质淡，苔薄白	语声微细	沉、迟、细、虚	里、寒、虚
阳	兴奋躁动，狂言乱语，面红目赤，舌质红，苔黄厚	语声响亮	浮、数、洪、滑、弦、实	表、热、实

2. 表里：是指病变部位的内外和病势的轻重深浅而言。如一般外感风寒，病初常有恶寒发热、头痛、肢体酸痛等症，表示其病在表，称“表证”；而其他有些疾患常表现为腹胀便秘、腹泻、神志不清、烦躁不安、角弓反张等症，则表示其病在里，称为“里证”。精神病一般表现为里证，多属七情所

伤，导致脏腑功能受损，气血失调，由此而出现兴奋躁动、淡漠少言、如醉如痴等一系列精神症状。

3. **寒热**：指疾病的属性而言。《黄帝内经素问·阴阳应象大论篇》说：“阳胜则热，阴胜则寒”。可见所谓寒热，乃阴阳偏盛偏衰的具体表现。辨别疾病的寒热，在治疗上具有重大意义。《黄帝内经素问·至真要大论篇》说：“寒者热之，热者寒之，温者清之，清者温之”。这就是说，寒证要以热药治，热证需用寒药解，这是治疗上的基本原则之一。

在精神科，比如手足发凉，面色发青，表情淡漠，行为孤独，少动少言，大便稀薄，喜热怕冷等表现，属于寒证，而面红目赤，兴奋躁动，大便秘结，肢体发热，怕热喜冷等症状，则属于热证。在治疗上，前者宜用温阳散寒，后者则宜清热泻下。

疾病的表现是复杂多样的，以上所述，只是单纯的寒证和热证，在临床实践中，有时是寒热交错，有时是真寒假热，或者是真热假寒。因此，必须细心地加以鉴别，分别予以不同的处理。

4. **虚实**：是指人的机体的抗病能力和病邪在斗争过程中的盛衰消长。虚指正气不足，实指邪气有余。如面色不华，形容枯槁，精神不振，神疲力乏，少气懒言，淡漠呆滞，语声低微等症属于虚证；而体格壮实，狂言乱语，大便燥结，腹满胀痛，声音洪亮者，属于实证。前者治宜温补气血，后者治宜涌吐攻下。

临床上，除了单纯的虚证和实证之外，尚有虚实错杂和虚实真假等特殊情况，在辨证时必须全面考虑，仔细区别。在治疗上，或先攻后补，或先补后攻，或攻补兼施，必须权

衡主次，酌情处理。

以上简述了八纲的基本概念和在精神科的基本用法，但临床现象是十分复杂的。因此，对于八纲不能机械地对待，而必须从阴阳这条总纲入手，灵活掌握。中医关于各种精神病的诊断列于表2。

三、中医关于精神病的鉴别诊断

1. 癫证与脏躁的鉴别：癫证比较顽固，往往长期持续，脏躁发作比较短暂，恢复较易。癫证男女均可发生，脏躁以妇女为多见，男子较少。癫证先见精神抑郁，表情淡漠，继则悲喜无常，如痴如醉，脏躁多知觉过敏，睡眠不安，发作时自觉烦闷急躁，或悲伤哭泣，或作痉挛，或惊狂乱叫，过后一如常人。

2. 狂证与阴躁、如狂、惊狂的鉴别：

(1) 阴躁：阴证狂躁，实非狂证，其病但躁，欲坐泥水、井中、阴凉处，躁扰不宁，证见手足逆冷，脉沉细，虽烦渴而不喜饮，甚则身微热，面赤戴阳，足冷烦躁，脉数无力。乃里寒下虚，阴盛阳越，若误作狂实，祸不旋踵。试以凉水，入口即吐而不纳，脉微弱无力，或浮大而空，均应明辨。

(2) 如狂：太阳热邪不解，随经入腑，搏结血分，少腹急结，小便自利，脉微而沉，其人如狂，乃热结膀胱，因病而狂，非狂证也，下血乃愈。又有先伤于内，而寒复感于外，见证如狂，乃属虚狂，面无黄赤之色，刚暴之气，内无胸腹之结，滑实之脉，虽现躁扰，禁之则止，多妄诞而声息不壮，或眼看虚空，惊惶不定，上无口渴，下无便秘，此皆精气受伤，神魂不守，如妄行攻泻，必至杀人。

表 2 中医关于各种精神病的诊断

病种	脉证特征		脉象	舌苔	语声	情志	呼吸	动态	表情	二便	体温
	脉	证									
癫	歌哭不时， 如痴如醉， 秽洁不辨	弦滑或 细微	白腻或舌 红苔黄，虚 证舌淡苔少	独言独 语，反复 复	独 言，反 复重 复	郁不 郁，时 哭时 笑	一般， 有虚 时略粗， 证多清冷	多静	淡漠 呆钝	溲清 便清 或正 常	正常
狂	狂叫骂詈， 毁物殴人， 少卧不饥	弦紧滑 实，久则 细数	舌红绛， 苔多黄腻或 黄燥	狂叫， 音壮厉	声 音壮厉	手舞足 蹈，狂 歌易怒	粗厉	多动	凶狂	溲赤 便秘	正常， 有时 略高
痫	卒倒无知， 涎壅痰口吐 沫，或作畜 鸣，醒后如 常	滑或细弱	白腻或微 黄，或微白， 或如常人	发作时， 作畜音	发声时， 呻吟， 醒则如 常	发时呻 吟，醒 则如常	一般， 久则 多低弱	作时 止时	忧郁	无变 化	正常

(3) 惊狂：惊狂乃亡阳惊惕之证，阳邪在表，过汗津伤，正气耗散，或火劫、烧针、艾灼、劫夺阴津所致。其证倏然而起，惕然而动，精神耗乱，肢体不宁。当视患者体质虚实进行调治，亦不可误作狂证。

3. 痫证与卒中、痉病的鉴别：痫病仆地，作声如畜鸣，口吐涎沫，发作后一如常人。中风于发作后多有口眼喎斜、半身不遂等证。痉病虽亦时发时止，然身强直，反张如弓，并无畜音，以此为辨。

常见精神病的鉴别诊断见表 3。

断诊鉴别精神病见表 3

病种	脉证 行为特征	脉象	舌	苔	语	声	情志	呼吸	动态	表情	二便	体温
癫	歌哭不时，秽如醉如痴，不辨洁	弦滑或细微	白腻或舌苔黄，虚证舌淡苔少		独言或舌反复语，复	独重	郁郁不乐，时哭时笑	一般，略有粗多，略虚证，清冷	多静	淡漠呆钝	溲清，或便溲，或正常	正常
癫呆	沉默寡言，目举动不经，瞪口呆	沉细无力	舌润，苔薄	苔	低声小语		神志恍惚，神情麻木	略粗，清冷	多静	痴呆	溲清，或便溲，或正常	正常
狂	狂叫骂詈，少物殴人，不饥	弦紧滑实，久则细数	舌红绛，苔黄		狂叫，声音壮厉	声	手舞足蹈，狂歌易怒	粗厉	多动	凶狂	溲赤，便秘	正常，有时略高
癫狂	有时神志恍惚，言语错乱，有时凶狂易怒，打人毁物	弦滑微数	舌淡红，苔黄		时独言或时狂言，时狂言音大叫，壮厉	独	时哭时笑，狂舞乱舞	粗厉	时静时动，动静无常	无常	溲黄，或时有便秘	正常，有时略高
病	卒倒无知，或筋吐沫，或抽搐，或常	滑或细弱	舌润，苔薄	苔	作畜叫声	声	时发呻吟	一般，久则低弱	时作时止	忧郁	无变化	正常
病狂	有时少卧，不饥，愤怒发狂，有时卒然仆倒，抽筋吐沫	弦滑或微数	舌红，苔黄	苔	壮厉，或如畜叫	或	时愤怒，时呻吟	多粗厉	多动	时郁时狂	溲赤，便秘	有时略高

第三章 中医关于精神病的治疗原则

一、整体观念

祖国医学认为，人体内部的阴阳、气血、脏腑等各部分之间，是相互依存又相互制约的。人体就是以脏腑为中心，通过经络运行气血，与五官、肢体等组织相联系的有机整体。这种整体观念，广泛地应用于祖国医学的生理、病理、诊断、治疗等方面。我们在诊断与治疗精神病的临床实践中，同样也是以整体观念为指导，着重调整人的机体的阴阳平衡，根据具体情况，辨证施治。切不可头痛医头，脚痛医脚，顾此失彼，贻误病机。

二、精神治疗和药物治疗相结合

人的精神状况和思想活动，对疾病的发生和发展起着很重要的作用。祖国医学把人的精神活动称为七情，即喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。七情内伤可引起疾病。人的七情变化是大脑对客观外界事物的反映。在正常情况下，由于受外界的影响，精神活动发生一系列变化，但不会引起各种病变，是属于正常的生理活动。如果精神刺激严重，或刺激持续时间长，造成情志的过度兴奋或抑制，超过了正常生理活动所能调节的范围，影响到体内阴阳、气血、脏腑的功能失调，

就会发病。反之，如果人的情绪乐观，保持情志活动正常，可使肝气舒畅，气血畅通，从而提高了人的机体的抵抗力。如元代朱震亨在《丹溪心法·活套》中说：“五志之火，因七情而起，郁而成痰，故为癫癇狂妄之证，宜以人事制之，非药石所能疗也，须诊察其由以平之”（《古今图书集成医部全录》卷二百九十五）。这说明祖国医学充分注意到精神因素在精神病治疗中的应用。历代医家在长期与疾病作斗争的实践中，就提出了一套以情胜情的方法来治疗精神病。因此，我们应克服那种见病不见人的思想，树立治病又治人的医疗作风，从病人的实际情况出发，积极做好政治思想工作，调动患者的主观能动性，这是我们预防、治疗精神病的重要内容之一。

三、标本兼顾

任何疾病，都有一个标与本的问题。所谓“标”，即指疾病的现象；所谓“本”，即指疾病的本质。前者包括了某种疾病的整个临床表现，后者则包括了这一疾病的病因和发病机理的全部内容。比如，一个狂证病人，临床表现为兴奋激越，躁动不安，这是标；而病在何脏何腑？病因是什么？是气滞血淤引起，还是痰火扰心所致？这便是本，这是我们临床医生必须努力探求的东西。在治疗上，一般的原则是，急则治其标，缓则治其本。但是在通常的情况下，总是标本兼顾。如果只治标，不治本，临床症状虽可获得一度缓解，但因病因未除，终将难获痊愈。又由于在一般情况下，治标较易，用时也较短，而治本较难，需时也较长，所以在病情较急较重的情况下，如不及时采取治标的措施，就不能尽快地解除患者的痛苦，这就是急则治其标的道理。总之，治病必须作

出正确诊断，以求其本，注意标本兼顾，这是我们每一个医生开处方治病所必须遵循的原则之一。

四、辨证施治

辨证施治，是中医诊断疾病的核心，也是治疗精神病所必须遵循的重要原则之一。所谓辨证施治，就是运用中医关于病因学、病理生理学等方面的知识，将四诊所获得的资料，通过八纲进行分析归纳，以决定病变的部位、性质及其程度，然后根据病人的具体情况，给予不同的治疗。中医之所以强调辨证施治，乃是由于客观事物本身的复杂性所决定的。比如，同一疾病，由于性别年龄的不同，体质的强弱不一，病程的长短有别等因素的影响，在不同的病人身上，就有不同的临床表现。正是这样，我国古代医学家很早就提出了所谓“舍脉从证”或“舍证从脉”，以及“同病异治”或“异病同治”等科学观点。因此，在诊治过程中，必须根据病人的具体情况，具体分析，以便具体对待，实行辨证施治，才能取得满意的效果。如若千篇一律，生搬硬套，那是没有不出差错的。

五、预 后

癫、狂、痫的预后，根据前人经验，结合本院实践，分述如下：

(1) 凡癫、狂、痫证神脱目瞪，如愚如痴者，多难治。体质异常消瘦，形色憔悴者，预后更差。

(2) 癫狂证无故大便，自下黑血者，难治。

(3) 凡病从阴出阳，如原属癫证，由癫转狂者易治；从阳入阴，如原属狂证，由狂转癫者难治。

(4) 痫狂之证，为痫久不愈又兼发狂，往往难治。

(5) 凡癫痫发时仆地吐涎沫，强惊起如狂，反遗粪者，难治。

(6) 痫证发作间隔时间短者，比较易治；间隔时间越长，越不好治。

(7) 癫狂之证，经过电休克治愈，不久复发，又用电休克，愈而又发，反复三次以上，病情恶化转痴呆者多属难治，其机理尚待探讨。

(8) 先天性痫证，由儿在母腹受惊，痰气逼入心肝，与本身气血搏结，多不易治。怀抱之子，神气不足，偶有所触，神不守舍，痰涎乘虚侵袭致痫者，治之亦较难。若成人外感风寒，内伤饮食，脏气闭阻，郁而生成之痫，则比较易治。

(9) 脉诊，癫证脉滑大者生，沉小紧急者难治；狂证脉实大者生，沉小者难治；痫证脉虚缓者可治，弦急者不可治。根据临床经验，癫狂见沉急之脉，痫证见沉小急实之脉，亦有治愈者。

第四章 中医常用治法在精神科的应用

中医治疗疾病的方法很多，如汗、吐、下、和、温、清、消、补等。由于精神病本身的特点，有些治法在精神科就不那么常用。相反，有些治法（如吐、泻等）则较其它科应用为多。根据我们的临床实践，一般以清心降火，舒肝解郁，祛痰开窍，养血安神等方法较为常用。

一、清心降火法

此法多用于狂证患者。因狂证始发，由于气血受阻，胃火炽盛，导致肝胆实热内燔，热灼于肺，火乘于心，故出现面红目赤，大便秘结，小便赤黄等症。又由于火热壅盛，熬液成痰，进而痰火扰心，蒙蔽心神，故狂证乃作。因此，在治疗上采取涌吐攻下，降火清心，方可使其治愈。所以，清心降火除痰是治疗精神病的主要方法之一。方剂莱菔子、瓜蒂散、将军汤、清心汤等，是治疗精神病狂证的良方。

二、舒肝解郁法

忧郁沉默是精神病临床中多见的一组症状。肝喜条达，而精神抑郁，肝气郁结，就出现胸闷，胁胀，嗳气，引起脾胃不和，少食少眠。因肝与胆相表里，进而出现惊悸多梦，疑虑重重。因此，根据舒肝解郁法，以七气汤、逍遥散、加

味温胆汤等方剂治之。

三、祛痰开窍法

前人认为，“痰”是百病之源。温病里所说的“痰迷心窍”，指精神科、神经科的脑病，如脑瘤、脑炎的昏迷不语，癫痫发作和中风等，治则多以除痰祛风，随之用开窍醒脑，再就是紧张木僵型的精神病，可用苏合香丸、祛风化痰汤、清心抑气汤等。

四、养血安神法

病经涌吐攻下，祛邪必须补正，促使恢复健康，或病势短暂，需养血安神者，可用补心汤、加味归脾汤、定志丸等。

精神病的治疗，与其他疾病一样，应该针对不同的发病原因，具体征候，辨证施治，注意整体，辨别阴阳、寒热、虚实，既有一定原则，又要灵活掌握。

狂证多热多痰，多实热壅结，涌吐攻泻，清热除痰为主要方法。癫证多为痰气郁结，心血不足，宜辨别虚实，或清热除痰，或舒肝解郁，或养血安神。癫痫证多因脾肾两虚，风痰阻络，宜温脾补肾，祛风化痰，开窍醒脑。临床上还要根据病人的性别、年龄，发病新久，病情轻重，体质强弱，或攻或补，或清或温，或通络涤痰，或扶正驱邪。病无定法，方随证转，具体辨证用药，应灵活掌握，经典验方，注意加减，切忌生搬硬套。

第五章 中医关于精神病的 分类和治疗

一、分证的方法

癫、狂、痫的分类，内经并无明显的界限，具体内容，也互有详略，一般对癫狂叙述较详而略于痫症，言狂多及癫，言癫亦多涉及痫。《黄帝内经灵枢·癫狂篇》对狂证的描写，实际上是癫证的形象；而《黄帝内经素问·奇病论篇》对癫证的分析，则又是痫证的具体内容：“人生而有病癫疾者，……病名为胎病，此得之在母腹中时，其母有所大惊，气上而不下，精气并居，故令子发为癫疾也。”不正是指小儿先天性的痫证么。

后代医家对癫、狂、痫的分类，各有不同的见解，归纳起来，可分为以下两种：

（一）内经分证法

癫狂不分（或者说寓癫于狂，举狂赅癫），癫痫混同（以痫为癫或癫痫混称）。它以扁鹊、巢元方、孙思邈、王焘、王怀隐、张景岳等为代表。《难经·五十九难·论狂病与癫病的鉴别》云：“狂癫之病，何从别之？然：狂疾之始发，少卧而不饥，自高贤也，自辨智也，自贵倨也，妄笑，好歌乐，妄行不休是也。癫疾始发，意不乐，僵仆直视，其脉三部阴阳俱

盛是也”。这种说法与内经是完全一致的。

隋代巢元方《诸病源候论》云：“风癫者，由血气虚，邪入于阴经故也，……其发则仆地，吐涎沫，无所觉是也。”“狂病者，由风邪入并于阳所发也，……狂发，或欲走，或自高贤，称神圣是也。”“痫者，小儿病也。十岁已上为癫，十岁已下为痫，其发之状：或口眼相引，而目睛上摇；或手足掣纵，或背脊强直，或颈项反折。”《诸病源候论》，人民卫生出版社一九五五年六月第1版）巢氏的论点，表面上癫、狂、痫三证分明，实际上仍是癫狂不分，癫痫相混。孙思邈、王焘、王怀隐、张景岳、虞搏、楼英、徐灵胎等都有类似的见解。

（二）后代分证法

将癫、狂、痫具体划分为三个不同的类型，眉目清楚，掌握较易，以朱震亨、龚廷贤、王肯堂、李梴、龚云林、程钟龄、沈金鳌、叶天士、陈修园等为代表。

科学的发展，总是从无到有，从简单到完备。癫、狂、痫学理的形成，也正是沿着这个规律。唐宋以前，主要沿用内经分证，只是在理论、辨证用药方面充实改进，还存在一定的局限性，方剂的创造，如虎睛汤治风癫，四物鸢头散治风狂，水银丸治风痫，或由于药源较少，或由于毒性较大，在临床上也很少使用。元明以后，在前人经验的基础上，结合临床实践，对癫、狂、痫有了新的认识。元朱震亨在《丹溪心法》中说：“癫属阴，狂属阳，癫多喜而狂多怒……，癫者神不守舍，狂言如有所见，经年不愈，心经有损，是为真病，如心经蓄热，当清心除热；如痰迷心窍，当下痰宁志，……狂病宜大吐下则除之。”又说：痫证有五：“牛吼、马嘶、鸡

鸣、羊叫、猪呼……”（《足本丹溪心法》，上海文瑞楼版），无非痰涎壅塞，迷闷心窍，发则头旋颠倒，手足搐搦，口眼相引，胸背强直，叫吼吐沫，食顷乃苏。大大突破了内经的范围。

明代龚廷贤在《寿世保元》中说：“癫者，喜笑不常，颠倒错乱之谓也”。“狂者，狂乱而无主定也。”“大抵狂为痰火实盛，癫为心血不足”。“阳气太盛，胃与大肠实热，燥火郁结于中而为之耳，此则癫狂之候也。”“痫症，发则仆地，闷乱无知，嚼舌吐沫，背反张，目上视，手足搐搦，或作六畜声者是也。”（《寿世保元》，上海科技出版社一九五九年四月新1版）原其所由，或因七情之气郁结，或为六淫之邪所干，或因受大惊恐，神气不守，或自幼受惊，感触而成，皆是痰迷心窍，如痴如愚，治之不需分五，俱宜豁痰顺气，清火平肝。如癫与狂分开，而又和痫证绝不相混，明清绝大多数医家，都同意这种分类法，现在已经基本上成为定论，为后代所沿用。

明代李梴在《医学入门》中谈到痫与癫狂不同，“痫与癫狂相似，但痫病时发时止，邪流五脏，癫狂经久不愈，邪全归心。”又说：病只一痰，“内伤最多，外感极少。盖伤饮食积为痰火，上迷心窍，惊恐忧虑，则火盛神不守舍，舍空痰塞。丹溪云：病因痰塞心窍，发则头旋卒倒，手足搐搦，口眼相引，胸背强直，叫吼吐涎，食顷乃醒。病先身热脉浮，在表者阳痫，属六腑，易治。病先身冷脉沉，在里者阴痫，属五脏，难治。若神脱目瞪如愚痴者，亦难治。”同时，还说痫有五种：“痫久必归于五脏。肝病，面青，摇头，喜惊，作鸡鸣状。心病，面赤，口张，摇头，马嘶。脾病，面黄，下利，吐舌，羊吼。肺病，面白，吐沫，腹胀，牛吼。肾病，面黑，直视如尸，猪叫。此五痫病状偶类之耳。其实痰火与惊三者

而已。”《古今图书集成医部全录》卷二百九十八）这为后代中医对精神病癫和痫的分类提供了科学的根据。

从上述文献分析，祖国医学癫、狂、痫的内容，与现代医学精神病的涵义，基本上是一致的。我们在临床实践中，运用癫、狂、痫的理法方药，治疗精神病，能够取得比较满意的效果，也是有一定的理论依据和实践基础的。

二、癫 证

（一）概述

癫证，乃临床上较为多见的一种精神病。其主要原因，多为七情所伤。主要特点为静而少言，如痴如醉，或悲或喜。起病或缓或急，病程多较迁延。总之，临床所见，以阴证为主，故《难经·第二十难·论阴阳伏匿的脉象》中早有“重阴者癫”的说法。

（二）病因和发病机理

癫证者，多由于七情所伤，以致心火不宁，肝气抑郁，脾气不升，进而气滞津聚，结而成痰，上逆阻蔽神明所致。如《黄帝内经灵枢·本神篇》写道：“心怵惕思虑则伤神，神伤则恐惧自失……，脾愁忧而不解则伤意，意伤则悵乱”。十分明确地说明了七情内伤的致病作用。明代张景岳总结了前人的理论，认为癫证乃由于气郁痰结，蒙蔽心窍所致。他在《景岳全书》中写道：“癫病多由痰起，凡气有所逆，痰有所滞，皆能壅闭经络，格塞心窍，故发则旋晕僵仆，口眼相引，目睛上视，手足抽掣，腰脊强直，食顷乃苏。”（《古今图书集成医部

全录》卷二百九十六) 总之，癲证多属痰气郁结，其病主要在心、肝、脾。

(三) 辨证施治

癲证的病情，有轻重缓急之分，故治疗上当有新久虚实之别。一般说来，新病多实，久病多虚。对于新病实证，多以清痰解郁为主，辅以养血安神；而对于久病虚证，则应以养血安神为主，兼以清痰解郁，这是一般原则。在治疗过程中，需根据具体情况，仔细斟酌，灵活处理。

1. 癲证：有精神抑郁，情感淡漠，或自言自语，哭笑无时，或少食不眠，敏感多疑，或热冷不知，秽洁不辨。舌多淡红，苔白腻或黄，脉多弦滑。

(1) 病因：思虑太过，以致肝气郁滞，脾气不升，郁而成痰，蒙蔽心窍，以致神志不守。舌苔白腻，为痰浊中阻。舌红苔黄，乃因气郁化热，痰热交蒸。脉弦滑，为痰气郁结的征象。

(2) 治法：宜理气解郁，化痰开窍。

(3) 主要方剂：

① 温胆汤加减：

1) 心虚惊悸，加党参 15 克，炒枣仁 15 克，远志 10 克，柏子仁 10 克。

2) 烦躁不安，加黄连 6 克，麦冬 10 克。

3) 口干舌燥，加麦冬 10 克，五味子 9 克。

4) 小便短赤，加木通 3 克。

5) 大便秘结，加大黄 10 克。

6) 痰多，加胆星 6 克。

- 7) 痰血迷心，神志恍惚，加郁金 6 克。
- 8) 气郁，加木香 6 克，香附 10 克。
- 9) 血淤，加桃仁 3 克，赤芍 10 克。
- 10) 开窍泄热，加石菖蒲 9 克，远志 10 克。

② 清心汤加减：

- 1) 自利，去芒硝、大黄。
- 2) 自汗，去麻黄。
- 3) 痰多，加半夏 10 克，茯苓 12 克。
- 4) 眩晕，加天麻 6 克，菊花 6 克。
- 5) 血淤，加红花 3 克，桃仁 3 克，丹皮 10 克，生地 15 克。
- 6) 气郁，加陈皮 10 克，枳壳 9 克，木香 9 克，香附 10 克。
- 7) 肝郁，加柴胡 10 克。

③ 清心温胆汤(亦名清心抑气汤)。

其他如七气汤、逍遥散、白金丸等，均可随症选用。

2. 癲证：如表现为神志迷茫，不食不语，双目无神，呆若木鸡，舌红苔厚，脉多浮滑者。

(1) 病因：多为肝郁气结，风痰壅滞，阻塞清窍。

(2) 治法：宜驱风化痰，散郁开窍。

(3) 主要方剂：上池饮加减，驱风化痰汤。

3. 癲证：有思慕异性，如醉如痴，言语零乱，伴有失眠及行为障碍，舌红，苔黄薄或厚，脉弦者。

(1) 病因：为思虑太过，肾水不济，以致肝木枯槁，内火炽盛之故。

(2) 治法：宜平肝解郁，化淤祛邪。

(3) 主要方剂：癲狂梦醒汤加减。

4. 若临床上以不同程度的精神衰退为特点：表现有情

感淡漠，精神恍惚，形容枯槁，反应迟钝，生活懒散，智力减退，舌润苔薄，脉沉细无力者，此为癫呆证。

(1) 病因：本证多因癫病失治，日久恶化而成。部分病例则因虚狂虚痫衍生而来，少数病例则可能与先天因素有一定关系。不论何种原因，其共同特点为真阳亏损，气血两虚。故本症皆为虚证。

(2) 治法：宜补益气血，扶肾壮阳。

(3) 主要方剂：有滋阴汤、归脾汤、逐呆丹、紫河车丸等，可随证选用。

(四) 典型病例

〔病例 1〕

张××，男，28岁，干部。因在工作中受到批评，思想不通，逐渐出现精神抑郁，表情淡漠，语无伦次，时悲时喜，秽洁不知，饮食少进。半年后始来我院治疗。

诊断：患者有时痴笑，营养中等，二便如常，舌苔白腻，脉象弦滑，诊断为癫证。此由七情所伤，肝气抑郁，脾气不升，气郁痰结，阻蔽神明所致。治宜理气解郁，化痰开窍，拟用加味千金温胆汤。

方药：半夏9克，茯苓12克，陈皮9克，枳实9克，竹茹9克，木香6克，香附9克，郁金6克，远志9克，石菖蒲6克，炙甘草6克，生姜3片。

用上学每天一剂，水煎温服。连服十剂，神志已清，饮食增进，仅偶有失眠多梦。继而将原方去木香、香附、郁金，加炒枣仁12克，茯神9克，麦冬9克，水飞辰砂3克(研末，分两次开水冲)，又服五剂，痊愈出院。

〔病例 2〕

李××，女，26岁，干部。两月以来，夜卧不宁，精神抑郁，十天前突转神志颠倒，言语错乱，面赤易怒，有时骂人，好歌唱，喜冷饮，经治无效，来院就医。

诊断：口气微臭，大便带结，小便赤涩，舌红苔腻，脉浮滑而数。此属风癲，乃七情郁结于内，风热壅滞于外，内外合邪，痰热蒙心所致。治宜疏风热，调气血，表里两解，则郁滞可通，痰热可去。

方药：清心汤，去芒硝，加丹皮、生地、去皮尖桃仁各9克，并重用生石膏30克，滑石28克，大黄12克。

服一剂，当晚睡眠渐安，次日神志比较清楚，连服五剂，痊愈出院。

〔病例 3〕

胡××，女，15岁，学生。在家受了责骂，加之旁人批评，精神抑郁，渐至睡卧不宁，言语错乱，有时唱歌跳舞，有时狂笑。

诊断：面色红赤，大便干结，舌红苔黄，脉象滑数，此属风癲。乃内伤七情，复受外感，痰热交蒸，清窍被阻，治宜疏风清热，兼解痰郁。

方药：用清心汤，去芒硝，加丹皮、香附。

服一剂，当晚睡眠稍安，至半夜仍起床狂言乱跳，哭笑无常，原方连服四剂，狂言妄动基本停止，表情仍忧郁不乐，有时喃喃独语，苔腻脉滑，此风热已解，胸中痰热尚未完全涤除。

复用加味千金温胆汤。即：半夏9克，茯苓12克，陈皮9克，枳实9克，竹茹9克，石菖蒲6克，胆星6克，炒枣

仁9克，麦冬9克，炙甘草6克，生姜3片。

连服五剂，遂告痊愈。

〔病例 4〕

覃××，女，23岁。13岁在初中读书时，用脑过度，体质较差，有一天夜间在路上忽遇一犬从面前跑过，大受惊吓，由此经常心惊胆怯，夜眠不安，逐渐神志恍惚，胡言乱语，久经治疗，总不见效，以致身体日益瘦弱，饮食少思，秽洁不辨，几成痴呆。

诊断：苔腻，脉象沉弱，此病原由七情所伤，痰气郁结，治之失当，致成虚癫。宜养心安神，辅以涤痰解郁。

方药：滋阴汤（即与天王补心丹合十味温胆汤）。

每天一剂，水煎温服。服至十剂，神志语言渐清，原方略予加减，连服二月，食欲增进，身体好转，精神恢复正常。

〔病例 5〕

李××，女，32岁，农民。正值月经期间，触事生怒，突然神志失常，狂言妄动，好歌唱，有时骂人摔物，有时以手捶胸。

诊断：颜面潮红，目赤易怒，少卧不饥，舌苔黄腻，脉象弦急。此证属肝郁血淤所致癫证，治宜舒肝解郁，清热逐淤。

方药：加味逍遥散。

每天一剂，水煎温服，配合使用白金丸，每天上午十时开水吞服9克，如此三天，神志渐清。

继与千金温胆汤加丹皮9克，去皮尖桃仁6克，郁金6克，香附10克，两剂而愈。

〔病例 6〕

刘××，女，49岁，患癫症已两年。经常头晕目眩，神志颠倒，有时自言自语，说话无力，有时胡言乱语，喜笑异常。

诊断：舌苔白腻，脉来濡弱，此属气血两虚挟风痰郁火之症。

方药：当与驱风化痰汤五剂，眩晕减轻，神志亦渐清醒。

次服养血清心汤四剂，再以磁朱丸六两，日服两次，每次9克，开水送下，经四十五日治愈出院。

〔病例 7〕

袁××，男，41岁，工人。一九七三年九月十八日入院，入院前七天，因与爱人争吵，思想郁忧不乐，引起精神异常，疑家里人害他，叫头部发木，心中有个疙瘩向上顶，而以头撞墙，拒食六天，面带怒气。

诊断：舌红苔薄，脉沉无力，诊断为气郁癫证。

方药：当服莱菔子30克（研末），温开水调服，鹅羽探吐稀痰，未大吐。

后服清心汤加木香9克，制香附12克，当日下午二时兼服白金丸9克，下午五时说头不木胀了，心中疙瘩掉下，心里明白了，并吃面条2两。晚七时又服磁朱丸9克，一夜安眠。次日，以上症状消失，早餐吃包子三个，重3两，并转至轻病房开放治疗。共住院四天，痊愈出院，至今未发。

三、狂 证

（一）概述

狂证以狂躁刚暴，多怒不饥，骂詈歌笑，甚至毁物伤人

为特征，它与现代医学中的躁狂证和精神分裂症等所致的精神运动性兴奋症状群有类似之处。表现为兴奋躁动，行为紊乱，不食不眠，日夜吵闹不休，情绪激昂，易冲动，爬墙上屋，还可以有幻视、幻听和夸大妄想等。病者舌质红绛，苔多黄腻，脉象弦大滑数，发狂时舌有芒刺，痰色光亮，面如水肿，大便干结，小便赤黄。

（二）病因和发病机理

《黄帝内经素问·宣明五气篇》中说：“五邪所乱：邪入于阳则狂”，《黄帝内经素问·阴阳类论篇》中说：“二阴二阳皆交至，病在肾，骂詈妄行，癫疾为狂。”《黄帝内经素问·脉要精微论篇》中说：“衣被不敛，言语善恶，不避亲疏者，此神明之乱也。”《黄帝内经素问·生气通天论篇》讲：“阴者，藏精而起亟也；阳者，卫外而为固也。阴不胜其阳，则脉流薄疾，并乃狂。”《难经·第二十难·论阴阳伏匿的脉象》说：“重阳则狂，重阴则癫。”这些，都说明阴阳失调可引起癫狂，而阴阳失调则与七情、六淫有关。祖国医学认为，七情属于内因的范畴，七情可以损伤脏腑，产生多种疾病。精神病的发病机理，主要是由七情内伤所致。

早在《黄帝内经素问·至真要大论篇》中就有“夫百病之生也，皆生于风寒暑湿燥火”的记载，并明确指出了狂与火的密切关系，如“诸燥狂越，皆属于火。”《黄帝内经灵枢·经脉篇》对狂的描述更为详细，它说：“胃足阳明之脉，……病至则恶人与火，闻木声而惕然而惊，心欲动，独闭户塞牖而处。甚则欲上高而歌，弃衣而走。”元代朱震亨的《足本丹溪心法·癫狂三十九》中说：“癫属阴，狂属阳，癫多喜而狂多怒，……

大率多因痰结于心胸间”。明虞搏在《医学正传》中说：“大抵狂为痰火实盛”（《古今图书集成医部全录》卷二百四十五）。又如隋代巢元方等著的《诸病源候论》中提出：“狂病者，由风邪入并于阳所为也。风邪入血，使人阴阳二气，虚实不调，若一实一虚，则令血气相并，气并于阳则为狂发”（《诸病源候论》，人民卫生出版社，一九五五年六月影印本）。由此可见，痰火和风与狂证的发生关系非常密切。

总之，狂证多因大惊大怒，刺激过度，火盛痰壅，神明蔽塞，气塞胸膛，或图谋不遂，忧思郁结，屈抑无所伸，忿怒无所泄，以至肝胆气逆，横暴莫制，乘于心则狂妄颠倒，乘于胃则痰实壅盛，五志之火内燔，熬液成痰，痰迷心窍，血迷心胞，蒙蔽心神，狂证乃作。狂病少卧，少卧则卫独行，阳不行阴，阳气亢极，心火暴炽，阴气暴虚，故令其神昏颠倒，其病虽属于心肝，根蒂则在于胃，胃为多气多血之经，水谷之海，痰火结于胃中不得出，阳盛则狂。至于伤寒太阳阳明的发狂，不属于本证范围，应加以鉴别。

（三）辨证施治

狂证属痰火实盛，病在心肝胃。一般狂属实，癫属虚。方书论癫证有虚实之称，但狂证亦有虚实之别。然而，我院在治疗过程中，狂证只遇到阳狂实证。至于阴证、寒证、虚证比较少见。临证时，应根据发病新久，体质强弱，具体脉证，加以区分，辨证施治。为了便于观察，仍按虚实立论。

1. 新病实证：

（1）病因：病起急骤，先有性情急躁，头痛失眠，两目怒视，面红目赤，突然狂乱无知，自高自是，好歌好舞，弃

衣而走，逾垣上屋，甚至披头散发，大叫大喊，不避水火，伤人毁物，气力逾常，不食不眠，骂詈不避亲疏，喜笑恙怒而狂。舌质红绛，苔多黄腻，脉象弦大滑数。此为心火独盛，阳气有余，神不守舍。或因怒气伤肝，肝火暴涨，鼓动阳明痰热，痰火上扰所致。

(2) 治法：涌吐风痰，清热泻火。

(3) 主要方剂：以莱菔子散、将军汤、泻心汤、抽薪饮、服蜜煎为主方。一般采用七日疗法：第一日服莱菔子散，使其大吐，驱其风痰。第二日至第五日，用将军汤或泻心汤，将肠胃中痰火淤积物排除。第六、第七两日，每日煎服服蜜煎一剂，以养正除邪。凡新病体壮狂甚者，可按此法治疗。

方剂的用量，可根据病人的具体情况适当加减，方中大黄用量适当，去其胃肠积热，可加快疗效。如体弱病轻者，只用大黄 30 克；体壮病重者，也可用大黄 50~60 克。如果热毒还未完全扫尽，有时仍有发狂现象，每天可服大黄 15~30 克，开水泡服，直至痊愈为止。

个别患者不适以上诸方时，可选用下列次方或辅助方以治之。

①若只有火邪而无胀闭热结者，可清其火，宜用抽薪饮。心火盛，宜用黄连解毒汤。肺胃热盛，宜用白虎汤。膈热盛，胸膈如焚，宜用凉膈散。肝胆热盛，宜用龙胆泻肝汤，或当归芦荟丸。

②若三焦邪实，阳明热盛而大便闭结者，宜用大承气汤。兼有血分热结者，宜用当归承气汤。

③若因火致痰者，宜用涤痰汤，或抱龙丸等类药物。顽痰胶结者，宜用礞石滚痰丸。

④发狂奔走，势不可遏，宜用辰砂散以镇之，亦可采用外治法，用醋烟熏鼻。其他痰血迷心，妇女肝郁血淤，所求不遂，情志过激而致狂者，宜用癫狂梦醒汤，血府逐淤汤，或参考癫证用药进行治疗。

2. 久病虚证(火盛伤阴型)：

(1) 病因：狂证日久，其势渐戢，火盛伤阴，心血耗损，阴虚火旺，呵之多能自止，表现兴奋烦躁，且显疲倦之象，多言善惊，形瘦面赤。舌质红，脉细数。

(2) 治法：宜滋阴降火，安神定志。

(3) 主要方剂：一般以二阴煎或服蜜煎为主方。肾水不足，心经有热，水不制火者用二阴煎。肝气不和，正虚邪扰兼有郁结者，用服蜜煎。根据病情也可适当配合定志丸、朱砂安神丸，或磁朱丸一类药物。

(四) 典型病例

〔病例 1〕

张××，男，21岁，农民。因故郁怒积于胸中，彻夜不寐，妄见妄言，继即弃衣裸体，骂詈不避亲疏。病后五日，送院就诊。途中打伤其父眼睛和腰部，护送人将他捆绑于柳树上，竟将柳树连根拔起。

诊断：脉象弦滑，舌苔黄腻，此因郁怒伤肝，肝火挟阳明痰热，上扰神明，以致狂暴莫制。治当大吐大下，以折肝火而除痰热。

方药：首先用瓜蒂散3克，温水调匀，灌服，少顷大吐，吐后狂势渐戢，静卧一晚，次日服将军汤，用大黄90克，连煎两次，分两天服，一日服二次。

服后，泻出肠胃中实热，至第四日，神志渐转清楚，脉象缓和，身软无力，乃改用服蜜煎加味。即：生地 18 克，麦冬 12 克，赤芍 9 克，石菖蒲 9 克，石斛 9 克，知母 6 克，木通 9 克，茯神 9 克，陈皮 9 克，丹皮 9 克，大黄 9 克，石膏 15 克，水煎温服。

服后，病即渐愈，七日后出院，回家生产，迄今二十三年从未复发。

〔病例 2〕

葛××，男，37 岁，工人。一九五〇年即精神失常，妄言妄见，甚则弃衣而走，登高而歌，骂詈不避亲疏，时作时止。延至一九五八年三月十九日始送本院治疗，在夜间十点钟陪伴疏忽，竟爬上两丈高的病房，将椽角打开，坐在屋脊上唱歌，推倒屋顶兽头。只得派数人上去想办法将其缚住放下。

诊断和治疗：因其脉证均显实热痰壅之象，乃灌服瓜蒂散 3 克（瓜蒂焙焦研末），少顷大吐，吐出大量黄白色痰涎。吐后赤身裸体，伏在床上，一夜未醒。

次日用将军汤，服至第五日，不再狂躁，神志渐清，接服蜜煎两剂，至第七日精神完全恢复正常。

出院后，又以礞石滚痰丸 60 克带回家，每天一次，每次 3 克，开水吞下，服药以后，即能照常工作，至今二十三年未发。

〔病例 3〕

彭××，女，22 岁。突起神志恍惚，哭笑无常，言语夸张，行为高大。小便赤涩，大便燥结，心中发烧，口渴喜饮，月经先期。

诊断：目赤，舌尖红，苔黄，脉数，此为内有郁热，宜釜底抽薪，拟以抽薪饮加味。

方药：黄连 6 克，龙胆草 6 克，生石膏 24 克，大黄 21 克。

连服三剂，即愈。

〔病例 4〕

毛××，男，21 岁，学生。突起神志恍惚，行动失常，言语紊乱，兴奋喊叫，撕衣摔物。

诊断：面赤口干，少食不卧，舌红苔黄，脉数有力。此邪热弥漫三焦，非大剂苦寒不能熄其炽火。

方药：当与黄连解毒汤，加大黄 30 克。

服后神志渐渐安静，连服三剂，精神恢复正常，休息七天，痊愈。

〔病例 5〕

钟××，女，28 岁。十天以来，心神恍惚，烦躁不安，胡言乱语，有时高声叫骂，甚至打人。

诊断：面赤唇裂，渴喜冷饮，大便秘，小便黄，苔黄脉数，此因上中二焦热邪壅滞所致。

方药：用凉膈散，生芒硝加重大黄。

服一剂，狂躁稍减，连服五剂，精神恢复正常。

〔病例 6〕

杨××，男，25 岁。先有口苦，失眠及头晕目眩现象，后渐神志不宁，目赤易怒，骂詈叫号，躁扰狂越。

诊断：大便秘结，小便赤涩，此乃肝胆实火为患。

方药：与当归芦荟丸作汤。

服二剂，神志逐渐清楚，继以当归芦荟丸，每天两次，

每次 9 克，早晚开水吞服，十天病痊愈出院。

〔病例 7〕

台××，男，33岁，工人。因婚姻不遂，思虑怫郁患病，于一九七三年一月十五日入院。

诊断：病情表现为乱语不眠，躁动吵闹，打人骂人，撕衣毁物，面黄体瘦，脉沉无力。诊断为狂证。治当舍脉从证。

方药：服用瓜蒂散 3 克，约 20 分钟后，吐出涎痰少许。约过四小时后，又吐出痰涎半痰盂。次日用清心汤加味：拈半夏 12 克，陈皮 12 克，茯苓 12 克，防风 9 克，大黄 9 克，荆芥 9 克，炒栀子 9 克，白芍 12 克，连翘 12 克，甘草 12 克，桔梗 9 克，川芎 9 克，当归 15 克，石膏 30 克，滑石 24 克，薄荷 12 克，黄芩 15 克，土炒白术 9 克，川连 9 克，生姜 3 片。

经服清心汤加味三剂后，病渐至安静。九日后临床症状消失，自知力恢复，并参加病房劳动，协助医务人员护理病人，住院二十八天，痊愈出院。

四、癲狂合并证

本证是一种兼有癲证和狂证某些特点的一种疾病。然其病因、发病机理及临床表现均与癲证、狂证不尽相同，故列专节专门加以介绍。

（一）临床表现

本证的临床症状，表现不一，其基本特点为时癲时狂。癲时患者则精神恍惚，沉默寡言，或喃喃自语，多愁善感，

或反应迟钝，如醉如痴。狂时患者则躁动不安，妄言妄见，或狂歌乱舞，少食不眠，或水火不避，伤人毁物，或神魂颠倒，秽洁不辨。病情时轻时重，时癫时狂，或癫狂并见，形象多端，变化无常。一般来说，癫狂合并证的患者舌红苔黄，脉多弦细或弦滑。

（二）病因和发病机理

本证在临床上虽表现为时癫时狂，或一起病就癫狂并见，但在病理机制上，癫狂之间仍多有关联。癫证失治，郁痰化火，而出现狂证，此时病为由阴出阳。狂证日久，实火渐得宣泄，余邪滞留，痰阻经络，则可转为癫证。此为病从阳转阴。这种疾病的转机，对于指导治疗和预后的判断，均具有重要意义。

（三）辨证施治

本证临床上有重于癫或重于狂以及时癫时狂等三种情况，故在治疗上，必须根据患者的具体情况，具体分析，权衡主次，分别予以不同的处理。

1. 治法：

（1）偏于癫者，原则上按癫证治疗，方以清心汤或清心温胆汤为主。

（2）偏于狂者，原则上按狂证治疗，常以涤痰泄热，舒肝解郁法为主，方以将军汤或风引汤为主。

（3）癫狂并见者，多属于阳证、热证，少数兼有虚证。对于阳证、热证，可按实癫或一般狂证治疗；对于虚实相兼者，多采取攻补兼施，很少使用纯补的方剂。

2. 方药:

(1) 痰浊壅盛: 可先服莱菔子散吐之。

(2) 活血化淤: 以癫狂梦醒汤、血府逐淤汤为主。

(3) 病久兼虚: 宜以服蜜煎之类为主。

(4) 气逆癫狂: 用排气饮。

(5) 痰因火动, 气喘, 烦热, 宜用清膈煎, 或先服三黄汤清热泻火, 后用化狂丹补脾以祛痰。

(6) 其它特殊情况, 可参照癫证、狂证所列诸方酌情选用。

我们的临床实践证明, 凡病由阴出阳者易治, 从阳转阴者为难治, 癫狂并见者, 多提示正气未衰, 阴血未耗, 一般说来, 预后也较好。所以, 医者治病, 必须抓住时机, 尽量采取有效措施, 胆大心细, 促使病从阳解, 这对于提高疗效, 解除病人痛苦, 是非常重要的。

(四) 典型病例

〔病例 1〕

宋××, 男, 47 岁。精神失常已十二年之久, 表现失眠, 自言自语, 有时无故骂人、打人, 甚至拿刀杀人, 影响治安。一九五八年八月送我院治疗。

诊断: 查见患者目赤, 舌苔黄, 脉洪大, 诊断为癫狂合并证。

方药: 先以瓜蒂散 3 克灌服, 吐出大量黄痰后, 狂势渐息, 昏睡无力, 接着服将军汤六剂, 精神状况好转。又服礞石滚痰丸二十天, 睡眠渐好, 行为、言语亦渐趋正常, 最后服磁朱丸一个月, 痊愈出院。

〔病例 2〕

赵××，男，46岁。因患痢疾年余，屡治不愈，思想苦闷，渐致神志恍惚，语言错乱，夜不安眠，有时躁扰不宁，甚至毁物伤人。

诊断：脉濡数，舌苔黄腻。此由湿热宿积肠胃，加之情志久郁，化热生火，上扰神明，致成癫狂证。治宜清热燥湿，使宿疾新疴，一举两解，拟用泻心汤。

方药：酒浸大黄15克，酒炒黄连12克，黄芩15克。

每天一剂，上下午各煎服一次。服药四天，癫狂不作，痢疾亦随之而愈。

〔病例 3〕

王××，女，18岁。因所求不遂，患病半年，时发时止，每次月经前五至七天发病，头痛，腹痛，多冷汗，歌哭吵闹，打人毁物。月经来后腹痛消失，精神症状也逐渐好转，待月经后十天左右，完全恢复正常。而不到半月，又再复发。

诊断：入院时正值发病第四日，患者面红目赤，哭泣骂人，大便干结，舌绛，苔黄腻，脉弦滑。为肝气不舒，气滞血淤引起，以血府逐淤汤加大黄治疗。

方药：当归10克，生地20克，桃仁10克，红花6克，枳壳10克，赤芍10克，柴胡10克，甘草10克，川芎10克，牛膝10克，大黄10克，水煎服。

服药后六日诸症缓解，药物作适当减量。

方药：当归10克，生地15克，桃仁10克，红花6克，枳壳10克，赤芍10克，柴胡10克，甘草3克，川芎10克，牛膝10克，水煎服。

经服上药二月，疗效巩固，痊愈出院。

〔病例 4〕

陈××，女，时哭时笑，烦躁不眠，兴奋话多已三月，每隔二十余天一发。

诊断：一九七九年八月，发病后两天就诊，面红目赤，面部发热，话多，乱走，月经四年未来。舌红，苔垢腻，脉弦数，为肝郁气滞，痰阻清窍，宜理气活血化淤，用癫狂梦醒汤加味。

方药：去皮尖桃仁 15 克，柴胡 10 克，制香附 10 克，木通 10 克，赤芍 10 克，半夏 10 克，大腹皮 10 克，青皮 10 克，陈皮 10 克，桑皮 10 克，苏子 12 克，甘草 10 克，大黄 10 克，水煎服。

上方连服五剂，症状改善，对上方作适当减量，观察二日未发，痊愈，出院后连服逍遥散十剂，追踪半年，已参加工作，未复发。

〔病例 5〕

赵××，男，21 岁，农民。一九七八年出现精神异常，一九七九年六月四日来我院就诊。

诊断：精神分裂症(中医诊断为癫狂证)。患者乱语少食，哭笑无时，大便干结，舌淡红，苔白腻，脉弦滑。为思虑过度，痰气郁结。

方药：以党术散补脾胃之气，使得所养，并兼服三黄汤二剂，以泻肠胃之火。先后服党术散十余剂，症状消失，恢复正常，参加生产劳动，至今未发。

〔病例 6〕

杨××，女，27 岁，农民。一九七九年十一月因证明及现金被窃，不能入院，只得门诊及以后函件治疗。

诊断：患者兴奋吵闹，时时乱语吼叫，诊断为精神分裂症(中医诊断为癫狂证)。

方药：服党术散，兼服三黄汤，经治疗二十余天，恢复正常，继而服磁朱丸，一日二次，一次9克，巩固疗效。患者已痊愈，参加生产。

〔病例 7〕

王××，男，23岁，农民。于一九七九年十月初，因公事受屈，被人拷问，以至精神失常，不食乱跑，向人申诉，滔滔不休已十余日。

诊断：反应性精神病(中医诊断为癫狂证)。其舌红苔薄黄，脉弦数，为肝气郁结，风热内生，痰阻心窍。

方药：以清心汤三剂获效。

〔病例 8〕

敖××，男，64岁，农民。于一九七九年十月出现精神异常，夜不眠，疑人害他。

诊断：舌淡红，苔薄，脉浮无力。

方药：当服党术散、三黄汤及礞石滚痰丸，每日上午九时服3克，磁朱丸每日下午六时服6克，服药十五天，症状消失，恢复正常，参加生产。

〔病例 9〕

杨××，女，27岁，农民。日夜不眠，乱语发狂，吵闹不安。

诊断：为癫狂合并证。

方药：服党术散、三黄汤，症状控制。其后继服党术散八剂痊愈。

五、痫 证

(一) 概述

痫证俗称羊痫疯，是一种反复发作的、抽搐性的、短暂神志失常的疾病。典型表现为，发作时，意识丧失，抽搐，感觉障碍，或精神失常。颇似现代医学的癫痫。不过它概括了原发性癫痫和继发性癫痫。早在《黄帝内经》中，本病就概括于癫证之中，如《黄帝内经灵枢·癫狂篇》说：“癫疾始作，而引口啼呼喘悸者。”又说：“癫疾始作先反僵，因而脊痛。”从这里，可以看出《黄帝内经》所述的癫证，既有精神症状，也有抽搐发作，可见对癫痫的认识处于萌芽时期。到了明代，才把癫痫从癫证中划分出来。明代王肯堂在《证治准绳》中提出：“痫病发则昏不知人事，眩仆倒地，不省高下，甚而瘈瘲抽掣，目上视，或口眼喎斜，或口作六畜之声。”（《古今图书集成医部全录》卷二百九十五）王氏还提出痫病频繁发作，可导致“志愚”。明代龚信还提出痫证皆是“痰迷心窍，如癡如愚。”（《古今图书集成医部全录》卷二百九十八）发作时，可导致神智不宁，时发狂躁，多言好怒，痫病不至，目瞪如愚。由此可见，祖国医学不但对癫痫大发作有详细的记载，对癫痫性精神障碍，人格改变，智能障碍，也有一定的认识。

(二) 病因和发病机理

综合有关记载，痫证除有先天因素而得之者外，有因大惊大恐，伤及肝肾，肾虚肝旺；或继发于其它疾病，痰聚经络，致使肝之失调，气逆痰涌，阻塞清窍，故突然发作。其

中痰在发病机理中的作用记载颇多,痰说是痫证的主要病机,所以治痰成为治病的主要大法。

(三) 辨证施治

痫证治疗, 主要根据病情的新久, 发作的频度, 体质的强弱, 或温或清, 或补或泻, 审证施治。在发作期, 以豁痰熄风治标为主, 间隙期以扶脾补肾治本为主, 或标本兼治。兹为便于辨证, 亦以虚实为纲, 分述于下。

1. **新病实证**: 典型的痫证发作, 舌苔白腻或微黄, 脉多见滑象, 治法宜祛风化痰, 行气活血。

(1) 因外感六淫, 风热壅盛, 或内外合邪, 气血怫郁所致新发病证, 宜防风通圣散主之。如加减得当, 每见效甚速。

(2) 七情内伤, 痰热交蒸, 上扰心神者, 宜加味温胆汤。

(3) 气血虚挟风痰郁火, 痰涎壅盛者, 宜驱风化痰汤。

(4) 其它: 如忧郁过度者, 宜宁痛散, 若因惊恐而发者, 用龙齿丹。

2. **久病虚证**: 痫证日久, 精神萎靡, 面色不华, 舌质淡, 苔白, 脉多细滑, 治则宜补养精气, 健脾化痰。

(1) 久病气血两虚, 兼有痰热者, 宜清心温胆汤。

(2) 久病精气大败, 宜紫河车汤或丸。

(3) 其它:

1) 气虚者用黄芪赤风汤, 或补中益气汤。

2) 脾虚者宜用六君子汤。

3) 心脾两虚者用归脾汤。

4) 气血两虚者宜用八珍汤, 或十全大补丸。

5) 肾气虚者用六味地黄汤。

6) 心肾不交者用磁朱丸。

3. 小儿痫证：小儿痫证，多因气血未充，体质未实，或为外邪所伤，或因卒受惊骇，或因哺乳失节，或因其母在妊娠时惊怖所致。总的治法，以祛痰熄风，兼调脾胃，肾虚者宜补肾。常用方为天麻散、定痫丸，同时根据其脾虚或肾虚，按证选方，大补气血。

痫证愈后，应注意调治。为了巩固疗效，可酌情选用十全大补丸、六味地黄丸、紫河车丸，维持服用3~6个月以上，防止复发。

(四) 典型病例

〔病例 1〕

张××，女，5岁。患痫证近一年之久，每发卒然仆地，手足搐搦，嚼舌吐沫，叫如畜声，开始一月一发，或数日一发，近则一日一发，有时一日数发，醒后亦若平人。

诊断：为痫证，脉象浮数，舌质红，苔黄，盖有风热壅滞，痰火迷心所致。治宜先行疏风清热，辅以去痰开窍，拟防风通圣散加减，合牛黄清心丸施治。

方药：防风4.5克，当归3克，黄芩4.5克，荆芥4.5克，川芎3克，酒炒大黄2.4克，麻黄1.5克，白芍3克，滑石9克，薄荷4.5克，白术4.5克，桔梗4.5克，连翘4.5克，栀子3克，甘草4.5克，石膏9克，生姜3片。

上药每天一剂，上下午水煎温服，晚上服牛黄清心丸一粒，如此连服五天，发作次数渐减，接服加味温胆汤六剂，痫证基本控制。

为了巩固疗效，乃与六君子汤加远志、石菖蒲，连服十

多剂，又用紫河车一个，清水洗净，煮烂，分数次吃完，自后饮食倍增，身体发育亦较好，十九年以来尚未复发。

〔病例 2〕

王××，男，19岁。患痫证三年，发则眩晕倒地，昏迷不知人事，四肢搐搦，口吐涎沫，并作畜声。数日一发，一日一发，不定。

诊断：面色不泽，精神衰疲，舌淡，脉象沉弱。此为久病气血俱虚，又有痰火郁结。

方药：首先用清心温胆汤，每天一剂，水煎温服，十剂后病情显著进步。仍以原方适当加减，继续服用外，同时配合晨服磁珠丸10克，晚服紫河车丸12克，并用紫河车一个，清水洗净煮食，如此交替治疗两个多月，痫证基本治愈。

以后，又以六味地黄丸两斤，每天二次，每次10克，饭前开水吞服，迄今数年未发。

六、痫狂合并证

（一）概述

本病主要是痫证，只是在发作过程中兼见狂象。类似现代医学中“癫痫性精神障碍”。特点是始则猝然发作，不省人事，反复发作后渐渐发狂。亦有癫痫频频发作数年后出现发狂，以后狂痫交替出现，遂成痫狂合并证。表现有或久或暂、轻重不一的精神障碍。长期地反复发作，可导致智能衰退。

（二）病因和发病机理

痫证频繁发作，年深日久，出现发狂，以后痫狂交互出

现。或因惊而得惊，神不守舍，舍空而痰聚，痰涎壅塞，迷闷孔窍，发则头旋颠倒，手足搐搦，口眼相引，胸背强直，叫吼吐沫，日久如狂。病因与发病机理与痫证基本相同，或因七情之气郁结，或为六淫之邪所干，皆是痰迷心窍，如痴如愚，只是发狂兼之，较痫证重也。

（三）辨证施治

1. 痫证：反复发作后，有的逐渐胡言乱语，少卧不食，面赤易怒，甚则逾垣上屋，打人骂人，舌红苔黄，脉弦细或弦滑。此证多属虚中夹实，治宜清心豁痰，平肝定志，一般以服蜜煎或风引汤为主方。

（1）如痰火亢盛，宜用生铁落饮以制之。

（2）热痰闭塞，宜服定神至宝丹或牛黄清心丸。

（3）顽痰胶结，宜服礞石滚痰丸。

（4）若证实脉实，甚至痰浊壅盛者，亦可先予三圣散吐之，以后再随证施治。

2. 临床上也有癫痫合并证：先为痫证，频频发作，日久气血损伤，痰浊蒙心，出现癫象，以后痫癫交替出现，舌苔白腻或微黄，脉细无力。此证多系虚证，治宜养心安神，兼化痰浊，一般以清心温胆汤配紫河车丸为主。其它特殊病情，可参考虚痫、虚癫或癫呆证有关诸方，化裁选用。

（四）典型病例

〔病例 1〕

朱××，男，26岁。狂痫已六年，有时猝然倒地，气复则苏，发病数次后又发狂，逾垣上屋，胡言乱语，送院治

疗，体质尚好。

诊断：为癫狂合并证。

方药：当灌服三圣散 3 克，吐后，次日服风引汤。

连服七剂，狂乱已止，痫仍发作，改用定神至宝丹作汤，服八剂，在服药后一小时左右，配合服抱龙丸，每天二次，每次二粒，开水送下，痫亦稍有减轻，发作时痰涎仍壅盛，继于每天上午十时左右，以薄荷煎汤送服礞石滚痰丸 12 克，连服二十天，痫病基本控制。

最后用六君子汤、十全大补丸等类药物，继续调治三月余，病遂痊愈出院，至今二十多年未复发。

〔病例 2〕

李××，男，26 岁。狂躁，精神失常已近三年，经常打人骂人，语无伦次。发狂年余后，又出现突然昏倒，全身抽搐，口吐白沫。每次要昏睡 1~2 小时，醒后狂躁复作。

诊断：为狂痫证。

方药：先用三圣散取吐后，狂躁明显减轻，继服风引汤二十剂，痫仍发作。

又服控涎丹吐痰一次，风引汤、抱龙丸交替服用三十天，狂躁完全停止，精神恢复正常。

七、癡呆证

（一）概述

癡呆证，实际上就是癫狂证发展的后一阶段。由于癡、狂失治，正气虚弱，久病沉痾，行为呆滞，各种机能活动衰退，所以出现痴痴呆呆的现象。也有因虚痫形成的，成为痫

与呆的合并证。

（二）病因和发病机理

明代张景岳在《景岳全书》中说：“凡平素无痰，而或以郁结，或以不遂，或以思虑，或以疑惑，或以惊恐而渐致痴呆。”（《景岳全书》，上海科技出版社一九五九年九月第1版）痴呆证由于病深入肾，以致肾阴虚，则无以化血，肾阳虚则无以化气，气血生化不能进行，则心神失养，证必痴呆。

（三）辨证施治

本证因癫、狂、痫证日久，病程牵延，以后逐渐精神倦怠，目瞪口呆，沉默少语，情感淡漠，生活懒散。舌红少苔，脉细数，或舌淡苔薄，脉沉细无力。

（1）肾为藏精之脏，肾阴虚，则肾水不能上济于心，心阴不足，故心神失养，神志不清，舌红少苔，脉细数。治宜滋阴潜阳，养血安神。方用滋阴汤、天王补心丹。

（2）肾阳虚，命门大衰，人的气化功能失常，故行为呆滞，沉默少语，肢体不温，舌淡苔薄，脉沉细无力。宜滋补肾阳，摄精安神。方用八味丸、养心汤等。

（四）典型病例

〔病例 1〕

姚××，女，36岁。患癫痫病五年，渐转痴呆。形容憔悴，神志恍惚，唧唧咕咕，声颤无力，秽洁不知，目瞪神疲。

诊断：舌质淡，脉沉细，此为久病气血大虚，心失所养，以致神志糊感，状若痴愚。

方药：治宜养心安神，补脾益血。先服养心汤四剂，继以天王补心丹作汤剂，服八剂，饮食稍增，精神渐好。

以后又服紫河车丸 250 克，磁朱丸 180 克，经两个月治疗，精神恢复正常。

〔病例 2〕

杨××，女，31 岁。平时操劳过度，经常失眠，以后逐渐神志恍惚，语言错乱，哭笑无常，久治不效，渐至面黄肌瘦，形容憔悴，神情迟钝，秽洁不知。

诊断：舌苔薄，脉象细数，此乃思虑过度，病久真阴亏损，致成痴呆。治宜养心血，滋肾阴，交通心肾，使阴平阳秘，精神乃治。

方药：即用天王补心丹合六味地黄丸作汤剂，每天一剂，连服三月而痊愈。

八、头痛、眩晕、不寐等症

这里主要介绍的是相当于现代医学的神经官能症的一部分内容。祖国医学虽然没有神经官能症这一诊断名称，但关于神经官能症的描述内容极其详尽，治疗方法也极其丰富。

（一）头痛

1. 概述：头痛是一个常见的症状，可单独出现于多种急、慢性疾病中。在祖国医学中记叙很多，而且内容十分丰富，对其症状描述亦十分细致，治疗方法也很多。我们这里指的头痛，即指已确诊为神经功能性头痛、血管神经性头痛、偏头痛等，不包括“真头痛”。所以在辨证施治上，应该特别谨慎，防止误诊贻治。

2. 病因和发病机理：头为诸阳之会，凡五脏精华之血，六腑清阳之气，皆上会此处，诸阴至颈而还，惟足厥有络，上头至巅顶。病因有外感、内伤之殊，病情有虚实之别。其脉浮紧弦长洪大者，属风热痰火所致，为外感；其脉微弱虚濡者，属气血两虚，为内伤。

(1) 外感头痛：多因起居不慎，感受风寒湿六淫之邪，自表侵袭于经络，上犯巅顶，清阳之气受阻引起。由于风邪外犯，上先受之，故头痛，以风邪所得者多见。若风挟寒邪，寒凝血滞，阻遏经络，血郁入内，而为头痛，若风挟湿邪，弥漫侵淫，则蒙蔽清阳，使清阳不升，浊阴不降，而为头痛。

(2) 内伤头痛：多与肝脾肾三脏有关。因于肝者，一因情志不和，肝失条达，郁而生火，上扰清空，而为头痛。一因木火伤阴，肝火濡养，或肾水不足，水不涵木，二者都能致肝阳上亢，而成头痛。因于肾水不足，或房劳不节，肾精亏耗，脑髓空虚，而致头痛。因于脾者，多系劳伤过度，或病后体虚，饮食不节等，致气血亏损，不能上营脑髓而致头痛。或脾失健运，痰湿滋生，痰浊上扰，阻遏清阳，亦可发生头痛。至于外伤跌仆，以及久病气滞血淤，亦易形成头痛。

3. 辨证施治：头痛应从久、暂、虚、实等方面，进行辨证施治。暂病头痛，多数病势较剧，无有休止，是外邪致病，多属实证，应以祛邪为主。久病头痛，病势大多较缓，时作时止，多因内伤虚证，应以滋阴潜阳。

(1) 功能性头痛：一般为肝阳偏亢，心血不足或肾气虚弱引起。凡头痛，头晕，目眩，耳鸣，口干，便燥，夜寐不安，伴有怔忡，健忘，烦躁，易怒，五心发热。舌质红无苔，

脉细虚数，均属阴虚肝旺。治法宜滋阴敛肝，潜阳安神，用龙牡汤主之。即生地 21 克，麦冬 10 克，五味子 9 克，龙骨 15 克，牡蛎 12 克，炒酸枣仁 15 克，柏子仁 6 克，远志 9 克，龟板 9 克，茯神 10 克，地骨皮 9 克，当归 9 克，水煎服。

如上症兼有梦遗、盗汗、神倦者，多属心肾不交。宜滋补心肾，活血安神，用六味地黄汤加茯神 15 克，炙远志 10 克，酸枣仁 10 克，麦冬 10 克，五味子 10 克。

(2) 偏头痛：是常见的一种慢性头痛，临床特点为周期性发作，头痛多位于一侧，当疼痛剧烈时，可伴有恶心、呕吐、畏光等。发病持续时间长短不一，间隙期完全正常。

我们认为，不管疾病新久，不问左右偏正，均属痰热风湿，气血虚损，宜清上蠲痛饮主之。即：当归 10 克，川芎 10 克，细辛 1.5 克，羌活 9 克，防风 10 克，菊花 6 克，蔓荆子 6 克，米泔浸炒苍术 10 克，麦冬 10 克，独活 9 克，生甘草 6 克，酒炒黄芩 12 克，生姜 5 片，水煎服。

左侧痛甚者，加红花 3 克，柴胡 10 克，生地 15 克，龙胆 3 克。

右侧痛甚者，加干葛 9 克，黄芪 20 克。

额顶痛甚者，加蒿本 10 克，大黄 6 克。

4. 典型病例：

〔病例 1〕

李××，女，31 岁，农民。于一九七六年起患全头痛，时作时止，延至一九七八年十月十日来我院门诊治疗。

诊断：脉浮弦，舌质淡红，无苔，因受寒六淫之邪，自表袭入经络，清阳之气受阻，故满头痛。

方药：当服清上蠲痛饮四剂，另用菊花 30 克，川芎 30

克，每日用 10 克，泡开水喝。十天后而愈。

〔病例 2〕

杨××，女，30 岁。一九七五年因患剧烈头痛，呕吐，烦闷，心神恍惚，四肢厥冷，夜不能安卧。

诊断：舌质淡，苔白腻，脉沉无力，不思饮食，此乃胃虚停痰，为痰厥头痛。

方药：服半夏白术天麻汤四剂，兼服香砂六君丸，每日一次，每次 10 克，痊愈。

（二）眩晕

1. 概述：眩晕一词，早见于《黄帝内经》，指头眩，眩者言其黑，晕者言其转，眼花头旋，轻者闭目即止，重者如坐舟车中，旋转不定，起则欲倒，恶心呕吐，以及耳鸣等症状。祖国医学对其症状的描述，与现代医学中眩晕的概念基本上是一致的。

2. 病因和发病机理：《黄帝内经素问·至真要大论》指出：“诸风掉眩，皆属于肝”。认为眩晕与肝风有关，属上虚。刘河间在《河间六书》则认为由于风火所致。元代朱震亨的《丹溪心法》又有无痰不作眩，偏主于痰之说，而张景岳在《景岳全书》又强调无虚不能作眩，当以治虚为主。本病发生的原因，历代各家学说不一，他们从不同角度阐述其眩晕的病因和发病机理，但在临床实践中如辨证得法，都可收到良好的效果。

3. 辨证施治：根据其发病原因不同，治则也不同，其方法如下：

（1）胃虚停痰所致者：见证头旋眼花，烦闷呕吐，目不

敢开，言语无力，四肢厥冷，夜不安眠，舌质淡红，苔白腻，脉浮滑。宜半夏白术天麻汤。即：酒洗黄柏 9 克，炒干姜 3 克，泽泻 12 克，茯苓 12 克，天麻 9 克，蜜炙黄芪 18 克，党参 18 克，炒苍术 10 克，炒神曲 10 克，白术 12 克，法半夏 9 克，陈皮 9 克，炒麦芽 9 克，生姜 5 片，水煎热服。

(2) 气血两虚所致者：见证头晕眼花，心悸耳鸣，失眠多梦，面色不华，气短自汗，舌淡无苔，脉浮无力。宜服防眩汤，即：党参 12 克，半夏 10 克，土炒白术 10 克，当归 15 克，熟地 15 克，白芍 10 克，川芎 10 克，山茱萸 10 克，天麻 10 克，水煎温服。

(3) 肝阳上亢所致者：见证头晕头痛，易怒耳鸣，失眠多梦，口苦胁痛，舌红，苔黄，脉弦数。宜清晕化痰汤，即：陈皮 10 克，半夏 10 克，白茯苓 10 克，防风 10 克，羌活 9 克，甘草 6 克，枳实 9 克，川芎 9 克，黄芩 10 克，白芷 10 克，细辛 1.5 克，制南星 6 克，生姜 3 片，水煎服。

4. 典型病例：

〔病例〕

李××，男，30 岁，工人。一九七七年患头晕，眼花，旋转不定，不能行走，时作时止，于一九七八年八月，来我院门诊治疗。

诊断：脉浮无力，舌质淡无苔，因肝风肾虚，肝风掉眩。肾虚不能纳气归原，使诸气逆奔而上，故头晕。

方药：服清晕化痰汤四剂，兼服六味地黄丸 120 克，每日服一次，每次服 10 克。兼服补中益气丸，每次 10 克，每天一次。

(三) 不寐

1. 概述：不寐一证，即现代医学中的失眠症，古代文献中亦有称为“不得卧”或“不得眠”者，是以经常不易入寐为特征的一种证候。不寐的证情不一，有的初就寝难以入寐，有的入眠而易醒，醒后再不能入寐，亦有时寐时醒，有的甚至整夜不能入寐等等。

2. 病因和发病机理：《黄帝内经素问·逆调论篇》提出：“胃不和，则卧不安。”《黄帝内经素问·病能论篇》有“肺者藏之盖也，肺气盛则脉大，脉大则不得偃卧。”张仲景提出虚劳虚烦不得眠。张景岳把不寐分为“有邪”和“无邪”二种，寐乎阴，神其主也，神安则寐，神不安则不寐，其所以不安者，一由邪气之扰，一由营气之不足耳，有邪者多实证，无邪皆虚证。“有邪”和“无邪”是指机体内气血、脏腑功能的失调，或痰热的影响而言。总之，引起不寐的原因很多，有的因思虑劳倦，内伤心脾，阳不受阴，心肾不交，阴虚火旺，肝阳扰动，心胆气虚，以及胃中不和等，故能影响心神而致不寐。

3. 辨证施治：根据上述发病机理，一般将不寐分为心脾血亏，阴亏火旺，心胆气虚，胃中不和等四种类型。根据我们的经验，以身体虚弱及老年人阳衰不寐者，痰在胆经而神不守舍，不寐者居多，宜用加味六君子汤，即：党参 21 克，白术 12 克，茯苓 12 克，甘草 10 克，法半夏 10 克，陈皮 10 克，炒酸枣仁 12 克，黄芪 12 克，生姜 3 片，水煎服。

4. 典型病例：

〔病例〕

胡××，女，28岁，农民。一九七七年起彻夜不寐，心

悸害怕。因思虑过多，有伤心脾，心伤阴血暗耗，神不守舍，脾伤则无以生化精微，血不养心，心神不安，故通夜不寐。一九七八年十月来我院门诊治疗。

诊断：脉沉而无力，舌质淡红无苔，为心胆虚弱。

方药：服温胆汤加制南星、炒酸枣仁，八剂而愈。

(四) 惊悸、怔忡

1. **概述：**惊悸、怔忡系指患者自觉心跳不安，并感心前区不适、紧张疑惧的一组症状群。一般多呈阵发性，每因情感波动或劳累而发作。现代医学中的植物神经系统功能紊乱、贫血以及各种心脏病所引起的心律失常，均可出现上述证候。这里以心脏神经官能症为主加以介绍。

2. **病因和发病机理：**悸者，心卒动而不宁也。惊者，心跳而怕惊也。怔忡者，心中躁动不安，惕惕然如人将捕之也。惊悸者，忽然若有惊，惕惕然心中不宁，其动也有时。怔忡者，心中惕惕然，动摇不静，其作也无时。情绪波动均可以导致本症，如大怒伤肝，大恐伤肾，怒则气逆，恐则精却，阴虚于下，火逆于上，亦可动撼心神而发惊悸。亦有痰热内蕴，郁怒之后，胃失和降，痰火上逆，而致心悸。综合上述，惊悸、怔忡主要由于精神因素引起心主不安，或与心血不足，心阳衰弱，水饮内停等有关。

3. **辨证施治：**心悸的辨证，先要掌握心阳虚还是心阴虚，以及挟痰挟淤等夹杂情况，分别主次，进行不同的治疗。

(1) **心神不安：**心悸善惊易恐，多梦失眠，舌脉一般正常。宜用甘麦大枣汤加减。即：甘草 9 克，淮小麦 30 克，红枣 15 个，柏子仁 10 克，夜交藤 15 克，五味子 9 克，水煎温服。

(2) 心血不足：心悸头晕，面色少华，口唇指甲苍白，四肢无力。舌质淡红，脉细。宜归脾汤加减。

(3) 阴虚火旺：心悸不安，心烦少寐，头晕目眩，耳鸣腰酸，舌红苔薄，脉细数或弦数。宜六味地黄汤加减。

(4) 阳气衰弱：心悸不安，胆虚易惊，胸闷气喘，自汗，四肢浮肿，小便不利，舌淡苔白，脉微细或虚数。宜用参麦地黄汤，即：党参 18 克，麦冬 10 克，生地 22 克，山药 12 克，山茱萸 10 克，泽泻 10 克，丹皮 10 克，茯苓 10 克，水煎温服。

4. 典型病例：

〔病例〕

陈××，男，28 岁。做恶梦，害怕有人来捉他，心跳不安，形容消瘦，此人平素心虚胆怯，一九七八年八月来我院门诊治疗。

诊断：脉细弱，舌质淡，苔薄，因久虚劳，伤及肾阴，水不济火，虚火妄动，上扰心神，故惊悸。

方药：当服补心汤五剂，好转，又服温胆汤加炒酸枣仁八剂，服后病愈。

(五) 脏躁

1. 概述：脏躁证是一种常见病，主要表现为发作性精神障碍，酷似现代医学中的“癔病”或称“歇斯底里”。以女性患者较多，发病前多有精神因素或不良暗示，临床见证颇为复杂。

2. 病因和发病机理：脏躁病首见汉代张机著的《金匮要略》。“妇人脏躁，喜悲伤欲哭，象如非己所作，数欠伸”。（《金匮要略讲义》，上海人民出版社，一九七三年二月新 1 版）

若为七情所伤，则心不得静，而神躁扰不宁也。其病因和发病机理，主要是七情内伤，五志生火，动扰五脏所致。

3. 辨证施治：按肺散津而主悲，肺津虚则悲伤欲哭，心藏血而主神，心血虚则神乱，而如有神灵所凭，津血两虚，则不能下润于脏，故先以滋补津液者，化生津血。宜用甘麦大枣汤。即：甘草 9 克，小麦 30 克，红枣 15 枚，右三味水煎五碗煎取三碗，分三次温服。

我院根据滋阴养血，抑制阴盛，而津愈枯，阳衰，而阴愈燥之理。宜用清心温胆汤，效果尚好。即：白芍 10 克，当归 12 克，川芎 10 克，党参 15 克，白术 10 克，茯苓 12 克，甘草 9 克，法半夏 10 克，麦冬 10 克，枳实 10 克，竹茹 9 克，菖蒲 9 克，制香附 10 克，黄连 6 克。

4. 典型病例：

〔病例〕

范××，女，30岁。于一九七七年患病，心烦不安，故痛哭流泪，大吵大闹，有时胡言乱语，蹬足捶胸，时好时发。

诊断：脉沉无力，舌质淡红，无苔。

方药：当服甘麦大枣汤三剂，兼服蜂蜜，每日用33克，开水冲服。好转后，又服清心温胆汤四剂而愈。

祖国医学对神经官能症的治疗，主要是调整肺腑功能紊乱，尤其重要的是医生要向病人作耐心细致的思想工作，引导病人正确对待疾病，端正对疾病的认识，树立战胜疾病的信心，在调动病人主观能动性的基础上，配合物理治疗和药物治疗，这样才能收到更好的效果。

第六章 精神科常用方剂 及应用体会

方剂是运用多味药物，在辨证、立法的基础上，根据药物的性能和相互关系，再通过一定配伍法则所组成的一种处方。

方剂的组成，可分为主治药、辅助药两个部分。而辅助药又可分为相助药、相制药、随症用药、引经调和药四类。方剂组成有它一定的原则，但具体内容却不是固定不变的。临床上必须随着病情的变化，体质的强弱，年龄的大小，还要根据就地取材，适当灵活地加减运用。

精神科的方剂既有一般方剂的共同特点，又有它的特殊性。既要注意药物配伍的变化，药味加减的变化，药味用量的变化，也要坚定不移地对某些药物的用量要求达到一定的分量，对治疗才有作用。这是临床医师必须遵循的一条原则。

一、精神科常用方剂

（一）癲证主方

1. 温胆汤（《备急千金要方》）：

〔主治〕

- （1）胆虚痰热上扰，虚烦不寐，惊悸，口苦呕涎等证。
- （2）气郁生痰化热，痰热交蒸，上扰神明所致的癲、痫

等证。

〔组成〕 法半夏9克，茯苓12克，陈皮9克，麸炒枳实9克，甘草9克，竹茹9克，生姜3片，大枣2枚。

〔用法〕 水煎，饭前温服。

〔加减〕 心虚加党参、炒枣仁；心内燥热加黄连、麦冬；口干舌燥加麦冬、五味子；内热心烦加炒栀子；小便短赤加木通；大便闭结加大黄；狂躁不安加铁落、龙齿；痰多加胆星、天竺黄；痰血迷心加郁金；气郁加木香、香附；血淤加去皮尖桃仁、赤芍；清火解毒加银花、连翘；开窍泄热加石菖蒲、远志。

本方如果适当加减，可以通治一般的癫、狂、痫证，无论虚实，皆有一定效果。《医书汇参辑成》所载的“十味温胆汤”，即本方加党参、熟地、枣仁、远志，主治温胆汤证而挟虚者。《东医宝鉴》所载的“加味温胆汤”，即本方加党参、当归、炒枣仁、白术、黄连、麦冬、辰砂、乌梅、竹沥，主治忧思郁结，惊恐伤心，心不自安，惊悸怔忡，痰迷心窍，神不守舍，烦乱，悲歌叫骂，奔走不识人等证。此外，本书所介绍的治疗虚癫的主方“滋阴汤”，也就是“十味温胆汤”合“天王补心丹”所组成。

2. 清心汤（《证治准绳》）：

〔主治〕

（1）治疮疡肿痛，发热饮冷，脉象沉实，睡卧不宁。

（2）风热壅盛，表里俱实，内外诸邪所伤，气血拂郁所致癫狂等证。

〔组成〕 防风9克，荆芥9克，连翘9克，麻黄3克，薄荷9克，当归9克，川芎9克，白芍9克，土炒白术9克，

炒黑栀子9克，大黄15克（另煎），芒硝6克（冲化），黄芩9克，生石膏18克，桔梗9克，滑石27克，甘草9克，黄连9克，生姜3片。

〔用法〕水煎，温服。大黄另煎或开水泡汁。水煎时先入石膏、滑石，后入荆芥、薄荷、大黄。根据病人体质，适当兑入。

〔加减〕自利去芒硝、大黄；自汗去麻黄；痰嗽加半夏、茯苓；眩晕加钩藤、菊花；血淤加红花、桃仁、丹皮、生地；气郁加陈皮、枳壳、木香、香附；肝郁加柴胡、青皮。方中麻黄冬季用，夏季减去，石膏、滑石冬季减半用。

〔方解〕本方用防风、荆芥、薄荷以解表、冬季用麻黄、使风热肌表郁邪从汗而出。栀子、滑石、石膏清肺泻胃，降火利水以解里，使风热由便泄出。川芎、当归、白芍和血补肝，黄芩去心肺、大小肠诸经之热，肝胆之火。连翘散气聚血凝，甘草、桔梗、白术和中健脾、燥湿以调气。黄连解热毒，宜肝胆，厚肠胃，泻心火。大黄、芒硝破结通幽，但芒硝味咸苦寒，虽无毒，非肠积热、痰实结搏者少用。凡病不由邪热闭结，血枯津涸，以致大便燥结，阴虚精乏，火热骨蒸，火炎于上，而致头痛目昏，口渴耳聋，咽痛，吐血，衄血，咳嗽痰壅，虚极等证，均忌用芒硝。如精神病虚极类实，误服芒硝峻下，恐病由阳转阴，则更难以救治。大黄还能泻实热，荡积滞，调中化食，强健脾胃，推陈致新。此方功能清三焦实热，熄肝风，使气血怫郁调畅，阴阳平衡。如气虚可加党参，血虚加熟地，阴热盛加黄柏，风盛头痛加羌活、独活、天麻、细辛等。故此方治疗癲狂合并证、狂证均有效。如狂盛，另用大黄60克，泡极开水当茶喝。

3. 清心温胆汤(《沈氏尊生书》方):

〔主治〕 癲病或痛病气血两虚而又兼有痰火者。

〔组成〕 法半夏9克, 茯苓12克, 陈皮9克, 麸炒枳实9克, 党参15克, 白术9克, 当归9克, 川芎10克, 白芍9克, 姜制黄连9克, 麦冬9克, 远志9克, 石菖蒲9克, 竹茹9克, 甘草10克, 生姜3片。

〔用法〕 水煎服。

〔方解〕 本方又名清心抑气汤。由于痰因气滞, 气顺则痰降, 故用陈皮利气。痰因湿生, 湿去则痰消, 故用茯苓渗湿。中不和痰涎聚, 用甘草和中补土。用半夏利气燥湿化痰。用石菖蒲开窍通心。用竹茹润燥清化热痰。用枳实下气, 破痰利膈。用党参、甘草补心脾而泻火, 使痰消火降, 经络通利。用香附利三焦, 解六郁, 使气顺郁消。用麦冬治肺伏火而化痰。麦冬凉而能补, 补而不膩, 故能疗心胸结气。用远志利九窍, 益智慧。用白术健脾胃, 利水去湿, 和中调气。用当归补虚和血。用白芍泻肝安脾, 缓中去湿, 养血散淤, 清热利肠。用川芎行气开郁, 入肝理血。用黄连除湿健胃, 泻心脏之火。用生姜调和诸药, 宣通表里, 消散烦闷, 去痰下气。本方攻补兼施, 平肝解郁, 清火化痰, 是治癲证的有效方剂。

4. 驱风化痰汤(《寿世保元》):

〔主治〕 治癲证, 以及五痫眩暈, 时作时止, 痰涎壅盛, 心神昏愠。

〔组成〕 党参16克, 土炒白术12克, 茯苓12克, 甘草10克, 法半夏10克, 陈皮10克, 当归12克, 川芎10克, 酒炒白芍12克, 桔梗10克, 胆南星9克, 远志10克,

瓜蒌仁 9 克，白附子 9 克，白僵蚕 6 克，天麻 10 克，姜汁炒川黄连 6 克，酒炒黄芩 10 克，麸炒枳实 10 克，生姜 5 片。

〔用法〕 水煎服。

〔方解〕 方用党参补五脏之气，泻五脏之火，开心益智。白术健脾胃，利水去湿，和中调气。茯苓利水行痰。甘草调和周身气血，补脏腑，泻诸火。法半夏除湿化痰，和胃健脾。陈皮宣通疏利，行气健胃，去湿化痰。当归补虚养血。川芎顺气行血，补肝散风。白芍泻肝安脾，缓中去水，清热利肠。白僵蚕祛风镇痉。枳实破气行痰。胆南星祛风湿，豁顽痰。瓜蒌仁清胸中痰火。桔梗宣肺祛痰。远志利九窍，强心益智。附子补虚散壅。黄连清火除湿，益肝胆，厚肠胃。黄芩去心肺、大小肠诸经之热，肝胆之火。生姜消食化痰，开胃平逆。

诸风掉眩，皆属于肝。但风药中必兼养血药，以制其燥。养血药须兼搜风药，以宣其滞。医家有治风先治血，血行风自灭的说法。凡精神病眩晕，时作时止，多属气血虚，挟风痰郁火，故此方治癫狂五痫眩晕有效。

5. 滋阴汤(本院经验方)：

〔主治〕 癫病日久，血虚痰热，心悸惊恐，神志恍惚，秽洁不知，语无伦次，精神衰疲等症。

〔组成〕 党参 15 克，玄参 9 克，丹参 9 克，茯苓 9 克，五味子 6~9 克，远志 9 克，桔梗 9 克，当归 9 克，天冬 9 克，去心麦冬 9 克，炒酸枣仁 9 克，柏子仁 9 克，生地 9~15 克，熟地 12 克，半夏 9 克，枳实 9 克，陈皮 9 克，竹茹 9 克，炙甘草 9 克，生姜 3 片，大枣 2 枚，辰砂 1.5 克。

〔用法〕 水煎温服。

〔方解〕 此方即“天王补心丹”合“十味温胆汤”组合而成，是我院治疗虚癫的一个经验方。凡癫、痫日久不愈，血虚痰热为患，可多服久服。

6. “天王补心丹”合“六味地黄丸”方(本院经验方)：

〔主治〕 癫病日久，心血不足，真阴亏损，致心神昏愤，怔忡头晕，自言自语，声颤无力等证。

〔组成〕 党参 15 克，玄参 9 克，丹参 9 克，茯苓 9 克，五味子 6 克，远志 9 克，桔梗 9 克，当归 12 克，天冬 9 克，去心麦冬 9 克，炒枣仁 12 克，柏子仁 9 克，生地 15 克，熟地 12 克，淮山药 12 克，山萸 9 克，丹皮 9 克，泽泻 9 克，辰砂 1.5 克(分二次冲药服)。

〔用法〕 作汤剂，水煎温服。

〔方解〕 本方治癫病日久，偏于阴虚有热者，以“六味丸”滋阴补肾，“补心丹”滋阴清热，养心安神。

7. 养心汤(《证治准绳》)：

〔主治〕 因心脾两虚所致的精神恍惚，魂梦颠倒，心悸易惊，善悲欲哭，肢体困乏，饮食减少，舌色淡，脉细无力等证。

〔组成〕 炙甘草 10 克，黄芪 12 克，党参 12 克，茯苓 12 克，茯神 12 克，川芎 10 克，当归 12 克，柏子仁 9 克，法半夏 10 克，远志 10 克，肉桂 6 克，五味子 9 克，炒酸枣仁 12 克，生姜 10 克，红枣 4 枚。

〔用法〕 水煎服。

〔附注〕 上海中医学院编：《中医内科学讲义》(上海人民出版社，一九六四年一月版)，亦以本方作为治疗虚癫的主方，临

床应用上，就方剂组成和药品性能来看，对心脾两虚的癫证，确是非常适宜的。

（二）狂证主方

8. 瓜蒂散（《伤寒论》）：

〔主治〕 痰火迷心，癫狂而脉证俱实者。

〔组成〕 炒黄甜瓜蒂、赤小豆各等分。

〔用法〕 上两味为末，根据体质强弱及病情轻重，用药0.6~3克，热水调匀，一次灌服，服后约10分钟左右，即当大吐，如不吐，可用鹅羽毛等刺激咽后壁引吐，或令含砂糖一块即吐，吐不止者，用葱白煎汤服之，或用麝香少许，温水调下即止。

〔反应〕

（1）服后多数病例先吐后泻，大便燥结甚者只吐不泻。

（2）吐时眼上翻或双目紧闭，多呈瞑眩之状。

（3）吐后精神萎靡，狂躁即可暂时安宁。

〔禁忌症〕

（1）上焦无实痰者。

（2）久病体虚者。

（3）旧有失血者。

（4）孕妇及产妇。

〔附注〕

（1）狂证大吐泻之后，不要马上给予食物，一般只许喝冷开水、吃凉西瓜等。

（2）吐法只用一次，不可多用。

9. 莱菔子散（经验方）：

方见本章第二节“几种主要药方应用的体会”。

10. 将军汤(《寿世保元》):

〔主治〕 逾垣上屋，骂詈叫号，不避亲疏，甚至弃衣而走，登高而歌，毁物伤人，气力逾常，不食不眠，舌红苔黄，脉象弦大滑数等症为主的实热狂证。

〔组成〕 大黄 120 克。

〔用法〕 大黄酒浸或不浸，连煎两次，每次加水适量，只煎二、三沸，将两次药液共收一起，分 2~3 天服完，每天两次，每次一小饭碗(约 300 毫升)，服后只给稀粥吃，不要给油腻厚味。

〔反应〕 服药后，肚子微痛，泄泻，开始一、二天，每天可泻 2~3 次，泻出黑粪或酱样粪便，以后次数逐渐减少，大便转为淡黄色稀粪，证明热毒已去，其它无特殊反应。

〔禁忌症〕 虚寒患者及孕妇、产妇禁用。

11. 泻心汤，又名“三黄汤”(《金匱要略》):

〔主治〕 心受积热，谵语成狂，逾墙上屋。

〔组成〕 另煎大黄 30 克，黄连 10 克，黄芩 15 克。

〔用法〕 水煎服。

12. 化狂丹，即党术散(经验方):

〔主治〕 补脾胃，和中气，除湿化痰，补肾益精。

〔组成〕 党参 30 克，土炒白术 30 克，茯神 30 克，甘草 9 克，法半夏 9 克，石菖蒲 9 克，制附子 0.3 克，菟丝子 10 克。

〔用法〕 水煎服。

〔方解〕 本方用党参补五脏之气。白术补脾胃，和中气。茯神安神益智。甘草调气血，泻诸火。半夏除湿化痰，开郁

和胃。附子除脾湿，引而补心。菟丝子补肾益精。石菖蒲宣窍泄热，健胃行滞，不必祛痰，痰自化，不必泻火，火自无。

凡癫狂证终年不愈，是热邪乘之，痰气侵之，故用此方而奏奇效。如初得、复发的病人，兼服三黄汤，即大黄12克，川黄连9克，黄芩12克，水煎服。倘大便日解三次者，此药停服，三黄另煎，泡服亦可。

13. 服蛮煎《《景岳全书》》：

〔主治〕 心虚邪热，肝气郁结，精神恍惚，语无伦次，正虚邪亦较轻之证。

〔组成〕 生地12克，麦冬9克，白芍9克，石菖蒲9克，石斛9克，丹皮9克，茯神9克，陈皮9克，木通9克，知母9克。

〔用法〕 水煎温服。

〔加减〕 如痰盛多郁者加贝母6克，痰盛兼火者加胆星9克，阳明火盛，内热狂叫者，加石膏18克，便结胀满多热者，加大黄15克，气虚神困者，加党参12克。

〔附注〕 张氏原注云：此方性味极轻极清，善入心肝二脏，行滞气，开郁结，通神明，养正除邪，大有奇妙。临床上一般用于正虚邪亦衰的患者，或狂证大吐下之后，确有养正祛邪之功。

14. 二阴煎《《景岳全书》》：

〔主治〕 久病虚狂，多言善惊，时而烦躁，形瘦面赤，舌质红，脉细数，以及心经有热，水不制火等证。

〔组成〕 生地12克，麦冬12克，炒枣仁18克，玄参10克，黄连9克，茯苓12克，木通9克，甘草10克，加灯草30根，或竹叶6克亦可。

〔加减〕 如痰盛热甚者，加胆星6克。

（三）痛证主方

15. 防风通圣散（刘河间方）：

〔主治〕 风热壅盛，表里俱实，内外诸邪所伤，气血拂郁所致的痛证。

〔组成〕 防风9克，荆芥9克，连翘9克，麻黄3克，薄荷6克，当归9克，川芎9克，白芍9克，白术9克，栀子9克，大黄6克，黄芩9克，石膏18克，桔梗9克，滑石18克，甘草6克，生姜3片。

〔用法〕 水煎温服。

〔附注〕 本方是我院治疗新发病证的一个常用主方，临床上如果加减得当，有一定的效果。我们在临床实践中，在此方基础上，加羌活6克，独活6克，效果明显。

16. 紫河车丸（《医学心悟》）：

〔主治〕 久病久癩，气血大虚，形容憔悴，不时发作。

〔组成〕 紫河车一个，茯苓30克，茯神30克，远志30克，党参30克，丹参21克。

〔用法〕 紫河车清水洗净焙干，其他各药均烘干，共同研末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每日早晚各9~15克，温开水吞服。

〔附注〕 在癩证主方中，清心温胆汤可加防风10克，羌活9克，独活9克，加味后用来治疗痛证，以及用驱风化痰汤治疗痛证，均在临床上收到了满意的效果。

（四）次方与辅助方

17. 四气汤（《和剂局方》）：

〔主治〕

(1) 七情气郁，痰涎结聚，咯不出，咽不下，胸满喘急，或咳或呕，或攻冲痛等证。

(2) 因痰气郁结所致的癫病，证见神志迷惘，表情呆钝，言语错乱，目瞪不瞬，舌苔白腻者。

〔组成〕 姜汁炒半夏 9 克，茯苓 12 克，姜汁炒厚朴 9 克，紫苏 9 克，生姜 3 片，大枣 2 枚。

〔用法〕 水煎服。

〔附注〕 本方用来治疗癫证，应加胆星、郁金、菖蒲、远志等药，才能奏化痰行气之功。

18. 苏合香丸《《和剂局方》》：

〔主治〕

(1) 中风，中气，猝然昏倒，牙关紧闭，不省人事。

(2) 中恶，客忤，胸腹满痛，或突然昏迷，痰壅气闭。

(3) 霍乱吐利，时疫瘴疟及因痰气郁结而成的癫、狂、痫等证。

〔组成〕 白术、青木香、乌犀角、香附末、朱砂、诃黎勒、白檀香、安息香、沉香、丁香、革拔各 30 克，麝香 2 克，龙脑、苏合香油(入安息香膏内)、乳香各 15 克。

〔用法〕 共为细末，入研药内，用安息香膏并炼白蜜为丸，每称 3 克，用蜡包裹，每服一丸，小儿半丸，生姜汤服下。

19. 温白丸《《证治准绳》》：

〔主治〕 因风痰所致的癫、狂、痫证，以及小儿惊风癫痫。

〔组成〕 天麻 15 克，白僵蚕、白附子、制南星各 30 克，

全蝎 6 克。

〔用法〕 共为末，面糊为丸，如绿豆大，每服 3 克，姜汤服下。

20. 牛黄清心丸(明代万全方：《痘疹心法》)：

〔主治〕

(1) 温邪内陷，热入心包，神昏谵语，身热，烦躁不安，以及小儿惊厥、中风、窍闭等证。

(2) 因热痰所致的癫、狂、痫证。

〔组成〕 牛黄 0.75 克，朱砂 4.5 克，黄连 15 克，黄芩 9 克，郁金 6 克，山梔 9 克。

〔用法〕 共为细末，炼白蜜为丸，每粒按潮重 3 克，蜡壳封固，每服一丸，研碎，开水和服，小儿酌减。

〔附注〕 此方一名“万氏牛黄丸”或“万氏牛黄清心丸”，即市上通常供应的中成药“牛黄清心丸”，若用于癫、狂、痫证，似宜再加入菖蒲、远志、沉香等行气豁痰等药。

21. 清心滚痰丸(《沈氏尊生书》方)：

〔主治〕 火盛痰结所致的癫、狂、痫证。

〔组成〕 大黄 120 克，黄芩 120 克，煅礞石 120 克，犀角、皂角、朱砂各 15 克，沉香 7.5 克，麝香 0.5 克。

〔用法〕 共研细末，水泛为丸，如梧桐子大，朱砂为衣，成人每日两次，每次 3～6 克，开水送下，小儿酌减。

22. 礞石滚痰丸(《丹溪心法》)：

〔主治〕 实热老痰，发为癫狂惊悸，或怔忡昏迷，或哮喘痰稠，或胸脘痞闷，或眩晕痰多，大便秘结，舌苔黄厚而腻，脉滑数有力者。

〔组成〕 青礞石 90 克，沉香 30 克，大黄 240 克，黄芩

240 克。

〔用法〕 礞石同焰硝三合入阳城罐内，赤石脂封护煅过水飞。沉香另研，上药共为细末，水泛为丸，如绿豆大，礞石上衣。每服 3～6 克，每日服一次，温开水送下，年老、小儿酌减。

〔禁忌症〕 虚寒及孕妇忌服。

〔附注〕 礞石滚痰丸是治疗实证癫、狂、痫证的一个最常用的辅助方，其使用率在 44% 以上。根据我院的经验，“清心滚痰丸”和“礞石滚痰丸”都是治疗精神病实证的有效方剂。新病实证宜用“清心滚痰丸”，久病实证则用“礞石滚痰丸”较佳。“礞石滚痰丸”也可用于新病，但必须在用“将军汤”或“泻心汤”去肠胃实火之后，一般于服药二、三日，大便由黑色或黑黄色变为纯黄，神志稍清时，再配服本丸，才特别有效。

23. 控涎丹《三因极一病证方》：

〔主治〕 痰迷心窍，狂言谵语，如有所见。

〔组成〕 去心甘遂 20 克，去皮紫大戟 20 克，微炒白芥子 30 克。

〔用法〕 上药研末，曲糊丸，如梧桐子大，食后临卧，淡姜汤下 5～10 丸。

〔禁忌症〕 孕妇忌服。

24. 三圣散《太平圣惠方》：

〔主治〕 癫、狂、痫证，痰实壅盛，胸膈膈闷，口多痰涎，脉象滑大有力，体形壮实者。

〔组成〕 防风、瓜蒂各 3 克，藜芦 1.5 克。

〔用法〕 各为粗末，每服约 1.5 克，以薑汁三茶盏，先

用两盏煎三、五沸，去蠶汁，次入一盏，煎至三沸，却将原两盏，同一处熬两沸，去渣澄清，徐徐服之，不必尽剂，以吐为度。

〔禁忌症〕 体弱及孕妇忌服，此方病体弱者慎用。

25. 白金丸《《良方》》：

〔主治〕 积忧成郁，痰血迷心所成的癫狂怪证。

〔组成〕 白矾 90 克，郁金 210 克。

〔用法〕 共为末，薄荷糊丸，每服 6 克，温汤送下。

〔附注〕 冯氏锦囊秘录书云：白金丸是济世方，治失心。昔有妇人癫狂数年不愈，后遇至人授此方，初服觉心胸中有物脱去，神气洒然，再服顿苏，此药善去郁痰，凡病得之忧惊，痰裹心窍者最宜。我院于一九六〇年治一患者孟××，男性，年三十，因忧郁得病，心神恍惚，言语错乱，自觉心中有硬块板塞不舒，即用“白金丸”9 克，服后一时许，患者说，心中硬物已经下去了，次日又服 9 克，神志清楚，恐郁痰未有化尽，第三日改服“清心汤”加桃仁、红花，一剂而愈。足见本方对积忧成郁，痰血迷心的癫狂证，有一定的效果。

26. 遂心丹《《济生方》》：

〔主治〕 风痰迷心癫狂及妇人心风血郁。

〔组成〕 甘遂 6 克，辰砂 3 克，猪心一个。

〔用法〕 甘遂为末，从猪心内取三管血和药入猪心内，缚定纸裹，煨熟取末，入辰砂末，分作六丸，每服一丸，将心煎汤调下，大便下恶物为度。

27. 上池饮《《寿世保元》》：

〔主治〕 风癫证。凡是癫证有风的表现，服之有效。或头目昏晕，遍身骨痛，或头痛心中怔忡，痰火炽盛；或半身

不遂，左瘫右痪，气血大虚，脾胃亏损，有痰，有火，有风，有湿，并能治之，以治诸风更为有效。

〔组成〕 党参 12 克，土炒白术 9 克，茯苓 9 克，甘草 9 克，陈皮 9 克，半夏 9 克，胆星 9 克，天麻 9 克，羌活 9 克，防风 9 克，牛膝 9 克，炒枣仁 9 克，乌药 3 克，当归 12 克，川芎 9 克，白芍 12 克，生地 15 克，黄芩 9 克，黄柏 6 克，红花 2.1 克，菖蒲 3 克，竹沥一匙，姜汁 1 匙，柳枝梢 6 克。

〔用法〕 水煎，饭前温服。

28. 三黄汤，即“泻心汤”（《金匱要略》）：

〔主治〕 清热泻火，涤荡肠胃积热。

〔组成〕 大黄 15 克，黄连 6 克，黄芩 10 克。

〔用法〕 水煎服，或作丸药服。

〔附注〕 本方治邪火有余，心受积热，肠胃实热，热盛发癫狂之证，卓有成效。

29. 逍遥散（《和济局方》）：

〔主治〕 肝郁血淤，两胁作痛，寒热往来，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，月经不调，乳房作胀，脉弦而虚者。

〔组成〕 柴胡 9 克，当归 9 克，白芍 9 克，白术 9 克，茯苓 9 克，炙草 4.5 克，生姜 3 片，薄荷 3 克。

〔用法〕 水煎温服。

〔附注〕 本方加生地 24 克，红花 3 克，去皮尖桃仁 10 克，以镇因悲哀忧郁所致之癫狂证。本方加丹皮、栀子，名“丹栀逍遥散”。

30. 加味逍遥散（《寿世保元》）：

〔主治〕 妇人癫疾，歌唱无时，逾垣上屋，乃营血逆于

心包所致。

〔组成〕 当归 12 克，白芍 9 克，白术 9 克，茯苓 9 克，柴胡 9 克，生地 12 克，远志 9 克，去皮尖桃仁 9 克，苏木 9 克，红花 2.4 克，甘草 6 克，煨姜 5 片。

〔用法〕 水煎服。

31. 血府逐瘀汤《《医林改错》》：

〔主治〕 时好时发，面红目赤，歌哭吵闹，或抑郁不遂，舌红，苔白腻或黄腻，脉弦滑，气滞血瘀的癫狂证。

〔组成〕 当归 12 克，生地 15~30 克，桃仁 10~30 克，红花 3~15 克，枳壳 10 克，赤芍 10 克，柴胡 10 克，甘草 10 克，桔梗 10 克，牛膝 10 克。

〔用法〕 水煎服。

〔加减〕 大便干结加大黄 30~60 克，兴奋话多，加黄连 10~15 克，烦躁不安加石膏 30~60 克。

〔附注〕 《医林改错》是明代医学家王清任的代表作，其中血府逐瘀汤在临床各科中应用较为广泛，只要有瘀血证皆可应用，收效甚著。本方实为桃红四物汤加味。桃红四物汤养血活血，柴胡，枳壳疏理气机，桔梗载药上行，牛膝逐瘀引下，甘草调和诸药，共达活血祛瘀，养血理气的功效。此方孕妇忌用。

32. 癫狂梦醒汤《《医林改错》》：

〔主治〕 癫狂哭笑不休，骂詈歌唱，不避亲疏，许多恶态。又治花癫。

〔组成〕 去皮尖桃仁 24 克，柴胡 9 克，香附 10 克，木通 9 克，赤芍 9 克，半夏 9 克，腹皮 9 克，青皮 9 克，陈皮 9 克，桑皮 9 克，苏子 12 克，甘草 15 克。

〔用法〕 水煎服。

〔附注〕 花癲多系青年人因思恋不遂所致。《石室秘录》说：“如人病花癲，妇人忽然癲痛，见男子抱住不肯放，……此肝木枯槁，内火熾盛，脉必弦出寸口，法当用平肝散郁祛邪之味”。用柴胡、当归、麦冬、白芥子各10克，白芍30克，炒栀子、茯神、玄参各9克，甘草、菖蒲各3克，水煎服。对本方作用，有精辟见解。

33. 定志丸（《沈氏尊生书》方）：

〔主治〕 喜乐过其节，情荡而不能收，心肺二脏受伤而成癲证。

〔组成〕 党参15克，白术9克，茯苓9克，茯神9克，菖蒲9克，远志9克，麦冬9克，朱砂9克。

〔用法〕 研为末，以蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣，每天三次，每次12克，温水吞服。

34. 辰砂散（《灵苑》）：

〔主治〕 癲狂或病狂合并证，狂言妄走，精神恍惚，思虑迷乱，乍歌乍哭，饮食失常等证。

〔组成〕 辰砂（光明者）15克，乳香（光莹者）15克，炒枣仁15克。

〔用法〕 上药研末，根据患者酒量，先令恣饮沉醉，但勿令吐，至静室中，以前药作三服，温酒调，作一盏调之令顿饮。如素少饮酒，但以随量取醉，服药讫，便安置床枕令卧。病浅者半日至一日，病深者三两日，令家人潜伺之，如鼻息匀调，切勿唤醒，亦不可惊触使觉，待其自醒，即神魂定矣，万一惊悟，不易复治。

〔附注〕 本方一次顿服，朱砂用量过大，恐有中毒的危

险。我院的用法是，朱砂 30 克，乳香、炒枣仁各 60 克，共研末，分八次服用，十天一次，于上午十时许酒调服，确有显著的安眠镇静作用，往往醒后，病即随之而愈。若遇不肯服药的病人，宜多方诱导，设法使其服下，不可勉强灌服，以免误入气管，发生意外。此方家庭治疗慎用。

35. 生铁落饮(《张氏医通》)：

〔主治〕 暴怒伤肝，肝火暴张，鼓动阳明痰热，上扰神明，以致病发癫狂者。

〔组成〕 天冬 9 克，麦冬 9 克，贝母 9 克，胆星 9 克，橘红 9 克，远志 9 克，菖蒲 9 克，连翘、茯苓、茯神、钩藤、丹参各 9 克，玄参 12 克，辰砂 3 克，生铁落 100 克。

〔用法〕 先将生铁落水煎 3 小时，去渣取水煎药。辰砂则另研细末，水飞，分三次药水冲服。

〔附注〕 根据我院经验，本方治疗单纯实狂，效果不显，生铁落虽重用，亦不见功。

36. 宁志膏(《类证普济本事方》)：

〔主治〕 癫狂心风，因惊恐而得者。

〔组成〕 党参、枣仁各 30 克，辰砂 15 克，乳香 7.5 克。

〔用法〕 上药研为细末，炼蜜为丸，如弹子大，每服一丸，薄荷汤送下。

37. 养血清心汤(《寿世保元》)：

〔主治〕 心虚有火，喜笑不常。

〔组成〕 党参 15 克，当归、枣仁各 12 克，白术、茯苓、川芎、生地、菖蒲、远志、麦冬各 9 克，甘草 6 克。

〔用法〕 水煎服。

38. 天王补心丹(《摄生秘剖》)：

〔主治〕 阴亏血少，虚烦心悸，睡眠不安，精神疲乏，梦遗健忘，不耐思虑，大便干燥，口舌生疮，舌红少苔，脉细而数等证。

〔组成〕 党参、玄参、丹参、茯苓、远志、桔梗各 15 克，当归、天冬、麦冬、枣仁、五味子、柏子仁各 30 克，生地 120 克。

〔用法〕 为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，辰砂 9~15 克，为衣。每次服 9 克，白开水下，空心服。或用桂圆汤下亦佳。

〔禁忌症〕 胡荽，大蒜，萝卜，鱼腥，烧酒。

39. 琥珀养心丹(《证治准绳》)：

〔主治〕 血虚惊悸，夜卧不宁，或怔忡。

〔组成〕 琥珀 6 克，龙齿 30 克，远志 15 克，菖蒲 15 克，茯神 15 克，党参 15 克，炒枣仁 15 克，当归 21 克，生地 21 克，柏子仁 15 克，黄连 9 克，朱砂 9 克，牛黄 3 克。

〔用法〕 共为细末，将牛黄、朱砂、琥珀、龙齿研极细，以猪心血和丸，如黍米大，金箔为衣。每服五十丸，灯草汤送下。

40. 朱砂安神丸(《李东垣方》)：

〔主治〕 心神烦乱，惊悸怔忡，寤寐不安。

〔组成〕 黄连 30 克，朱砂 30 克，生地 18 克，当归 12 克，甘草 12 克。

〔用法〕 共为末，酒泡蒸饼为丸，如麻子大，朱砂为衣。每服三十丸，临卧时，用温开水送服。

41. 六君子汤(《医学正传》)：

〔主治〕 脾胃不健，饮食不思，或胸膈不利，或膨胀呕

吐吞酸，大便不实等。

〔组成〕 党参 15 克，白术 9 克，茯苓 9 克，法半夏 9 克，陈皮 9 克，炙甘草 9 克。

〔用法〕 水煎服。亦可水泛为丸，每日一次，每次 9～10 克，饭前开水吞服。

42. 归脾汤《济生方》：

〔主治〕 思虑过度，劳伤心脾，怔忡健忘，惊悸盗汗，发热体倦，食少不眠，以及妇人脾虚气弱，崩中带下，又治虚癩。

〔组成〕 党参 12 克，白术 9 克，茯神 12 克，炒枣仁 12 克，龙眼肉 9 克，炙黄芪 14 克，当归 12 克，远志 9 克，炙甘草 9 克，广木香 6 克，生姜 3 片，大枣 3 枚。

〔用法〕 水煎服，亦可炼蜜为丸，每日二次，每次 9～10 克，饭前开水冲服。

43. 六味地黄丸《小儿药证直诀》：

〔主治〕 肾阴不足，虚火上升，腰膝软痠，骨热酸痛，头目眩晕，耳鸣耳聋，自汗盗汗，遗精梦泄，消渴淋沥，舌燥喉痛，牙齿动摇等证。又治久病阴虚的癩、狂、痫等证。

〔组成〕 熟地 240 克，茱萸 120 克，怀山药 120 克，泽泻 90 克，茯苓 90 克，丹皮 90 克。

〔用法〕 为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每天两次，每次 9～10 克，空腹开水服下。

〔附注〕 本方加味作汤剂，可治肾虚癩、狂、痫证。我院的经验，喜用六味地黄丸加川贝母 9 克，橘红 9 克，川连 3 克，竹茹 9 克，名为“加味六味地黄汤”。

44. 八味丸，即“肾气丸”《金匱要略》：

〔主治〕 肾阳虚，真阴亏耗，机能退缩的癡呆证。

〔组成〕 熟地 10~20 克，山茱萸 10 克，山药 10 克，泽泻 6 克，茯苓 10 克，丹皮 8 克，肉桂 6~10 克，炮附子 10 克。

〔用法〕 水煎服。

〔附注〕 方用六味地黄汤以补肾阳，附子、肉桂以温肾阳，壮命火，使阳归于阴，肾气则以固藏。临床中加党参健脾益气，加远志、酸枣仁、石菖蒲补心安神。此方阴阳并补，先后相济，阴平阳秘，精神乃治。

45. 大补元煎(《景岳全书》)：

〔主治〕 久病肝肾阴亏，气血大坏，精神失守。

〔组成〕 党参 12 克，当归 12 克，熟地 15 克，山茱萸 9 克，山药 9 克，炒杜仲 9 克，枸杞 9 克，炙甘草 6 克。

〔用法〕 水煎，空腹温服。

46. 磁朱丸(《千金方》)：

〔主治〕 心悸失眠，耳鸣耳聋，视物昏花，亦治癡病证。

〔组成〕 神曲 120 克，磁石 60 克，朱砂 30 克。

〔用法〕 上三味为末，米糊为丸，如梧桐子大，每日二次，每次 6~9 克，饭前米汤吞服。

〔附注〕 本方是治疗久病虚型癡证或病证的一个常用辅助方剂，效果良好。实型癡、狂、病证，则以“礞石滚痰丸”为其常用辅助方。一虚一实，各有专司，如能具体掌握，灵活运用，大能缩短病程，收到满意的效果。

47. 抽薪饮(《景岳全书》)：

〔主治〕 火邪炽盛，面红目赤，狂言乱语，小便赤涩等证。

〔组成〕 黄芩 9 克，石斛 9 克，木通 9 克，梔子 9 克，黄柏 6 克，枳壳 9 克，甘草 9 克，泽泻 9 克。

〔用法〕 水煎，食远温服，内热甚，冷服更佳。

〔加减〕 如热在经络肌肤者，加连翘、天花粉以解之；热在血分大小肠者，加槐花、黄连以清之；热在阳明头面或躁烦便实者，加生石膏以降之；热在下焦小便痛涩者，加龙胆草、车前以利之；热在阴分津液不足者，加麦冬、生地、芍药等药以滋之；热在肠胃实结者，加大黄、芒硝以通之。

48. 黄连解毒汤（《外台秘要》引崔氏方）：

〔主治〕 一切火热，烦躁狂乱，口燥咽干，大热干呕，错语不眠之证。

〔组成〕 黄连 9 克，黄柏 6 克，梔子 9 克，黄芩 9 克。

〔用法〕 水煎，去渣，温服。

〔加减〕 大便实者，加大黄 15 克。

49. 凉膈散（《和剂局方》）：

〔主治〕 上中二焦热邪炽甚，烦躁口渴，面赤唇焦，口舌生疮，胸膈烦热，咽痛吐衄，便秘溲赤，诸风癰疽，胃热发斑发狂，以及小儿急惊等证。

〔组成〕 连翘 9 克，大黄 15 克，芒硝 9 克，梔子 9 克，黄芩、薄荷、竹叶、甘草各 9 克，生蜜 24 克。

〔用法〕 作汤剂，水煎服，生蜜用药水冲。

〔附注〕 本方用治癰狂证，一般减去芒硝，重加大黄。

50. 龙胆泻肝汤（《古今医方集成》）：

〔主治〕 肝经实火或湿热，心神恍惚，胁痛耳聋，口苦目赤，小便淋浊，阴肿，阴痒，阴痛等。

〔组成〕 龙胆草 9 克，黄芩 9 克，梔子 9 克，泽泻、木

通、柴胡、车前子各 9 克，当归、生地各 12 克，甘草 9 克。

〔用法〕 水煎，温服。

51. 当归芦荟丸(《宣明论方》)：

〔主治〕 肝胆实火，头晕目眩，神志不宁，甚则惊悸抽搐，谵语发狂，或胸腹胀痛，大便秘结，小便赤涩等证。

〔组成〕 当归、黄芩各 60 克，大黄、青黛各 30 克，芦荟 30 克，广木香 12 克，麝香 3 克。

〔用法〕 研末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每日二次，每次 9 克，姜汤下，亦可用十分之一的剂量作汤剂，水煎温服。

52. 大承气汤(《伤寒论》)：

〔主治〕 阳明腑证，阳邪入里，胃实不大便，潮热谵语，不恶寒，痞满燥实坚全见，脉沉实有力及伤寒发狂。

〔组成〕 另煎酒浸大黄 12 克，冲服芒硝 9 克，厚朴 12 克，枳实 9 克。

〔用法〕 先煮厚朴、枳实，再加大黄煮二、三沸，倾碗内和芒硝服，得利则止。

〔附注〕 本方借治狂证，大黄可酌情用到 60~120 克，必要时再加黄连 9 克。

53. 当归承气汤(《沈氏尊生书》方)：

〔主治〕 血虚热闭，或肠胃实热而兼有淤结，胡言乱语，逾墙越壁，妇女尤宜。

〔组成〕 当归、大黄各 30 克，芒硝、厚朴、枳实各 10 克。

〔用法〕 先煮厚朴、枳实、当归、甘草，再加大黄煮 2~3 沸，倾入碗内，和芒硝服。

54. 涤痰汤(《证治准绳》方)：

〔主治〕 中风痰迷心窍，舌强不能言，并治癫、狂、痫证的有热痰者。

〔组成〕 半夏、橘红、枳实、胆星、菖蒲、竹茹各 9 克，党参、甘草各 6 克，生姜 3 片，茯苓 12 克。

〔用法〕 水煎，温服。

55. 抱龙丸（《和剂局方》）：

〔主治〕 癫、狂、痫证的有痰热内壅者，并治小儿急惊。

〔组成〕 天竺黄、辰砂各 60 克，水飞雄黄 30 克，麝香 3 克，陈胆星 120 克。

〔用法〕 上药为细末，煮甘草水和丸，如黄豆大，金箔为衣，薄荷汤下，每服二丸，小儿酌减。

56. 醋烟熏法：

〔主治〕 发狂奔走，势不可遏者。

〔组成〕 火盆一个，醋 500 克，姜汁适量。

〔用法〕 置火盆于病人处，将醋倾于炭火上，令其气冲入病人鼻内，又将姜汁喷其头面身体手足各处，稍顷即可暂时安静。

〔附注〕 此法多用于狂甚莫制，医生便于看病而使暂安之计。据《医效秘传》介绍，凡热病发狂，切不可掩盖床帐，需要揭开，候爽气良久，遂用铜镜按在心胸间，俟热稍退即除，若热太甚，燥渴不止，将硝 500 克研细，以水一盆，用青布 3~5 块，浸于硝水中，微拧半干，搭在病人胸膛并心上，频频易之，如得睡出汗乃愈。这些外治法，简而易行，特录于此，以供参考选用。

57. 宁痫散：

〔主治〕 忧郁过度，顽痰恶血，壅寒心包，神明失主，而作痫者。

〔组成〕 川郁金 18 克，广木香 18 克，制香附 18 克，白矾、朱砂各 9 克。

〔用法〕 上药共为细末，每日一次，每次 0.5 克，开水吞服。

58. 龙齿丹（《集验方》）：

〔主治〕 因于惊，神志恍惚集而成痫证，时发时止。

〔组成〕 研龙齿、炒白僵蚕、飞朱砂、研铁粉、石菖蒲、远志、木香、橘红、麻黄、天麻、制南星、党参各 15 克，苏子 30 克，龙脑 1.5 克，全蝎 10.5 克，麝香 0.3 克（另研）。

〔用法〕 上为细末，次入研药和匀，炼蜜为丸，每 30 克作 15 丸，每天二次，每次一丸，空心薄荷汤下。

59. 凌霄花散（《普济方》）：

〔主治〕 新久痫证，尤对气血不调，血中有伏热，血热生风者更良。

〔组成〕 凌霄花。

〔用法〕 上一味为细末，每天一次，每次 1.5 克，空心温酒调服。每服药后，用木梳梳头发，以冷水一大碗在侧，含水口中，水温即换，以碗水尽即住梳，如此连服四十九日，无论受病深浅，皆可获效。

〔附注〕 凌霄花即紫葳，甘酸微寒，入厥阴血分，有宣血清热祛风作用，为我院治疗痫证的一个常用方。实践证明，确有相当疗效，体虚者慎用。

60. 五痫丸（《杨氏方》）：

〔主治〕 无论新久痫证，风痰甚者更宜。

〔组成〕 制白附子 15 克，法半夏、制南星、乌蛇各 1.5 克，全蝎、皂角、白矾各 15 克，蜈蚣 2 条，僵蚕 45 克，朱砂 4.5 克，雄黄 4.5 克，麝香 0.3 克。

〔用法〕 先将皂角打碎，用水半碗浸透，揉汁去渣，同白矾煎干，然后同诸药共研细末，姜汁糊丸，如梧子大，每天一次，每次 1.5 克，空心温开水吞服。

61. 风引汤（《金匱要略》）：

〔主治〕 大人中风牵引，小儿惊风癰疽，并治癫、狂、痫证。

〔组成〕 大黄 15 克，干姜 9 克，龙骨 12 克，桂枝 9 克，煅牡蛎 9 克，寒水石、滑石、赤石脂、紫石英、白石脂各 18 克，炙甘草 6 克。

〔用法〕 水煎温服小半杯。

62. 追风祛痰丸（《沈氏尊生书》方）：

〔主治〕 风痰诸病。

〔组成〕 防风、天麻、僵蚕、白附子、牙皂各 30 克，全蝎、木香、枯白矾各 15 克，制南星 90 克，半夏曲 180 克。

〔用法〕 上药为细末，姜汁糊为丸，如梧子大，朱砂为衣，每天两次，每次 3 克，饭前淡姜汤送下，或薄荷汤下。

〔加减〕 如病人气血虚者，加党参、当归，脾虚加白术，有火者加姜汁、炒黄连各 20 克。

63. 定痫丸（《医学心悟》）：

〔组成〕 天麻 15 克，川贝、胆星、半夏、陈皮、茯神各 12 克，茯苓 15 克，丹参、麦冬、菖蒲、远志各 9 克，全蝎、

僵蚕、琥珀、辰砂各 6 克，竹沥、甘草各 30 克，姜汁 60 克。

〔用法〕 前十五味研末，用竹沥、姜汁、甘草熬膏，和药为丸，如弹子大，辰砂为衣，每服一九。

64. 黄芪赤风汤(《医林改错》):

〔主治〕 虚痲。

〔组成〕 黄芪 60 克，赤芍 6 克，防风 6 克。

〔用法〕 水煎温服。

65. 补中益气汤(《脾胃论》):

〔主治〕 久病气虚痲证。

〔组成〕 黄芪 9 克，党参 15 克，当归 12 克，白术 9 克，柴胡 6 克，橘皮 3.5 克，升麻 3 克，炙甘草 3 克。

〔用法〕 水煎，食前温服。

66. 祛癰汤(《石室秘录》):

〔主治〕 脾胃虚寒，所食水谷不变精微而变痰，痰凝胸膈之间不得化，流于心而成癰痲之证。

〔组成〕 白术 30 克，党参 15 克，白芥子 10 克，法半夏 9 克，肉桂 3 克，炒干姜 6 克，陈皮 9 克，石菖蒲 6 克，甘草 6 克。

〔用法〕 水煎温服。

67. 八珍汤(《六科准绳》方):

〔主治〕 气血两虚的癰痲诸证。

〔组成〕 当归 12 克，川芎 9 克，白芍 9 克，熟地 15 克，党参 15 克，白术 9 克，茯苓 9 克，炙甘草 9 克，生姜 3 片，大枣 3 枚。

〔用法〕 水煎，食前温服。

68. 十全大补汤(《和剂局方》):

〔主治〕 气血虚甚所致的癯病诸证。

〔组成〕 即“八珍汤”再加黄芪9克,肉桂3克。

〔用法〕 食前水煎温服,亦可研末为蜜丸,每天2次,每次9~12克,食前开水吞下。

69. 医病无双丸(《身经通考》):

〔主治〕 诸病证。

〔组成〕 南星、半夏、当归、生地、石膏各30克,天麻、僵蚕、荆芥穗、独活、犀角、茯苓、远志、麦冬、炒枣仁、辰砂、党参、白术、陈皮、黄连各15克,附子、甘草、川芎、黄芩各9克,牛黄、珍珠各3克。

〔用法〕 上药为末,好酒打稀糊为丸,如梧子大,金箔为衣,每天二次,每次3克,食前开水吞服。

70. 定神至宝丹(《寿世保元》):

〔主治〕 诸痛,神志不宁,时发狂躁,多言好怒,面容不泽。

〔组成〕 姜炒生地15克,橘红9克,贝母9克,茯苓9克,黄连6克,远志9克,菖蒲6克,炒枣仁9克,枳实9克,瓜蒌仁9克,天花粉9克,炙甘草6克,生姜3片。

〔用法〕 水煎温服。

71. 白虎汤(《伤寒论》):

〔主治〕 阳明经证,大热大汗,口渴,脉洪大,以及一切中暑烦热,热甚发斑,狂躁大渴等证。

〔组成〕 生石膏30克,知母10克,甘草10克,粳米15克。

〔用法〕 先煮石膏数十沸,再加药、米,米熟汤成,温

服。

72. 天麻散(《幼科大全》)：

〔主治〕 小儿急慢惊风，大人风疾壅盛，半身不遂，言语蹇涩，不省人事。

〔组成〕 法半夏 21 克，天麻、白术、茯苓、炙甘草各 9 克，生姜 6 克。

〔用法〕 上药共入磁罐内，加水一盅，煮干，为细末，每服 3 克，干姜汤调下。

73. 化痰丸：

〔主治〕 风疾痼病。

〔组成〕 生白矾 60 克，细茶叶 30 克。

〔用法〕 上二药共为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，一岁以上者，每日服一次，一次三丸。大人每日一次，每次四十丸，均皆茶汤送下。久服痰自大便中出，可断病根。但因白矾除湿化痰，追涎坠浊。茶叶下气降热，能去人脂，年老体弱者，不可久服。

74. 逐呆丹：

〔主治〕 癫病日久，气虚痰热，神志恍惚，目瞪口呆，秽洁不知，精神倦怠，沉默不语等证。

〔组成〕 党参 15 克，白芥子 10 克，菟丝子 15 克，白术 16 克，茯神 20 克，拈半夏 9 克，附子 0.6 克，白薇 9 克，水飞朱砂 3 克(研末)，先将各药煎汁，调服朱砂末 1.3 克。

〔用法〕 水煎服。

〔附注〕 此方大补心脾，安神除痰，故治癫呆有效。

75. 加味香砂六君子汤：

〔主治〕 精神病，脾胃虚弱，不思饮食，口不知味，胸

腹胀疼痛等症。

〔组成〕 党参 12 克，土炒白术 9 克，茯苓 12 克，甘草 9 克，法半夏 9 克，陈皮 9 克，砂仁 9 克，白豆蔻 9 克，制香附 9 克，炒苍术 9 克，姜汁炒厚朴 9 克，广木香 9 克，姜汁炒黄连 6 克，炒梔子 6 克，山楂 9 克，炒神曲 9 克，生姜 3 片，大枣 2 枚。

〔用法〕 水煎服。

76. 补心丹《《华佗》》：

〔主治〕 因惊失心，或因思虑过多，心气不宁，狂言妄语，叫呼奔走。

〔组成〕 水飞朱砂 3 克，雄黄 3 克（并研），白附子 30 克（为末），后拌匀，以猪心血为丸，如梧桐子大，以朱砂为衣。

〔用法〕 每服二丸，临卧用人参 3 克，菖蒲 3 克，煎汤送下，常服一粒，能安魂魄，补心气，镇神灵。

77. 大和中饮《《沈氏尊生书》》方：

〔主治〕 饮食留滞积聚，癫狂等证。

〔组成〕 陈皮 10 克，枳实 6 克，砂仁 10 克，山楂 10 克，炒麦芽 10 克，厚朴 6 克，泽泻 9 克。

〔用法〕 水一碗半，煎成八分，食远温服。

78. 六安煎：

〔主治〕 痰滞，气逆，癫等证。

〔组成〕 陈皮 10 克，法半夏 10 克，茯苓 10 克，甘草 9 克，去皮尖杏仁 6 克，白芥子 3 克，生姜 10 克。

〔用法〕 水煎食远服。

〔附注〕 本方老弱不用。

79. 宁志化痰汤(清代《沈氏尊生书》方):

〔主治〕 癫狂证, 心虚痰盛之证。

〔组成〕 胆南星 9 克, 制半夏 10 克, 陈皮 10 克, 茯苓 12 克, 天麻 9 克, 党参 24 克, 姜汁炒黄连 6 克, 炒酸枣仁 15 克, 石菖蒲 6 克, 生姜 6 克。

〔用法〕 水煎服, 再服清心养血汤。

80. 清心养血汤:

〔主治〕 心虚癫狂证。

〔组成〕 党参 18 克, 白术 12 克, 茯神 15 克, 甘草 9 克, 远志 10 克, 炒酸枣仁 12 克, 川芎 9 克, 生地黄 15 克, 当归 12 克, 龙眼肉 12 克。

〔用法〕 水二碗, 煎成八分, 空心服。

81. 七福饮:

〔主治〕 凡癫狂气血亏损者, 此能兼治之。

〔组成〕 党参 27 克, 熟地 27 克, 当归 12 克, 去皮尖杏仁 6 克, 土炒白术 10 克, 炙甘草 9 克, 远志 6 克, 生姜 6 克。

〔用法〕 水二碗, 煎成七分, 食远温服。

82. 洗心汤(《河间六书》):

〔主治〕 风壅涎盛, 心经积热, 口苦唇燥, 眼涩多泪, 大便秘结, 小便赤涩。

〔组成〕 白术 10 克, 麻黄和节 6 克, 当归 10 克, 荆芥穗 10 克, 白芍 10 克, 甘草 10 克, 大黄 10 克, 薄荷 10 克, 生姜 9 克。

〔用法〕 水煎, 空心服。

83. 防风黄连汤:

〔主治〕 伤寒, 心风狂妄者。

〔组成〕 黄连 9 克， 大黄 10 克， 防风 10 克， 远志 10 克， 茯神 15 克。

〔用法〕 水煎， 食远服。

84. 排气饮（《沈氏尊生书》方）：

〔主治〕 气逆癫狂等证。

〔组成〕 陈皮 10 克， 藿香 10 克， 枳壳 10 克， 厚朴 10 克， 木香 6 克， 制香附 10 克， 泽泻 12 克， 乌药 6 克。

〔用法〕 水 150 毫升， 煎成 100 毫升， 热服。

85. 清膈煎：

〔主治〕 痰因火动， 气壅， 喘满， 内热烦渴， 癫狂等证。

〔组成〕 陈皮 10 克， 贝母 10 克， 胆星 9 克， 海石 6 克， 白芥子 3 克， 木通 6 克。

〔用法〕 加水 500 毫升， 煎成 350 毫升， 温服。

86. 续命风行汤（《张氏医通》方）：

〔主治〕 中风癫证， 不知人事， 狂言舌肿。

〔组成〕 麻黄 3 克， 川芎 9 克， 石膏 12 克， 党参 12 克， 防风 9 克， 桂心 3 克， 甘草 10 克， 独活 9 克， 防己 9 克， 附子 3 克， 当归 9 克， 去皮尖杏仁 6 克， 生姜 10 克。

〔用法〕 水煎兑酒半杯， 再煎温服。

87. 回癰汤（《验方》）：

〔主治〕 忽然仆卧， 或作六畜声， 口吐痰沫， 手足搐搦， 气复则苏， 因寒而成， 感寒则发。

〔组成〕 党参 18 克， 茯苓 18 克， 山药 15 克， 薏苡仁 12 克， 肉桂 3 克， 白术 30 克， 法半夏 10 克， 制附子 3 克。

〔用法〕 水煎温服。

〔附注〕 在我院门诊治疗，小儿得之居多，因内伤脾胃，外感风寒，结成在胸膈之中，所以遇风寒便发旧痰，今纯用补正之药，不仅祛痰，还能去其病根，若作风痰治之，虽亦奏效，终不能一止而不再发。

88. 河车丸(《证治准绳》):

〔主治〕 久患心风癲，气血两虚之证。

〔用法〕 紫河车(即胞衣)不拘几个，焙极干，研为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每日二次，每次五十丸，空心酒下。

89. 收呆至神汤:

〔主治〕 风痰壅盛，郁抑不舒，癲痫痴呆等证。

〔组成〕 党参 20 克，柴胡 10 克，当归 12 克，白芍 15 克，法半夏 10 克，甘草 9 克，生枣仁 12 克，胆南星 6 克，制附子 1.5 克，石菖蒲 10 克，神曲 6 克，茯苓 20 克，郁金 1.5 克，水 1000 毫升，煎成 500 毫升服。

90. 清上蠲痛饮(《寿世保元》):

〔主治〕 痰热风湿，气血虚损。

〔组成〕 当归 10 克，川芎 10 克，细辛 1.5 克，羌活 9 克，防风 10 克，菊花 6 克，蔓荆子 6 克，米泔浸苍术 10 克，麦冬 10 克，独活 9 克，生甘草 10 克，酒炒黄芩 12 克，生姜 5 片。

91. 半夏白术天麻汤(《李东垣方》):

〔主治〕 胃虚停痰，烦闷呕吐，四肢厥冷，夜不安眠。

〔组成〕 酒炒黄柏 9 克，炒干姜 3 克，泽泻 12 克，茯苓 12 克，天麻 9 克，蜜炙黄芪 18 克，党参 18 克，炒苍术 10 克，炒神曲 10 克，白术 12 克，法半夏 9 克，陈皮 9 克，

炒麦芽9克，生姜5片。水煎服。

92. 防眩汤：

〔主治〕 气血两虚，心悸耳鸣，气短自汗。

〔组成〕 党参12克，半夏10克，土炒白术10克，当归15克，熟地15克，白芍10克，川芎10克，山茱萸10克，天麻10克，陈皮10克。

93. 清晕化痰汤：

〔主治〕 肝阳上亢，头晕头痛，失眠多梦。

〔组成〕 陈皮10克，半夏10克，白茯苓10克，防风10克，羌活9克，甘草10克，枳实9克，川芎10克，黄芩10克，白芷6克，细辛1.5克，制南星6克，生姜3片。

〔用法〕 水煎服。

94. 甘麦大枣汤《金匱要略》：

〔主治〕 心神不安，多梦失眠。

〔组成〕 甘草9克，淮小麦30克，红枣15个，柏子仁10克，夜交藤10克，五味子9克。

95. 参麦地黄汤：

〔主治〕 心悸不安，腰痛自汗。

〔组成〕 党参10克，麦冬10克，生地12克，山药12克，山茱萸10克，泽泻10克，丹皮10克，茯苓10克。

〔用法〕 水煎服。

96. 龙牡汤：

〔主治〕 因能滋阴潜阳，宁心安神，而能治阴虚头痛、惊悸、失眠等症。

〔组成〕 生地20~30克，麦冬10~20克，五味子6~10克，龙骨15克，牡蛎12克，炒酸枣仁15克，柏子仁6~9

克，远志 10 克，龟板 9 克，茯神 10 克，地骨皮 9 克，当归 9 克。

〔用法〕 水煎服。

97. 香砂六君子丸《和剂局方》：

〔主治〕 治气虚痰饮，呕吐痞闷，脾胃不和之证。

〔组成〕 木香 9 克，砂仁 9 克，党参 15~20 克，白术 9 克，茯苓 9 克，陈皮 9 克，半夏 9 克，甘草 3 克。

〔用法〕 水煎服。

98. 朱砂白金丸：

〔主治〕 治癫、狂、痫、痰疾之实证。

〔组成〕 郁金 210 克，明矾 90 克，朱砂 9 克。

〔制法〕 郁金、明矾共研细末，水泛为丸，再加水飞朱砂 9 克为衣，即成此丸。

〔服法〕 每日 1~2 次，每次 6~9 克，温热开水送下。

二、几种主要药方的应用体会

中医治疗精神病的药方很多，疗效各有差异，现将我院临床常用的几种方剂加以说明。

1. 瓜蒂散：治疗痰火迷心引起的实狂证，是必用的处方之一，涌吐效果比“三圣散”、“控涎丹”等都强。方中不配赤小豆，只用瓜蒂一味亦可。其用量可适当掌握，生瓜蒂的效果比熟瓜蒂要好，在临床应用中，涌吐效果提高一倍。使用生瓜蒂散时，用量必须根据病人情况酌减。古代医家用瓜蒂散治狂证经验甚多，《河间六书》云：发狂极甚，便当吐之，以瓜蒂散吐出痰涎宿物，一扫而愈。《续名医类案》云：龚子材治一人，癫狂乱打，走叫上屋，用瓜蒂散吐出臭痰数升，

又以承气汤下之而愈。可惜这一有效方法，后来很少应用，以致某些顽痰痼疾，无法加以克制。推其原因，可能是临床经验不足，唯恐发生意外。根据我院的实践经验，只要是癫狂实证，对药物掌握适当，就有特效，且无虚脱等不良反应。用熟瓜蒂，瓜蒂只能微炒，过炒降低治疗效果。生用，剂量要减轻，以吐为度。阴证虚证，切勿误用，以免造成不良后果。

2. 莱菔子(生萝卜子)：作涌吐剂，可代替瓜蒂、“三圣散”等药。凡邪在上焦，或痰食，或气不通等症，皆可以此吐之。用量大小，根据病情轻重和体质强弱，酌情决定，我们一般用30~50克。将生萝卜子研为极细末，清晨空心温开水调服，服后即时再多喝温开水，若不吐可用鹅翎探吐。如仍不吐，必从大便下行。此方比瓜蒂散等吐剂平稳，且疗效尚好。由于莱菔子含有挥发油，不能用纸包裹贮存，宜用瓷坛贮存，方可保持药性不变。临用时，将药粉倾入碗内，温开水调服。如多服，气动腹胀或吐不止，可用生姜15克煎水解之。莱菔子味辛甘，性平无毒，生能升，熟能降，升则吐风痰，宽利胸膈，下气化痰，又能消食化滞，故用作涌吐剂，治癫狂有效。注意禁与首乌、地黄同食。

我院治狂证、癫狂实证病人，先用生莱菔子末取吐后，再用“清心汤”清三焦实热，熄肝风，泻胃火。虚用化狂丹，补脾胃之气，使心得其所养。

3. 将军汤：本方系我院治疗狂证、阳证的主要方剂，凡属痰火为患，一般先服“莱菔子散”，涌吐后接服此方，用量也可适当增减。体弱狂轻的，只用30克，体壮狂重的，也可用45~60克。服后可根据情况，再酌用“清心汤”或“服奎

煎”。如热毒还未完全扫尽，有时仍偶有发狂现象，每天可用大黄 15 克，开水泡服，直至痊愈为止。

此方的来源，据《中国内科医鉴》说：大黄一物汤，即将军汤，江州民间所卖之狂药，即是此药，此药非多饮不效，故宜多煎，以代茶饮，余常得自江州乡之泽村氏，其后涉猎医籍，不见此说。最后，在邵氏明医指掌订补中，得见一语云：大抵狂病宜于大吐下，而吐下之效，莫如大黄一物汤云云。可知此方原来自民间，因其效果显著，故历代医家多有利用之。如《圣惠方》载：狂者阳明邪热所致，有实无虚也，用大黄 150 克，酒炒微赤为末，以腊雪水五升煎如膏，每服五匙，冷水下，盖取峻快之性，定祸乱以致太平，非此不能。清代洪金鼎说：癡狂谵言有单方，只用四两生大黄，加入八分小牙皂，为末三分下之良。用法虽略有不同，但其主药都是重用大黄，因大黄能荡涤肠胃三焦痰热淤积，具有推陈致新、苦寒健胃等作用。对证选用，有利无弊。

4. 清心汤：本方即防风通圣散加黄连。是我院治疗癡、狂、痫证的一个主方（痫证只用防风通圣散加减，一般不用黄连）。凡是表里邪实，气血怫郁之证，用之效果较好。推其致效的原因，可能正符合于《黄帝内经》关于五郁致病的机理。本方之效，能统治五郁，特别是风热气血诸郁。从本方组成看来，防风、荆芥、麻黄疏风解表，以治木郁。栀子、黄芩、黄连苦寒清热，以治火郁。大黄、芒硝咸苦泻下，以治土郁。薄荷、石膏、连翘、桔梗辛凉宣肺，以治金郁。滑石、甘草淡甘渗利，以治水郁。还有当归、川芎、白芍和血养肝，兼治血郁。白术健脾燥湿，甘草和中缓急。兼气病者，加木香、香附以治气郁。如此用药，风热得解，则表里皆通，气血调

和，则诸郁可解，因郁而致之癫、狂、痫等证，也相应治愈。

根据我院的经验，本方在应用时，大黄可以重用，但一般少用芒硝。原因是，癫、狂、痫证多因痰热淤积郁阻而成。大黄擅于荡涤肠胃，以及三焦痰热淤积，且苦能健胃，寒能泻热，推陈致新。实践证明，大黄不配芒硝，一般不会大泻，连续使用时，病人往往日益清醒，食欲也日益增强，病治愈时，身体已随着康复起来。至于芒硝咸寒泻下，有泻无补，多用久用，容易造成津液损伤，引致食欲不佳，身体日渐削弱，病愈后正气一时难以恢复，除了大便异常闭结，实不得已，才暂时使用芒硝外，一般不用。这不仅在本方使用时应当注意掌握，凡是各类精神病的治疗，都必须加以重视。

运用防风通圣散医治癫、狂、痫证，历代医家多有阐述。明代龚信在《古今医鉴》中说：防风通圣散能治一切癫狂风痰暴发之证。并附有医案一例，说有一女，年十五，因气恼患语言颠倒，欲咬人打物，偷藏东西，时哭时笑，心怕胆小，饮食不知饥饱，身体发热，以防风通圣散加生地黄、牡丹皮二服即安。清代龚廷贤著《寿世保元》中说：狂者，若风热实盛者，宜服防风通圣散加牡丹皮、生地黄、桃仁。《续名医类案》载：龚子材治一妇人发狂，弃衣而走，逾垣上屋，不识亲疏，狂言妄语，人拿不住，诸医束手，龚令家人将冷水乱泼，不计其数，须臾倒仆，脉之大部俱弦数有力，此热极生风也，用防风通圣散加生地黄、黄连、桃仁、红花、丹皮三剂而愈。朱丹溪、张从政等都有用防风通圣散治疗痫病的记载。由此看来，防风通圣散加减治疗精神病，很早以前就积累了一定的临床经验，惜后人未加注意。我院从祖国医学宝库中发掘

使用，并取得了比较满意的效果。

如肠胃积热，痰实结搏，用芒硝6克，甘草12克，姜汁炒黄连9克。如胆虚痰热，加陈皮9克，茯苓9克，法半夏9克，生姜6克，水煎服。方中麻黄冬季用，夏季减去，石膏、滑石冬季减半用。此方大黄、石膏、滑石按病情轻重增减，水煎时，先入石膏、滑石，后入荆芥、薄荷、大黄。

本方中防风、荆芥、薄荷用以解表，冬季用麻黄，使风热肌表郁邪从汗而出。栀子、滑石、石膏清肺泻胃，降火利水以解里，使风热由便泄出。川芎、当归、白芍和血补肝，黄芩去心肺、大小肠诸经之热，肝胆之火，连翘散气聚血凝，甘草、桔梗、白术和中健脾，燥湿以调气。黄连解热毒，宜肝胆，厚肠胃，泻心火。大黄、芒硝破结通幽，但芒硝味咸苦寒，虽无毒，非肠积热，痰实结搏者少用。凡病不由邪热闭结，以及血枯津涸，以致大便燥急，阴虚精乏，大热骨蒸，火炎于上而头痛目昏，口渴耳聋，咽痛吐血，衄血，咳嗽痰壅，虚极等证，均忌用芒硝。如精神病虚极类实，误服芒硝峻下，恐病由阳转阴，则病难以恢复原状。大黄虽破坚通幽，泻实热，荡积滞，能调中化食，强健脾胃，推陈致新，平胃下气，在胃中能助胃液的不足，以促进其消化作用，精神病愈后，即能恢复原状。此方不但清三焦实热，熄肝风，又能使气血怫郁调畅，阴阳平衡。气虚可加党参，血虚加熟地，阴热盛加黄柏，风盛头痛加羌活、独活、天麻、细辛等。故此方治疗癫狂合并证、狂证，均皆有效。如狂盛，另用大黄60克，泡极开水当茶喝。

5. 化狂丹：此方用党参补五脏之气。白术补脾胃，和中气。茯神安神益智。甘草调血气，泻诸火。半夏除湿化痰，

开郁和胃。附子除脾湿，引而补心。菟丝子补肾益精。菖蒲宣窍泄热，健胃行滞。不必祛痰，痰自化，不必泻火，火自无。

凡癫狂证终年不愈，是热邪乘之，痰气浸之。如初得或复发的病人，用化狂丹兼服三黄汤，即大黄9克，川黄连9克，黄芩9克，水煎服。倘大便日解三次者，此药停服。三黄另煎，泡服亦可。

【病例】

何××，女，40岁，失眠半年。忽然神志恍惚，言语错乱，哭笑异常，喊叫害怕，脉弱便秘，舌尖红，苔腻，当服化狂丹兼服三黄汤，七日病愈。

6. 清心温胆汤：痰因气滞，气顺则痰降，故用陈皮利气。痰因湿生，湿去则痰消，故用茯苓渗湿。中不和，痰涎聚，用甘草和中补土；用半夏利气燥湿化痰；用石菖蒲开窍通心；用竹茹润燥清化热痰；用枳实下气，破痰利膈；用党参、甘草补心脾而泻火，使痰消火降，经络通利；用香附利三焦，解六郁，使气顺郁消；用麦冬治肺伏火而化痰；麦冬凉而能补，补而不腻，故能疗心胸结气；用远志利九窍，益智慧；用白术健脾胃，利水去湿，和中调气；用当归补虚和血；用白芍泻肝安脾，缓中去湿，养血散瘀，清热利肠；用川芎行气开郁，入肝理血；用黄连除湿健胃，泻心脏之火；用生姜调和诸药，宣通表里，消散烦闷，去痰下气。

7. 驱风化痰汤：方用党参补五脏之气，泻五脏之火，开心益智。白术健脾胃，利水去湿，和中调气。茯苓利水行痰。甘草调和周身气血，补脏腑，泻诸火。法半夏除湿化痰，和胃健脾胃。陈皮宣通疏利，行气健胃，去湿化痰。当归补血清血。川

芍顺气行血，补肝散风。白芍泻肝安脾，缓中去水，清热利肠。白僵蚕祛风镇痉。瓜蒌仁清胸中痰火。胆南星祛风湿，豁顽痰。桔梗宣肺祛痰。远志利九窍，强心益智。附子补虚散壅。黄连清火除湿，益肝胆，厚肠胃。黄芩去心肺、大小肠诸经之热，肝胆之火。生姜消食化痰，开胃平逆。

诸风掉眩，皆属于肝。但风药中必须兼备养血药，以制其燥。养血药必须兼搜风药，以宣其滞。医书云：治风先治血，血行风自灭。凡精神病，有眩晕，时作时止，多属气血虚，并挟风痰郁火，故治癫狂五痫眩晕有效。

妇人经来时，心神昏愤，狂言乱语，因逆血攻心，不知人事。先用麝香 0.03 克，水飞辰砂 1.5 克，远志 9 克，甘草 9 克，柴胡、桔梗、茯神各 12 克，广木香 9 克，党参 9 克，水煎不拘时服。神志清楚后，续服茯苓丸，茯苓、茯神各 60 克，去骨远志 45 克，朱砂 21 克，猪心二个，取心内血，研为细末，稀粥为丸，如梧桐子大，每服 30 丸，用金银花汤送下。本方孕妇忌服。

8. 紫河车丸：本方是治疗久痫和癫呆证的一个常用方。根据我院的经验，只将紫河车洗净煮食（可以加食盐、酱油或同猪肉煮吃），效果也较好。尤其是痫证，单靠其它药物，很难收效。如果一面用药，一面吃紫河车，每月 2~3 个，则愈后很少复发。

紫河车治疗癫痫证，前人早有成熟经验，明代龚信说：紫河车不拘几个，焙极干研末，炼蜜为丸，如梧子大，每服 70 丸，空心酒下，治久患心风癫、气血两虚之证。明末清初，冯楚瞻说：久患癫痫，紫河车洗净，砂罐煮烂，入盐少许与服。清代陈修园更将其药理作用，作了初步解释，他说：癫痫多由

母腹中受惊，积久失调，一触而发，遂成此证，此先天受病，故用河车丸以人乳送下，取同气相求之义。

紫河车治疗癫痫的疗效，前人还有具体的观察和记载，兹录数例，以供参考。

(1) 吴茱山治一女子，瘦弱性急，思虑过度，耗伤心血，遂得失志癫疾，或哭或笑，或裸体而走，或闭户而多言，父母忧疑，诸疗无效。吴诊其脉，浮而濡，思虑过伤，神不守舍也。用紫河车两具，漂洗如法，煮烂如猪肚，切片任意啖之，二次即愈（《名医类案》）。

(2) 薛氏治一小儿患癫痫证，吐痰困倦，半晌而苏，诸药不效，年至十三而频发，用肥厚紫河车生研烂，加入人参、当归末，捣丸如梧桐子大，每服三、五十丸，日进三、五服，人乳化下，一月渐愈，又佐以八珍汤痊愈。又一儿七岁发惊痫，今其恣饮人乳，后发渐疏而轻，至十四岁复发，用乳不效，亦用紫河车数具而愈。常用加减八味丸而安，后至二十三岁复发，而手足厥冷，仍用前法，佐以八味丸、十全大补丸而愈（《景岳全书》）。

第七章 电针疗法在精神科的应用

电针乃从针灸发展而来。针灸学是祖国医学宝库中的一个重要部分。早在公元前二、三世纪，我国现存最早的医学著作《黄帝内经》中，已对针灸的基本理论和临床应用有比较系统的阐述。针灸不仅在国内深受人民群众的喜爱，而且在海外广泛流传，为中国人民和世界人民的保健事业作出了重大贡献。解放以来，在党和政府的关怀下，针灸学和医学领域的其他学科一样，有了很大的发展。新的疗法不断涌现，如运用中医的经络理论结合现代医学的解剖生理而形成的头针，把银针的机械刺激与电的刺激相结合而形成的电针等。由于电针具有设备简单，应用方便，疗效较好，副作用少，费用较低，易于推广等优点，所以在精神科的应用也日趋广泛，成为临床治疗的重要手段之一。

一、常用穴位

1. 定神：

〔部位〕 人中沟下三分之一与三分之二交界处。

〔针法〕 向上斜刺1~1.5寸。

〔功能〕 镇静安神，开窍止痛。

〔主治〕 癫、狂、痫、脏躁等。

〔注意〕 进针方向不可左右偏斜，以防刺破鼻粘膜而致出血。

2. 人中:

〔部位〕 人中沟中上三分之一交点处。

〔针法〕 向上斜刺入 0.5~1 寸。

〔功能〕 镇痛安神，回阳救逆。

〔主治〕 癫、狂、痫、脏躁、昏迷等。

〔注意〕 同定神穴。

3. 印堂:

〔部位〕 两眉之间中点处，正对鼻尖。

〔针法〕 向下或向左右横刺 0.3~0.5 寸。

〔功能〕 疏风活络，镇痉安神。

〔主治〕 头昏、头痛、失眠、眩晕等。

4. 丝竹空:

〔部位〕 眉外侧端凹陷处。如遇眉过长或过短，可取瞳子髎穴直上与眉外侧端或其延长线的交点处。

〔针法〕 直刺 0.2~0.3 寸，或向眉头方向斜刺入 1 寸。

〔功能〕 平肝熄风，明目镇痛。

〔主治〕 幻视、头痛、癫痫等。

5. 瞳子髎:

〔部位〕 目外眦外侧 5 分处。

〔针法〕 直刺 0.2~0.4 寸。

〔功能〕 疏散风热，明目止痛。

〔主治〕 幻视、头痛、口眼歪斜等。

6. 攒竹:

〔部位〕 眉内侧端之凹陷处，直对睛明穴。

〔针法〕 直刺 0.1~0.2 寸，或沿皮向下透睛明，或向丝竹空方向横刺。

〔功能〕 驱风活络，明目止痛。

〔主治〕 视幻觉及一切眼症。

〔注意〕 透睛明时，必须注意轻柔，不可捻转，出针后压迫局部，以防眶内出血。

7. 太阳：

〔部位〕 眉梢与外眼角中间向后一寸凹陷处。

〔针法〕 直刺 2~3 分，斜刺可达 0.5~1 寸。

〔功能〕 疏风散热，清头明目。

〔主治〕 头痛，头晕，可作癫狂证的配穴。

8. 百会：

〔部位〕 头部正中线与两耳连线的交点。

〔针法〕 向前或向后斜刺 0.5~1.5 分。

〔功能〕 清热开窍，健脑宁神，回阳固脱，平肝熄风。

〔主治〕 癫、狂、痫及头痛、头晕、失眠、惊悸、健忘等。

9. 风池：

〔部位〕 脑后，枕骨之下，项部肌肉隆起外缘的凹陷处。

〔针法〕 针尖向对侧眼高方向斜刺 1~2 寸，亦可横刺透对侧风池，可刺 2~3 寸。

〔功能〕 通经活络，调和气血，疏风解热，清头明目，益聪开窍。

〔主治〕 癫、狂、痫及头痛、中风不语等症。

10. 风岩：

〔部位〕 耳垂与哑门穴水平连线中点前 5 分。

〔针法〕 朝鼻尖方向刺入 2~2.5 寸。

〔功能〕 祛风活络，健脑止痛。

〔主治〕 癫、狂、痫、头痛、头昏、脏躁及痴呆等。

11. 哑门：

〔部位〕 颈后正中入发际 5 分凹陷处，与耳垂相平，第一、二颈椎之间。

〔针法〕 针尖向喉结方向刺入 1.5~2 寸。

〔功能〕 通经活络，醒脑开窍。

〔主治〕 癫、狂、痫，头痛项强，舌蹇不能言及痴呆证等。

〔注意〕

(1) 进针时，头应稍低，并应固定好头部。

(2) 进出针动作要轻柔和缓。

(3) 如出现触电样感，表示针尖已深达脊髓，应即停止进针。

(4) 严禁捻转。

12. 风府：

〔部位〕 哑门上 5 分，枕骨粗隆下凹陷处。

〔针法〕 头前屈，直刺 1~1.5 寸。

〔功能〕 驱风活络，醒脑开窍。

〔主治〕 癫狂证，头痛，眩晕，半身不遂，舌强不语等。

〔注意〕 应严格掌握进针深度，不可深刺入颅腔，以免伤及延髓，造成严重后果。余同哑门穴。

13. 医风：

〔部位〕 耳垂后凹陷中。

〔针法〕 直刺或向上成 45° 角，斜刺 1.5~2 寸。

〔功能〕 疏风通络，开窍镇痛。

〔主治〕 听幻觉及耳鸣、耳聋等。

14. 医明：

〔部位〕 医风穴后1寸。

〔针法〕 直刺1~1.5寸。

〔功能〕 镇静安神，止痛明目。

〔主治〕 癫狂证，头痛，眩晕，耳鸣，失眠等。

15. 安眠：

〔部位〕 医风与风池穴连线中点。

〔针法〕 直刺1~1.5寸。

〔功能〕 驱风止痛，镇静安神。

〔主治〕 癫狂证，脏躁，失眠，头痛，眩晕等。

16. 听宫：

〔部位〕 耳屏前方，张口凹陷处。

〔针法〕 直刺1~1.5寸。

〔功能〕 通经活络，开窍益聪。

〔主治〕 癫狂证的听幻觉、耳鸣、耳聋等。

17. 听会：

〔部位〕 耳前方，当耳屏间切迹前方与下颌小头颈后方的凹陷处。

〔针法〕 略张口，稍向上斜刺1~1.5寸。

〔功能〕 疏经活络，开窍益聪。

〔主治〕 癫狂证的听幻觉，耳鸣，耳聋等。

18. 廉泉：

〔部位〕 仰头取穴，喉结上中央凹陷处。

〔针法〕 向上后斜刺1~1.5寸。

〔功能〕 驱风活络，开窍。

〔主治〕 不语，幻味，咽食困难，泣涎，舌强。

19. 迎香：

〔部位〕 在面部，当鼻唇沟的上段，横平鼻翼的凸出处。

〔针法〕 直刺 2~3 分，或向上斜刺 0.5~1 寸。

〔功能〕 散热开窍。

〔主治〕 癫狂证的幻嗅、鼻塞及口眼歪斜。

20. 承泣：

〔部位〕 在面部眼下方，正坐直视时适当瞳孔的直下方的眶下缘处。

〔针法〕 直刺 0.5~1.3 寸。

〔功能〕 疏风活络，开窍明目。

〔主治〕 癫狂证、幻视、头昏眼花、口眼歪斜等。

21. 四白：

〔部位〕 在面部，下眼睑的下方，直视时当瞳孔的直下方，适对上颌骨的眶下孔处。

〔针法〕 直刺 2~3 分，亦可向下关穴方向斜刺 0.5~1 寸。

〔功能〕 疏风活络，舒筋镇痛。

〔主治〕 视幻觉、头痛、目眩、口眼歪斜等。

22. 地仓：

〔部位〕 面部，口角外方约一横指处。

〔针法〕 直刺 2~3 分，或横刺（向颊车方向），可刺 0.5~1.5 寸。

〔功能〕 疏风活络，扶正止痛。

〔主治〕 幻味，失音不语，流涎，口角歪斜等。

23. 头颞：

〔部位〕 太阳穴上1寸稍后，颞动脉前侧，咬牙时颞肌凸起处。

〔针法〕 针尖向耳壳上缘，与头皮成 15° 角，斜刺1.5~2寸，可直透率谷。

〔功能〕 驱风活络，失眠，健忘等。

〔注意〕 要避开血管。如刺破血管引起出血，可行局部压迫止血。

24. 大椎：

〔部位〕 在背部，第七颈椎棘突与第一胸椎棘突之间凹陷中适与肩平。坐位低头取穴。

〔针法〕 稍向上斜刺约2~2.5寸，有落空感，患者出现惊跳动作时，即表示针灸已近达脊髓，即不可再行深刺，如需带电，需将针回抽少许，以免带电后，局部肌肉紧张、收缩而将针继续带入，损伤脊髓。

〔功能〕 解表退热，镇静安神。

〔主治〕 狂证、癲证及头痛、项强、瘫痪等。

〔注意〕

(1) 要用硬性和韧性合适的粗针操作。

(2) 进针要缓，出针要快。

(3) 不得提插和捻转。

(4) 注意进针方向，以免刺入胸膛。

(5) 注意固定体位。

(6) 要严格消毒。

25. 陶道：

- 〔部位〕 背部，第一、二胸椎棘突之间凹陷中。
〔针法〕 同大椎。
〔功能〕 同大椎。
〔主治〕 狂证、癫证、头重、头痛、目眩、脊强等。
〔注意〕 同大椎穴。

26. 无名：

- 〔部位〕 背部，第二、第三胸椎棘突间凹陷中。
〔针法〕 微斜向上刺约 1.5 寸，至针有落空感。
〔功能〕 同大椎。
〔主治〕 癫、狂、痫证。
〔注意〕 同大椎穴。

27. 身柱：

- 〔部位〕 背部，第三、第四胸椎棘突间凹陷处。
〔针法〕 同无名。
〔功能〕 理气降逆，镇静安神。
〔主治〕 癫、狂、痫证，脏躁及胸背痛等症。
〔注意〕 参照大椎穴。

28. 合谷：

- 〔部位〕 手背部，第一掌骨缘的中点处。
〔针法〕 0.5~1 寸。
〔功能〕 镇痛安神，通经活络，疏风解表。
〔主治〕 狂证，头痛，不语，不眠及头面诸症等。
〔注意〕 孕妇应慎用。

29. 神门：

- 〔部位〕 腕关节边侧，掌后横纹头凹陷处。
〔针法〕 直刺 5 分。

〔功能〕 镇静安神，宁心通络。

〔主治〕 癫证，脏躁，惊悸，健忘，失眠等症。

30. 间使：

〔部位〕 腕关节内侧横纹正中上 3 寸。

〔针法〕 直刺 1~1.5 寸。

〔功能〕 宁心安神，通经活络。

〔主治〕 癫狂、脏躁、惊悸等证。

31. 郄门：

〔部位〕 腕关节掌侧横纹正中上 5 寸。

〔针法〕 直刺 1~1.5 寸。

〔功能〕 宁心安神，理气通络。

〔主治〕 脏躁、惊悸、烦躁不安等症。

32. 大陵：

〔部位〕 腕掌关节掌侧横纹中凹陷处，仰掌舒腕取穴。

〔针法〕 直刺 3~5 分。

〔功能〕 宁心安神，开胸和胃。

〔主治〕 癫、狂、痫证，脏躁，惊悸，失眠等症。

33. 劳宫：

〔部位〕 手掌中央第三、第四掌骨之间。

〔针法〕 直刺 3~5 分。

〔功能〕 镇静安神，开窍回阳。

〔主治〕 癫、狂、痫证，脏躁，中风，昏迷等症。

34. 后溪：

〔部位〕 在手只侧缘，第 5 掌骨小头的后下方，轻握拳时，当远侧掌横纹头上方的凹陷处。

〔针法〕 直刺 0.5~1 寸。

〔功能〕 宁心安神，清热利湿。

〔主治〕 癫、狂、痫、脏躁等证。

35. 外关：

〔部位〕 腕关节背侧横纹正中上 2 寸。

〔针法〕 直刺 0.5~1 寸，亦可透内关。

〔功能〕 通经活络，疏风解表。

〔主治〕 癫、狂，脏躁及上肢筋骨疼痛等证。

36. 曲池：

〔部位〕 在肘部桡侧，当屈肘时横纹尽头处。

〔针法〕 直刺 1~3 寸，亦可透少海。

〔功能〕 疏风解表，调和气血。

〔主治〕 癫狂，头昏，头痛，高血压等症。

37. 足三里：

〔部位〕 外膝眼下 3 寸，胫骨前缘外侧一横指处。

〔针法〕 直刺 2~3 寸。

〔功能〕 疏通经络，调和气血，强健脾胃。

〔主治〕 癫、狂、痫，脏躁，失眠，腹痛，头痛眩晕，怔忡，呃逆等症。

38. 丰隆：

〔部位〕 外踝上 8 寸，胫骨前缘与腓骨外侧面的中外三分之一的交点处。

〔针法〕 直刺 2~3 寸。

〔功能〕 安神宁志，清热化湿。

〔主治〕 癫狂，脏躁，失眠，中风等证。

39. 三阴交：

〔部位〕 内踝上 3 寸，胫骨内侧后缘。

〔针法〕 直刺 2~3 寸,亦可透悬钟。

〔功能〕 通经活络,调和气血,补脾健胃。

〔主治〕 脏躁,癫狂,失眠及月经不调等症。

40 太冲:

〔部位〕 足背部,第一跖骨间隙的中点处。

〔针法〕 直刺 0.5~1 寸,亦可透涌泉穴。

〔功能〕 舒肝理气,通络活血。

〔主治〕 癫、狂证,头痛,头晕,失眠等症。

41. 涌泉:

〔部位〕 脚掌中心,当第二跖骨间隙的中点凹陷处。

〔针法〕 直刺 1~1.5 寸。

〔功能〕 通关开窍,镇静安神。

〔主治〕 癫证,痫证,脏躁,不语,惊悸,失眠等症。

二、督脉电针疗法

所谓督脉电针疗法,是以主穴位于督脉(实际上是以脊髓为特点),加以电流刺激的一种治疗方法。由于督脉主一身之阳,通过刺激督脉上的穴位,加上适当的电流,以获得强烈的针感反应,从而起到泻阳镇静、安神定志的作用,部分狂证患者,应用本疗法有一定效果,其机理可能与此有关。另一方面,由于本疗法反应较大,如操作不当,可招致严重后果,故对其操作规程、适应症等必须熟练掌握,不可滥用。

〔主穴〕 大椎、陶道、无名、身柱。

〔配穴〕 风池、百会、头颞、定神。

〔方法〕

1. **体位：**以约束带将患者固定于特制治疗椅上，令患者端坐俯首，以利进针。

2. **消毒：**所用钢针必须先经 75% 酒精或 10% 的新洁尔灭溶液浸泡消毒。操作者的手和针刺部位的皮肤，均应用碘酒和酒精严格消毒。

3. **手法：**每次取主穴一个，配穴一至二个（头颞、风池均取双侧）。进针前令患者头尽量前倾，使颈段与上胸椎之间隙尽量增大，以利进针。当按要求进针至一定深度并获得满意针感后，再将针退出少许，以避免通电后，局部肌肉收缩，将针继续带入，损伤脊髓。然后夹上电极（我院使用的为上海生产交流感应电疗机）准备通电。

4. **通电方法：**有两种。

（1）快速冲击法：这种方法，即电量开大至患者有屏气，瞳孔散大，心跳加快，全身肌肉紧张，肢体强直等反应时为度，每次通电时间 2~4 秒，让患者休息片刻后，再酌情行第二次通电。一般每次通电 2~4 次，每日治疗一次，少数患者可酌情每日治疗两次。

（2）长程治疗法：这种方法即将电量开大至患者有明显肌肉收缩等反应，但无屏气及肢体强直等剧烈反应为度。每次通电 3~5 分钟，共两次，中途可让患者休息片刻。每日治疗一次。

由于各人的耐受量不同，加之针刺的深浅及穴位的准确性不一，故开始治疗时电量宜小，然后再酌情增大电量至有满意的针感反应，而患者又能耐受为度。

5. **疗程：**快速冲击法一般以 2~3 次为一个疗程，长程治疗法以连续五次为一疗程，一般若连续两个疗程无效者，

可终止本疗法，改用其它方法治疗。治疗期间若同时配用中药或西药治疗，则可提高疗效。

6. 适应症：主要适用于狂证患者。快速冲击法尤适用于狂证重症，而长程治疗法则适宜于狂证轻症。一般说来，对新病实证效果较好。对阴虚阳亢，有明显破裂性思维等严重思维障碍的患者，效果较差。

7. 禁忌症：对于有癫痫发作史，骨关节病变，心血管疾病，低血压，中度以上脱水以及老年性患者等，均属禁忌之列。

8. 注意事项：

(1) 固定体位，防止躁动。

(2) 高热体弱者，可暂缓治疗。轻度脱水者，待脱水纠正后再行治疗。

(3) 随时观察患者的精神状况和肢体活动情况，如发现虚脱，肢体活动不灵者，应即刻终止治疗。

(4) 如出现晕针、惊厥和下肢轻瘫等反应者，加强护理和对症处理。惊厥和下肢轻瘫是本疗法中较为严重的反应。但只要处理恰当，一般无严重后果。根据我们的体会，惊厥的发生多由于电量过大，通电过长所诱发，尤其多见于原有惊厥病史的患者。在临床上，引起下肢轻瘫的，乃由于进针过深，电量过大而伤及脊髓所致，一般多为双侧，少数为一侧，必须注意防止。轻瘫发生后，需将患者送至病房休息，并加强护理观察。轻者多在半小时至数小时内自行恢复。重者需给以适当治疗，包括新针治疗、按摩、口服中药及维生素 B₁ 等神经营养剂等。临床上，我们曾遇到一例，瘫痪程度较重，症状曾延续半月之久，经适当治疗，最后终于完全恢复。

三、体针电(艾)灸疗法

〔主穴〕 百会、头颞、人中、定神、印堂、风府、哑门等穴。

〔配穴〕 内关、郄门、神门、足三里、三阴交、劳宫、大敦、商白、丰隆、涌泉、大陵等穴。

〔选穴举例〕

(1) 喜笑异常，可刺人中、神门、内关、劳宫、大椎、陶道等穴。

(2) 呆不多言，可刺少商、少冲、涌泉、内关、中脘等穴。

(3) 多悲泣，可刺百会、人中、隐白、大敦、劳宫等穴。

(4) 痫证，可刺商白、涌泉等穴。在发作时，将病人两拇指、两足大趾并齐缚住，艾炷放在二指(趾)之间，上下同时灸，连续数壮，就能苏醒，再灸涌泉穴四、五壮。

〔电针灸方法〕

(1) 每次用主穴一至二个，配穴一至二个。所用穴位必须注意肢体上下左右搭配。

(2) 进针后夹上电极，调节电输出量至局部肌肉有轻度颤动，或至病员最大耐受量为止。

(3) 每次通电 20~30 分钟，每天 1~2 次，十五次为一疗程。

(4) 电疗机可用交流感应电疗机或半导体治疗机。

〔注意事项〕

(1) 开始治疗时应缓慢加大电量。

(2) 对兴奋躁动患者，必须固定体位。

(3) 经常检查治疗机的电输出情况，防止出现烧灼现象，并应防止折针。

(4) 对于躯体状况较差和老年患者，必须慎重处理。

(5) 如在治疗中出现晕针等反应，必须及时对症治疗，并加强护理。

〔附注〕 各类精神病及癔病、神经官能症等，均可使用电针灸治疗。

第八章 关于精神病的 中西医结合治疗

在一九六〇年以前,我院均以中医中药治疗精神病,一九六〇年以后,我们学习了西医治疗精神病的经验,对某些病例在用中药的同时,也合并西药安定剂治疗,这在临床实践中,加强药物的相互作用,缩短疗程,提高疗效,起到了良好的协同作用。

一、狂 证

本病为西医诊断的“躁狂症”、“反应性精神病(急性)”、“精神分裂症(急性发病伴有意识障碍)”等临床以躁狂为特征。

1. 主证: 妄言妄见, 弃衣而走, 登高而歌, 逾垣上屋, 骂詈不避亲疏, 双目怒视, 面红目赤, 不食不眠, 大便秘结, 舌质红, 苔黄腻甚或黑苔, 脉象弦大、滑数。

2. 病因: 由于阳气太盛, 胃与大肠实热, 燥火郁结于中为患。

3. 治则: 涤痰泻火, 辅以盐酸氯丙嗪镇静安神。

4. 方药举例: 患者空腹时, 以萝卜子 30~40 克研末, 经温凉开水调服取吐痰涎, 如不吐, 即以鹅毛羽刺激咽部探吐。这时患者可能安卧或不安卧, 间隔一段时间后再服清心汤, 并兼服将军汤(大黄 30~40 克开水泡服)。同时口服盐

酸氯丙嗪 75~200 毫克，其用量视病情轻重，随时增减或停药。

二、癲 证

本证有如西医诊断“精神分裂症”、“更年期精神病”、“周期性精神病”、“忧郁症”、“反应性妄想症或抑郁症”等精神病。

1. 主证：语言错乱，歌唱无时，时喜时悲，哭笑无常，舌苔薄腻，脉象弦滑。

2. 病因：狂证属阳，癲证属阴。癲证分新久虚实，新病多实证，久病多虚证；肥人多痰，瘦人多火；妇人多肝郁血淤；青年可能有所求不遂，同为七情过激所伤。也有喜、怒、忧、思、悲、恐、惊的不同，必须掌握具体病情，辨证施治。

3. 治则：

(1) 新病实证，以清痰解郁为主，辅以养心安神。

(2) 久病虚证，以养血安神为主，兼以清痰解郁。

总之癲为心血不足，多为所求不遂，宜养血安神兼降痰火。

4. 方药举例：

(1) 清心抑气汤以治气血虚，兼降痰火。此方平肝解郁，清出浊痰，以达到攻补兼施之效。同时兼服朱砂白金丸 10 克，每日一次。合并盐酸氯丙嗪 50~150 毫克，每日三次。

(2) 如脾胃虚寒，运化失常，所食水谷不变精而成痰，浊痰凝滞胸膈之间，不得化流入心而患痰疾。宜治痰补气，用祛癲汤。即：党参 15 克，白芥子 12 克，白术 20 克，肉桂

3克，干姜3克，陈皮9克，甘草10克，石菖蒲10克，法半夏10克，水煎服。此方党参、白术补脾胃，肉桂、干姜祛寒邪，白芥子、法半夏消融顽痰，甘草、石菖蒲引以入心开窍。如妇人追逐异性，为肝木枯槁，相火熾盛，当平肝散郁，用本方去肉桂、干姜加入白芍30克，柴胡9克，炒栀子10克。因柴胡、白芍、栀子皆入肝平木，祛火散邪。临床治疗中确有疗效。

三、癡呆证

本病类似“慢性精神分裂症”、“精神分裂症单纯型”等以精神衰退为特征。

1. 主证：神思恍惚，秽洁不知，情感淡漠，行为退缩呆滞，生活懒散，时呆默不语，时又喃喃自语，或在街头荒野神游，舌淡红，苔白腻，脉沉无力。

2. 病因：癡呆属虚，思虑伤脾，脾液不行，聚液成痰，痰蒙心窍，则津少血亏，心神散漫，神不守舍，遂成癡呆。

3. 治则：补益心脾，开窍祛痰。癡呆痰深，治痰即治呆。

4. 方药举例：逐呆仙丹合并盐酸氯丙嗪100~150毫克，每日三次。逐呆仙丹方，即：党参20克，白芥子10克，菟丝子12克，白术24克，茯神24克，法半夏12克，附子1.5克，白薇9克，朱砂3克(研末)。先将各药煎汤，调朱砂末，约200毫升内服。如患者不服，设法使患者发怒，并将药灌服，患者必大怒，随之慢慢熟睡，让其自醒，醒后恍然大悟，自感头脑轻松。并配服氯丙嗪100~200毫克，至逐渐病愈。

此方妙在大补心脾，以茯神为主，宁心安神，使痰在心消融，附子为无经不入，其余祛痰药物由附子引入各经，将遍身之痰化入膀胱排出。白薇、菟丝子、朱砂镇心安神，各药配合，能奏功效。

四、癫狂证

癫狂合并证，类似“精神分裂症青春型”、“轻躁狂”、“周期性精神病”等证候。

1. 主证：情绪不稳，时闹时静，凶狂易怒，毁物打人，时癫时狂，舌质红，苔黄，脉多弦滑。

2. 病因：

(1) 癫狂证由于心火盛，火盛痰结，扰乱清窍，以致神志恍惚。

(2) 青年患癫狂经久难愈，打人毁物，不认父母妻子，喜水恶食，是由心气虚，热邪乘之，热盛痰结，扰乱神明。

3. 治则：清热泻火，祛痰开窍。但心气虚，火在心，欲泻不可出，痰在心，欲消不易消，惟有补益脾胃，心气自得所养，不必祛痰，痰自化，不必泻火，火自无。如泻火更伤心气，痰涎愈盛，病更难治。

4. 方药举例：

(1) 以清心汤加氯丙嗪。

(2) 心气虚以化狂丹加味，即：党参 30 克，白术 30 克，茯神 40 克，甘草 9 克，石菖蒲 9 克，法半夏 10 克，附子 1 克，陈皮 9 克，水煎服。服后神志逐渐清楚，精神逐渐恢复正常。此方补心、脾、胃三经，附子引药补心，消痰直入心中，气也易补，痰也易消。并服盐酸氯丙嗪 75~100 毫克，每日

三次。

五、痫 证

本证亦即“癫痫病”。

1. 主证：痫证是一类呈阵发性而短暂发作的疾病。发即突然仆地，嚼舌吐沫，背反张，目上视，四肢抽搐，吟声如畜，苔白，脉多滑。

2. 病因：痫证以风痰致疾。或由于饮食不节，脾失健运，聚湿生痰。加以惊、恐伤及肝、肾，肝气不调，肝风内动，肾气不固，虚风内动，触及积痰。风痰上逆，心神被蒙，神昏突发癫痫，口吐涎沫，风痰走窜筋脉，壅闭经络，而吟声如畜，四肢抽搐，目上视，背反张。风痰内蕴故苔白，脉滑。

3. 治则：豁痰开窍，熄风定痫。

4. 方药举例：

(1) 新病宜豁痰顺气，清火平肝。方用清心抑气汤，加羌活、防风、独活各 10 克。兼服苯妥英钠 0.1 克，每日三次，每次 1 片。另服磁朱丸 6~9 克，每日 1~2 次。蜂蜜 30 克，开水冲服，每日 1~2 次。

(2) 因寒而患痫证，感寒则发，方用党参 10 克，附子 3 克，肉桂 3 克，茯苓 15 克，山药 10 克，薏苡仁 15 克，白术 30 克，法半夏 10 克，水煎服。兼服苯妥英钠 0.1 克，每日三次，每次服一片。此证小儿得的多，由于内伤脾胃，外感风寒，痰结胸中，遇风寒即发。小儿服苯妥英钠 0.05 克，每日三次，一次服一片或服半片。

六、痫狂合并证

本病即为“癫痫精神障碍”，在患癫痫后又并发精神障碍，出现躁狂症状。

1. 主证：癫痫连发数次后，渐渐发狂，胡言乱语，打人骂人。有的癫痫频频发作数年后出现狂证，以后痫、狂交替出现，而成痫狂合并证。舌红，苔黄腻，脉多弦滑。

2. 病因：痫证多次发作，顽痰胶结，热痰上扰，蒙塞心窍，神乱狂闹。

3. 治则：痫狂证多虚夹实，宜清心豁痰，平肝定志。

4. 方药举例：以服蛮煎、清心抑气汤为主方，兼服苯妥英钠 0.1 克，每日三次，每次 1~2 片。

七、典型病例

1. 狂证：

〔病例〕

江××，男，28岁，工人。无明显发病诱因，失眠话多二月，入院前十日病情加剧，日夜不眠，连自己亲人也不能识别。打人骂人，砸机器，乱语乱跑，往水中跳。一九七四年六月二十五日入院。

诊断：患者语言紊乱，时而大声吼叫，怒目视人，大便已多日不解。由于病情躁动，无法细诊。面红目赤，舌绛苔黄垢，脉大滑。诊断为狂证（精神分裂症）。

方药：患者体质壮实，即以萝卜子（研末）60克，温凉开水调拌，诱其服尽，约2~3分钟后，吐出黄稠色痰涎及药末、水。吐后病势减轻，并口服氯丙嗪 200 毫克，使其安

静入睡。次日清晨又以大黄 60 克开水浸泡，取浓汁 200～300 毫升口服，大便即通畅，并服清心汤三剂，每日一剂，分三次服。方药为：黄连 12 克，防风 10 克，大黄、石膏、滑石各 30 克，荆芥 10 克，连翘 10 克，甘草 10 克，桔梗 10 克，川芎 10 克，当归 10 克，薄荷 6 克，白术 10 克，白芍 9 克，栀子 12 克，黄芩 15 克，生姜 3 片。同时每日早、中各服氯丙嗪 75 毫克，晚服 150 毫克。

患者由于上焦风痰从上涌出，胃与大肠实火从下泻出，加之氯丙嗪镇静，第五日病情已显著好转，并参加病房学习和工娱活动。其后中药照原方将药减量，其中大黄 12 克，石膏 20 克，滑石 20 克，加生地 20 克，继续服六剂，二天一剂，每日服二次。西药按原药量服。住院六天症状已控制，半月内症状消失，自知力恢复，经巩固治疗 20 余日，住院共三十八天，八月三日痊愈出院。

2. 癫狂证，

〔病例〕

孙××，男，20 岁，农民。一九七四年八月一日入院，七天前遭人殴打，心中怫郁不乐，以致精神异常，日夜不眠，语言夸大，内容紊乱，四处奔走，时轻时重，否认有病。

诊断：舌红，苔黄腻，脉弦数，诊断为癫狂证（精神分裂症）。

方药：入院后先以萝卜子取吐热痰，再以清心汤照前者量服三剂，兼服氯丙嗪 150 毫克，每日三次，服药后病情好转，住院七天就能正确认识自己疾病。后改服温胆汤加味四剂，即法半夏 12 克，陈皮 10 克，茯苓 10 克，甘草 3 克，竹茹 9 克，枳实 9 克，黄连 10 克，黄芩 12 克，石菖蒲 9 克，

梔子 9 克，生姜 3 片，大枣 2 枚。并兼服氯丙嗪，早、中午各服 75 毫克，晚服 150 毫克，于八月十五日痊愈出院。随访已五年半未复发。

3. 癡证:

〔病例〕

李××，女，21 岁，教师。一九七八年六月九日入院。因受人侮辱，反招人诬为作风不正。一月前开始沉默少语，渐至哑语，胆小害怕，终日哭泣。入院前十余日，突转乱语，见什么说什么，时又发呆不语。

诊断：入院后意识清楚，检查被动，情感淡漠，对医生问话置之不理，舌红，苔白腻，脉沉数。诊断为癡证（精神分裂症）。

方药：清心抑气汤。即：黄连 10 克，当归 9 克，白芍 9 克，川芎 9 克，党参 9 克，白术 10 克，茯苓 12 克，甘草 3 克，法半夏 10 克，麦冬 10 克，枳实 9 克，竹茹 9 克，石菖蒲 9 克，制香附 9 克，陈皮 9 克，生姜 3 片，合并氯丙嗪 225~300 毫克/日。治疗中出现口紧，吞咽困难，肢微颤等锥体外系副反应，加安坦 2 毫克，每日一次。经治疗四十五天，一九七八年七月二十四日痊愈出院。

4. 癡呆证:

〔病例 1〕

王××，女，47 岁，农民。一九七六年十一月八日入院，患精神病已六年，终日呆坐一处，时而自语发笑，生活不知料理。

诊断：舌淡苔薄，脉沉细无力。诊断为癡呆证（精神分裂症衰退型）。

方药：用逐呆仙丹(作汤剂)：菟丝子 15 克，党参 30 克，白术 20 克，茯神 20 克，法半夏 15 克，白芥子 10 克，白薇 6 克，附子 2 克，丹砂末 0.3 克(先将别药煎好后冲丹砂 0.1 克服)。服此方 15 剂后，又换服六味地黄汤加减：炮附子 3 克，熟地 15 克，山药 10 克，山茱萸 12 克，肉桂 3 克，菟丝子 10 克，当归 10 克，党参 30 克，石菖蒲 10 克，茯苓 6 克，泽泻 6 克，续服十余剂。在服中药的同时，合并服氯丙嗪 150 毫克/日，经治疗四十八天于一九七六年十二月二十六日痊愈出院。

〔病例 2〕

朱××，女，15 岁。二岁时因患痫证抽搐后，目瞪口呆，说话吐词不清，秽洁不知，终日糊糊涂涂，一九七八年六月一日来我院门诊治疗。

诊断：舌淡红，苔白腻，脉沉细弱，诊断为癫呆证。

方药：当服收呆至神汤。即：党参 30 克，柴胡 12 克，当归 12 克，白芍 18 克，法半夏 10 克，甘草 9 克，生枣仁 12 克，胆南星 6 克，制附子 1.5 克，石菖蒲 10 克，神曲 6 克，茯苓 30 克，郁金 6 克。水二碗，煎一碗服。并兼服氯丙嗪 12.5 克，每日三次，同时服蜂蜜 30 克。

服药治疗一月后，神志逐渐清楚，言语逐渐恢复正常。

5. 痫证：

〔病例 1〕

陈××，男，32 岁，工人。因患痫证，感寒则发，数年未愈。每发仆地，手足搐搦，作牛羊之声，口吐涎沫，开始一月一发，数日一发，有时一日发数次，在各地医治无效，于一九七八年来我院治疗。

诊断：住院后，脉沉迟，舌淡，苔白腻。诊断为痫证。

方药：因寒而致，当服党参30克，白术30克，茯苓15克，山药12克，薏苡仁12克，肉桂3克，制附子3克，法半夏10克。水煎服。并每日兼服苯妥英钠0.1克，每日三次，每次服一片。另外，每日用开水冲服蜂蜜30克。经治疗后，迄今未发。

〔病例3〕

汪××，男，6岁。从小患痫证，医治无效，于一九七七年五月十二日来我院门诊治疗，突然倒地，手足搐搦，口流涎沫，作猪羊之声，少时苏醒，一如常人。据其父说，一至二天发一次，有时一天发数次。

诊断：来诊时面黄消瘦，脉细弱，舌质红，无苔，因内伤脾胃，外感风寒，痰结在胸膈之中，一遇风寒便发癫痫。患者遇风寒便风痰上涌，而引起癫痫复发，治宜补气血，健脾胃，平肝解郁，清火化痰。

方药：清心抑气汤加防风6克，羌活3克，独活3克，法半夏6克，白芍6克，当归9克，川芎6克，党参12克，白术9克，茯苓10克，甘草6克，麦冬6克，麸炒枳实6克，竹茹6克，陈皮9克，生姜3片，水煎服。并兼服苯妥英钠0.05克，每日三次，每次服0.05克，迄今未发，于一九七八年十一月一日又来我院复诊，身体肥胖，饮食正常，症状完全消失。

第九章 精神病的家庭简便治疗法

精神病也是一种常见的疾病，当患有这类疾病后，患者家属和所在单位，以及患者本人，要求及时住院治疗。但医院床位有限，往往不能满足患者都能及时住院治疗的要求。如果能有效地开展家庭治疗，每个患者的家属或单位都能掌握一些诊疗这类疾病的知识，这不但有利于防病治病，及时地给患者施行治疗，而且可以节省费用开支和路途往返。

如何开展家庭治疗？一般可用以下方法进行。

1. 对于狂证、癲狂证：躁扰不宁，面红目赤，大便秘结，先以大黄 30~50 克，用开水泡服。次以清心汤煎服，方中重用大黄、石膏、滑石。如系青少年患者，兴奋躁动，追逐异性，语言有青春色彩，舌紫或舌有青纹，为气滞血淤，方中可加去皮尖桃仁 10 克，红花 3 克，生地 15 克，以达活血化淤的效果。在服中药的同时，可配服盐酸氯丙嗪，每日 200~300 毫克，分三次口服。这样，常可提高疗效。若能将白天的剂量略微减少，晚上睡前的一次剂量适当加大，则不仅使镇静安眠的效果更好，且可减少药物反应的发生。

2. 对于癲证和癲呆证：可口服清心抑气汤、化狂丹。如病久不愈者，可服滋阴汤。亦可配服氯丙嗪，每日 200~300 毫克，分三次口服。

3. 对于痫证：可用清心抑气汤，加独活 10 克，羌活 10 克，防风 10 克，水煎服。同时，配服磁朱丸，每次 10 克，

每日一次。亦可配服蜂蜜，每次 30 克。每日一次，开水冲服。西药可用苯妥英钠，每次 0.1 克，每日三次，口服。

4. 对于狂病合并证：可按狂证、癫狂证的法则治疗。西药的运用，可参考上述方法，配服苯妥英钠和氯丙嗪。当狂躁症状缓解后，中药可改用清心温胆汤，加独活 10 克，防风 10 克，羌活 10 克。另外，兼服三黄汤，即：大黄 12 克，黄连 10 克，黄芩 12 克，水煎服。氯丙嗪则可根据病情好转的程度，逐渐减量。

在家庭治疗中，由于身旁没有医护人员，观察病情的责任，就自然落到病人亲属的身上，因此，作为患者的亲属，必须掌握一些必要的医药护理知识，便于观察患者的病情变化，作些必要的处理。如服氯丙嗪后，可出现口紧流涎，身颤扭体，坐立不安，翻目上视等药物反应。此时，可给服安坦，每次一片（2 毫克），每日三次，多可使症状缓解。亦可根据病情，适当减药或停药。

〔病例 1〕

郑××，男，18 岁。在家受责骂，精神抑郁，逐渐睡卧不宁，言语错乱，有时唱歌，有时狂笑。

诊断：面色红赤，大便干结，舌红苔黄，脉象滑数，此属癫狂证。乃内伤七情，复受外感，痰热交蒸，清窍被阻。治宜疏风清热，兼解痰郁。

方药：法半夏 10 克，陈皮 10 克，茯苓 10 克，防风 10 克，大黄 10 克，荆芥 10 克，栀子 10 克，白芍 12 克，连翘 10 克，甘草 10 克，桔梗 10 克，川芎 10 克，当归 12 克，石膏 24 克，滑石 21 克，薄荷 10 克，黄芩 10 克，白术 10 克，黄连 9 克，生姜 10 克。

水煎，每日早晚服，兼服盐酸氯丙嗪(每片含 25 毫克)，每日三次，每次服 3 片。并服蜂蜜，每日 30 克，开水冲服。服至三十天，精神恢复正常，参加劳动生产。

〔病例 2〕

周××，男，27 岁，先失眠，头晕，后渐神志不清，目赤易怒，骂詈叫号，躁扰狂越。

诊断：大便秘结，小便赤涩，此乃肝胆实火为患的狂证。

方药：服三黄汤，即：大黄 30 克，黄连 9 克，黄芩 15 克，水煎服。兼服盐酸氯丙嗪(每片 25 毫克)，每日三次，每次服四片。

另服蜂蜜，每日用 30 克，开水冲服，服至五天神志清楚，言语正常。

改服化狂丹：党参 30 克，白术 30 克，茯神 30 克，法半夏 10 克，石菖蒲 10 克，菟丝子 12 克，甘草 10 克，制大附子 1.5 克，水煎服。服至三剂，精神恢复正常。

病愈，未有休息，就参加生产。

〔病例 3〕

田××，女，48 岁。因在工作中受了批评，思想不通，因而精神抑郁，表情淡漠，逐渐语无伦次，时悲时喜，饮食少进，有时痴笑。

诊断：身体一般，大小便如常，舌苔白腻，脉象弦滑，诊断为癫证。此为七情所伤，肝气抑郁，宜化痰开窍，服清心抑气汤。

方药：法半夏 10 克，白芍 12 克，当归 12 克，党参 21 克，白术 10 克，茯苓 12 克，石菖蒲 10 克，远志 10 克，制

香附 10 克，黄连 9 克，陈皮 10 克，生姜 10 克。

水煎，每日早晚温服，兼服盐酸氯丙嗪（一片 25 毫克），每日三次，一次服 3 片。另服蜂蜜，每日 30 克，开水冲服，连服两月，神志清楚，言语正常，上班工作。

〔病例 4〕

陈××，女，17 岁。患癫证两年，渐转痴呆，神志恍惚，唧唧咕咕，秽洁不知，目瞪口呆。

诊断：舌质淡润无苔，脉沉细，此系气血虚，心失所养，以致神志糊惑，治宜养血安神，宁心定智。

方药：用养心汤，即：炙黄芪 12 克，炙甘草 12 克，当归 12 克，茯神 12 克，川芎 10 克，当归 12 克，柏子仁 6 克，法半夏 12 克，远志 10 克，肉桂 6 克，炒酸枣仁 12 克，五味子 9 克，生姜 10 克，红枣 3 枚。

水煎温服，兼服盐酸氯丙嗪（每片 25 毫克），每日三次，每次服 3 片。服至三个月，神志逐渐清楚，言语逐渐正常，病愈在家，搞轻微体力劳动，

〔病例 5〕

邓××，女，30 岁。正值月经期间，触事生怒，突然神志失常，狂言乱语，骂人摔物，少卧不饥。

诊断：舌苔黄腻，脉衰弦滑，此系肝郁痰火所致的癫证。治宜清热解郁，即予参术散（即化狂丹）。

方药：党参 30 克，白术 30 克，茯神 30 克，法半夏 10 克，陈皮 10 克，石菖蒲 10 克，菟丝子 15 克，制附子 1.5 克。

水煎服。另用大黄 15 克，黄连 9 克，黄芩 15 克，泡开水喝。兼服盐酸氯丙嗪（每片 25 毫克），每日三次，每次服 4 片。在家服一月，病愈，参加农业生产。

附录

方剂索引

二 划

二阴煎.....82	八珍汤.....100
七福饮.....104	十全大补汤.....101
八味丸.....93	十味温胆汤.....75

三 划

三圣散.....86	大承气汤.....96
三黄汤.....88	大和中饮.....103
上池饮.....87	万氏牛黄丸.....85
大补元煎.....93	万氏牛黄清心丸.....85

四 划

天王补心丹.....91	化痰丸.....102
天王补心丹合六味地黄丸79	五痢丸.....98
天麻散.....102	牛黄清心丸.....85
化狂丹.....81	六君子汤.....92
	六安煎.....103

六味地黄汤.....93
风引汤.....99

丹桅逍遥散.....88

五 划

四气汤.....83
瓜蒂散.....80
白金丸.....87
白虎汤.....101
加味温胆汤.....75
加味逍遥散.....88
加味香砂六君子汤.....102
加味六味地黄汤.....93
龙胆泻肝汤.....95

半夏白术天麻汤.....106
生铁落饮.....91
宁志膏.....91
宁志化痰汤.....104
宁痢散.....97
归脾汤.....93
龙牡汤.....107
龙齿丹.....98
甘麦大枣汤.....107

六 划

当归芦荟丸.....96
当归承气汤.....96
回癫汤.....105
收呆至神汤.....106

血府逐瘀汤.....89
朱砂安神丸.....92
朱砂白金丸.....108

七 划

防风通圣散.....83
防风黄连汤.....104
防眩汤.....107
驱风化痰汤.....77

苏合香丸.....84
辰砂散.....90
医痢无双丸.....101

八 划

泻心汤·····	81	河车丸·····	106
定志丸·····	90	抽薪饮·····	94
定神至宝丹·····	100	抱龙丸·····	97
定痢丸·····	99	参麦地黄汤·····	107
服蛭煎·····	82	肾气丸·····	93

九 划

养心汤·····	79	洗心汤·····	104
养血清心汤·····	91	泻心汤·····	88
追风祛痰丸·····	99	香砂六君子丸·····	108

十 划

凌霄花散·····	98	桃仁四物汤·····	89
涤痰汤·····	96	莱服子散·····	80
将军汤·····	81	祛癩汤·····	100
逍遥散·····	89	党术散·····	81
逐呆丹·····	102		

十一 划

清心汤·····	75	清上蠲痛饮·····	106
清心温胆汤·····	77	清晕化痰汤·····	107
清心养血汤·····	104	清膈煎·····	105
清心滚痰丸·····	85	凉膈散·····	95
清心抑气汤·····	77	控涎丹·····	86

排气饮	105	黄连解毒汤	95
黄芪赤风汤	100	续命风引汤	105

十二划

温胆汤	74	琥珀养心丹	92
温白丸	84	补心丹	103
滋阴汤	78	补中益气汤	100
遂心丹	87		

十三划

紫河车丸	83
------------	----

十四划

磁朱丸	94
-----------	----

十五划

醋烟薰法	97
------------	----

十八划

礞石滚痰丸	85
-------------	----

二十一划

癫狂梦醒汤	89
-------------	----